

Kansallinen syöpästrategia 2026–2035

Toimeenpanon tiekartta vuosille 2026–2031

Kansallisen syöpästrategian toimeenpanon käynnistämisen ohjausryhmä

Tiivistelmä

Kansallinen syöpästrategia 2026–2035: **Toimeenpanon tiekartta vuosille 2026–2031**

Kansallisen syöpästrategian toimeenpanon tiekartta ohjaa strategian vaiheittaista toteutusta ensimmäisellä viisivuotiskaudella 2026–2031. Tavoitteena on kehittää ihmislähtöisiä palveluita, vähentää syöpätaakkaa ehkäisyn ja varhaisen toteamisen avulla sekä varmistaa vaikuttava ja yhdenvertainen hoito. Vaikka syövän hoito on Suomessa korkeatasoista, kasvava syöpätaakka ja strategiassa esitetty tavoite olla hoitotuloksissa pohjoismaisella tasolla edellyttävät merkittäviä uudistuksia. Diagnostiikan ja hoidon yksilöllistyminen luovat uusia mahdollisuuksia, mutta lisäävät myös tarvetta vahvistaa tietopohjaa ja parantaa syövän ennaltaehkäisyn, hoidon ja tutkimuksen vaikuttavuutta.

Tiekartassa kuvataan toimenpiteet, niiden aikataulut, vastuutoimijat sekä resurssitarpeet. Tiekartan tavoitteena on varmistaa strategian käytännön toteutus sekä selkeyttää eri hallinnonalojen, viranomaisten, hyvinvointialueiden ja järjestöjen roolit. Onnistuminen edellyttää laajaa kansallista sitoutumista ja aktiivisia politiikkatoimia.

Osa toimenpiteistä on jo käynnissä osana laajempia kansallisia hankkeita, mutta useiden toimenpiteiden osalta toimeenpano edellyttää lisäresursseja ja säädösmuutoksia. Syöpästrategian toimeenpano vaatii kokonaisuudessaan arviolta 140 miljoonan euron lisäinvestoinnit, joiden odotetaan tuottavan merkittäviä säästöjä ja kasvua ennaltaehkäistyjen syöpätapausten, varhaisemman toteamisen ja lisääntyneen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan kautta.

Toimeenpanon toteutusta varten asetetaan seurantaryhmä, joka koordinoi, linjaa ja seuraa strategian toteutumista. Tiekarttaa päivitetään toimeenpanon aikana toimintaympäristön muutokset huomioiden, ja laajempi arvio sekä tiekartta toiselle viisivuotiskaudelle tehdään vuonna 2030.

Referat

Den nationella cancerstrategin 2026–2035: **Färdplan för genomförandet 2026–2031**

Färdplanen för genomförandet av den nationella cancerstrategin styr ett stegvis genomförande av strategin under den första femårsperioden 2026–2031. Syftet med den nationella cancerstrategin är att utveckla tjänster som sätter människan i centrum, minska cancerbördan genom förebyggande och tidigare konstaterande samt att säkerställa en jämlik och effektiv cancervård. Trots att cancervården i Finland håller en hög nivå, kräver den växande cancerbördan och det mål som förts fram i strategin att behandlingsresultaten ska vara på nordisk nivå betydande reformer. Diagnostik och individanpassad vård skapar nya möjligheter, men ökar också behovet att stärka kunskapsunderlaget och förbättra effektiviteten inom förebyggande och behandling av cancer samt cancerforskningen.

I färdplanen beskrivs åtgärder, tidtabeller för dem, ansvariga aktörer och resursbehov. Målet med färdplanen är att säkerställa genomförandet av strategin i praktiken och förtydliga rollerna för de olika förvaltningsområdena, myndigheterna, välfärdsområdena och organisationerna. För att lyckas krävs ett omfattande nationellt engagemang och aktiva politiska åtgärder.

En del av åtgärderna pågår redan som en del av större nationella projekt, men för flera åtgärder kräver genomförandet tilläggsresurser och författningsändringar. Genomförandet av cancerstrategin beräknas i sin helhet kräva 140 miljoner euro i tilläggsinvesteringar som förväntas ge betydande besparingar och tillväxt genom förebyggda cancerfall, tidigare konstaterande samt ökad forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet.

En uppföljningsgrupp tillsätts för genomförandet och den samordnar, ger riktlinjer för och följer upp genomförandet av strategin. Färdplanen revideras under genomförandet med beaktande av förändringar i verksamhetsmiljön. En mera omfattande bedömning och färdplan för den andra femårsperioden görs 2030.

Abstract

Finland's National Cancer Strategy 2026–2035: **Roadmap for implementation for 2026–2031**

The roadmap for the implementation of the National Cancer Strategy guides the gradual implementation of the strategy during its first five-year period (2026–2031). The aim is to develop human-centred services, reduce the cancer burden through prevention and early detection, and ensure effective and equal treatment. Although cancer treatment is of a high standard in Finland, the growing cancer burden and the goal set in the strategy for Finland to be at the same level in treatment results as other Nordic countries will require significant reforms. The individualisation of diagnostics and treatment creates new opportunities, but these also increase the need to strengthen the knowledge base and improve the effectiveness of cancer prevention, treatment, and research.

The roadmap describes measures, their schedules, responsible actors, and resource needs. The objective of the roadmap is to ensure the practical implementation of the strategy and to clarify the roles of different administrative branches, authorities, wellbeing services counties, and organisations. Success will require extensive national commitment and active policy measures.

Some of the measures are already under way as part of more wide-ranging national projects, but the implementation of many measures will require additional resources and legislative amendments. The implementation of Finland's National Cancer Strategy as a whole will require an estimated EUR 140 million in additional investments, which are expected to generate significant savings and growth through prevented cancer cases, earlier detection and increased research, development, and innovation activities.

A monitoring group will be set up to coordinate, outline, and monitor the implementation of the strategy. The roadmap will be updated during the implementation, taking into account changes taking place in the operating environment, and a more extensive assessment and a roadmap for the second five-year period will be drafted in 2030.

Sisällys

Johdanto ... 7

Yhdenvertaisuuden näkökulmat syöpästrategian toimeenpanossa ... 9
- Sosioekonomiset tekijät ... 9
- Alueellinen eriarvoisuus ... 12
- Ikääntyneet ... 14
- Lasten ja nuorten syövät ... 16
- Harvinaiset syövät ja perinnölliset syöpäalttiusoireyhtymät ... 18
  - Harvinaiset syövät ... 18
  - Perinnölliset syöpäalttiusoireyhtymät ... 20
- Huonon ennusteen syövät ... 22

Toimenpiteet tiekartalla ... 26
- 1. Vahvistetaan osallisuutta ja kehitetään ihmislähtöisiä palveluja ... 26
  - 1.1 Asiakkaat, potilaat ja läheiset osallistuvat syövän ehkäisyn, hoidon ja palveluiden kehittämiseen ... 26
  - 1.2 Arvostava, inhimillinen ja yksilöllinen kohtaaminen tukee potilasta osallistumaan aktiivisesti omaan hoitoonsa ... 30
  - 1.3 Selkeä ja saavutettava terveysviestintä sekä terveyslukutaidon tukeminen edistävät syövän ehkäisyä, varhaista toteamista ja hoidon vaikuttavuutta ... 33
- 2. Vähennetään syöpätaakkaa ehkäisyn ja varhaisen toteamisen avulla ... 35
  - 2.1 Syövän riskitekijöitä vähennetään ja suojaavia tekijöitä vahvistetaan yhteiskuntapoliittisin keinoin ... 35
  - 2.2 Syöpää ehkäistään hyvinvointialueilla ja lähipalveluissa ... 42
  - 2.3 Eurooppalaiset suositukset ja kansalliset rakenteet ovat perustana vaikuttavien syöpäseulontaohjelmien suunnittelulle ja toteutukselle ... 44
  - 2.4 Lainsäädäntö ja rekisteritieto mahdollistavat laadukkaan, kustannusvaikuttavan ja riskiperusteisen seulonnan ... 47
  - 2.5 Syövät havaitaan aiempaa varhaisemmassa vaiheessa kaikkialla terveydenhuollossa ... 51
- 3. Varmistetaan yhdenvertainen ja vaikuttava syövänhoito ... 54
  - 3.1 Kansalliset hoitosuositukset ja hoitoketjut ohjaavat yhdenvertaista, viiveetöntä ja vaikuttavaa hoitoa ... 54
  - 3.2 Kansallisen syövänhoidon laaturekisteri, systemaattinen tulosten tarkastelu ja vertaisarviointi tukevat vaikuttavan hoidon kehittämistä ... 59
  - 3.3 Kuntoutus, psykososiaalinen tuki, terveyssosiaalityö ja palliatiivinen hoito ovat vakiintunut osa syöpäpotilaan hoitoketjua ja yhdenvertaisesti saatavilla ... 63
  - 3.4 Toimintakykytieto ohjaa ikääntyneiden syöpäpotilaiden diagnostiikkaa ja hoitoa ... 68
  - 3.5 Riittävä ja osaava henkilöstö varmistaa vaikuttavan ja ihmislähtöisen syövän hoidon ... 70
- 4. Aallonharjalla muuttuvassa toimintaympäristössä ... 77
  - 4.1 Kansallinen terveyden tietovaranto ja kehittynyt analytiikka tukevat syövän tutkimusta ja tiedon hyödyntämistä ... 77
  - 4.2 Vahvistuva kliininen syöpätutkimus on tiivis osa jokaisen potilaan hoitoa ... 81
  - 4.3 Suomi on yksilöllisen lääketieteen edelläkävijä ... 85

4.4 Vähennetään syöpätaakkaa monitieteisen tutkimuksen avulla 90
4.5 Uusien syöpälääkkeiden ja muiden hoitomenetelmien arviointi ja käyttöönotto on vaikuttavaa, viiveetöntä ja yhtenevää arviointitahosta riippumatta 93
Toimeenpano ja seuranta 101
Kustannukset ja ennakoidut säästöt 102
Liite 1. Syöpästrategian toimeenpanon arvioidut kustannukset 2026-2031 päätavoite-, osatavoite- ja toimenpidekohtaisesti 104
Liite 2. Ohjausryhmän ja sihteeristön kokoonpano 110

Johdanto

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) julkaisi marraskuussa 2025 Suomen ensimmäisen kansallisen syöpästrategian vuosille 2026–2035[1] vastaamaan kasvavan syöpätaakan ja muuttuvan toimintaympäristön haasteisiin. Strategian tavoitteena on kehittää ihmislähtöisiä palveluita, vähentää syöpätaakkaa ehkäisyn ja varhaisen toteamisen kautta sekä varmistaa yhdenvertainen, viiveetön ja vaikuttava syövän diagnostiikka, hoito ja kuntoutus koko maassa. Strategia korostaa myös tutkimuksen, uusien menetelmien ja tiedolla johtamisen merkitystä syövän ehkäisyn ja hoidon kehittämisessä.

Strategia viitoittaa pitkän aikavälin toimia ja esittää keskeiset painopisteet syövän ehkäisyn, hoidon ja syöpätutkimuksen kehittämiseksi vuoteen 2035 saakka. Strategia muodostuu neljästä strategisesta päätavoitteesta (kuva 1), niiden alle täsmennetyistä osatavoitteista sekä näiden toteutumista tukevista toimenpide-ehdotuksista. Strategian läpileikkaavana teemana on yhdenvertaisuus.

Tässä kansallisen syöpästrategian toimeenpanon tiekartassa kuvataan strategian toteuttamisen ensimmäiset konkreettiset vaiheet vuosille 2026–2031. Tiekartta tarkentaa strategiassa esitetyt toimenpide-ehdotukset kuvaamalla niiden käytännön toteutuksen, vastuut, tarvittavat resurssit sekä aikataulun ensimmäiselle viiden vuoden jaksolle. Tiekartan tavoitteena on mahdollistaa strategian suunnitelmallinen ja vaiheittainen toteuttaminen sekä tukea ohjausta ja seurantaa. Tiekarttaa päivitetään toimeenpanon edetessä, ja strategian puolivälissä on tarkoituksena toteuttaa laajempi arviointi, jonka pohjalta määritetään tiekartta strategiakauden toiselle puoliskolle.



Kuva 1.

1 Sosiaali- ja terveysministeriö. Kansallinen syöpästrategia 2026-2035: Yhdessä syöpää vastaan – Ihmislähtöistä syövän ehkäisyä ja hoitoa.

Tiekartan pohjana on syöpästrategiatyön työryhmien tuottama laaja materiaali, jota sihteeristö (liite 2) on päivittänyt ja tarkentanut yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa. Työryhmissä oli mukana yli 200 asiantuntijaa terveydenhuollosta, tutkimus- ja koulutusorganisaatioista sekä järjestöistä. Työryhmät ja niihin osallistuneet asiantuntijat on kuvattu kansallisen syöpästrategian liitteessä 1.

Tiekarttaan pyydettiin kommentteja vastuutahoilta keväällä 2026. Tiekartan viimeistelyvaiheessa tunnistettiin tarve tarkentaa vastuukuvauksia ja ohjausmekanismeja. Nämä huomioidaan toimeenpanovaiheessa osana seurantaryhmän ja vastuutahojen toimintaa. Toimenpiteiden vastuutahojen kesken sovitaan toteutuksen tarkempi työnjako.

Tiekarttaa on valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta kansallisen syöpäkeskuksen FICANin koordinoimana. Tiekarttatyötä on ohjannut sosiaali- ja terveysministeriön asettama kansallisen syöpästrategian toimeenpanon käynnistämisen ohjausryhmä, jossa ovat olleet edustettuina STM, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), FICAN ja Syöpäjärjestöt (liite 2).

Yhdenvertaisuuden näkökulmat syöpästrategian toimeenpanossa

Suomalaisessa terveydenhuoltojärjestelmässä keskeisenä tavoitteena on tarjota kansalaisille yhdenvertainen mahdollisuus ennaltaehkäiseviin palveluihin sekä oikea-aikaiseen ja laadukkaaseen hoitoon.

Pitkäaikaistutkimukset osoittavat kuitenkin, että syöpään sairastumisen riski ja syöpäkuolleisuus vaihtelevat eri väestöryhmien välillä. Sosioekonomiset tekijät vaikuttavat sekä syövän ilmaantuvuuteen, hoitotuloksiin että suhteelliseen elossaoloaikaan, ja näissä tekijöissä on myös suurta alueellista vaihtelua.

Syöpään sairastuminen vaikuttaa ihmisen arkeen ja elämään monin tavoin. Sairaus ja sen hoidot voivat heikentää työ- ja toimintakykyä, elämänlaatua, työssä selviytymistä ja toimeentuloa. Lisäksi hoitojen myöhäisvaikutukset voivat ilmetä vasta vuosien kuluttua ja kuntoutuminen saattaa olla pitkä prosessi. Kokemukset hoitoon pääsystä ja terveydenhuollon toimivuudesta vaihtelevat huomattavasti sekä väestöryhmien välillä että eri syöpäsairauksia sairastavien kesken. Yhdenvertaisuuden turvaaminen on tärkeää myös syövän sairastaneiden ja muun väestön välillä esimerkiksi työelämässä ja rahoituspalveluiden hakemisessa.

Yhdenvertaisuus on perusoikeus, joka on kirjattu Suomen perustuslakiin. Muodollinen yhdenvertaisuus tarkoittaa sitä, että kaikkia kohdellaan samalla tavalla ja heille tarjotaan samat palvelut. Se ei kuitenkaan yksin riitä takaamaan todellista yhdenvertaisuutta. Tosiasiallinen syöpään sairastuneiden yhdenvertaisuus vaatii yksilöllisten elämäntilanteiden kokonaisvaltaista ja oikeudenmukaista huomioimista, riittävää tietoa tarjolla olevista tukipalveluista sekä sujuvaa moniammatillista yhteistyötä. Vasta silloin jokaisella on todellinen mahdollisuus saavuttaa paras mahdollinen hoidon lopputulos.

Ei kaikille kaikkea, vaan jokaiselle yksilöllisen tarpeensa mukaan.

Sosioekonomiset tekijät

Suomalaiset pitkäaikaistutkimukset[2] ovat osoittaneet, että riski sairastua syöpään ja syöpäkuolleisuus vaihtelevat eri väestöryhmissä sosioekonomisia taustamuuttujia arvioitaessa. Lisäksi yksilöiden väliset erot terveydenlukutaidossa, tiedon hankinnassa ja tulkinnassa vaikuttavat hoitoon ja lääkehoitoon sitoutumiseen.

Nämä eroavuudet on osoitettu muun muassa keuhko-, kolorektaali-, rinta- ja eturauhassyövässä. Kansainvälisissä tutkimuksissa veri- ja imusolmukesyöpiä

2 X. Zai, ym. Disparities in cancer incidence, stage at diagnosis, treatment and mortality across socioeconomic groups in Finland: a register-based population study. *BMJ Public Health*. 2025;3:e002829.

tarkastellessa potilaan matala sosioekonominen asema on yhteydessä huonompaan ennusteeseen useissa eri syöpätyypeissä, kuten multippelissa myeloomassa, akuutissa leukemiassa ja non-Hodgkin lymfoomassa. Erot selviytymisessä on huomattu myös lasten kohdalla suomalaisessa tutkimuksessa, jossa muuttujina olivat vanhempien tulotaso, koulutus ja syntyperä[3].

Sosioekonominen asema on yläkäsite, jota ei voida tutkimuksissa mitata suoraan yksittäisellä muuttujalla. THL:n mukaan sosioekonomisella asemalla kuvataan kaikkia yksilön aineellisten voimavarojen ja niiden hankkimiseen vaadittujen edellytysten muodostamaa kokonaisuutta. Näitä aineellisia voimavaroja ovat tulot, omaisuus ja asumistaso. Niiden hankkimisen edellytyksiä ovat puolestaan koulutus, ammatti ja asema työelämässä.

Alhaisen sosioekonomisen aseman potilailla heikompiin lopputuloksiin liittyy monia mahdollisia mekanismeja, ja erot johtuvat todennäköisesti useiden tekijöiden yhdistelmästä.

Vähän koulutetut, pienituloiset ja työntekijäammateissa toimivat sairastavat enemmän, heidän toimintakykynsä on useammin heikentynyt ja he kuolevat nuorempina kuin korkeasti koulutetut, hyvätuloiset ja ylemmät toimihenkilöt. Matalan sosioekonomisen aseman ja heikomman syöpäselviytymisen taustatekijöinä pidetään epäilyä diagnostiikan viivästymisestä, heikentynyttä hoitoonpääsyä, hoidon heikompaa intensiteettiä ja vähäisempää osallistumista syöpäseulontoihin. Muita tekijöitä ovat sosioekonomiseen asemaan liittyvät elintapaerot tupakoinnissa, alkoholinkäytössä ja ylipainossa, jotka kaikki sinällään ovat riskitekijöitä usean perussairauden suhteen.

Muita tunnistettuja terveydenhuollon palvelujärjestelmään yhdistettyjä eriarvoisuutta lisääviä tekijöitä ovat palvelujen hinta, erot potilaiden terveyslukutaidossa, palvelujen haastava sijainti ja vaikeus saavuttaa palveluita. Pienituloisille ja lähes tulottomille ihmisille nykyiset asiakasmaksut sekä lääke- ja matkakulut voivat olla liian korkeita, mikä voi viivästyttää terveyspalveluihin hakeutumisesta tai johtaa siihen, että potilas säästää lääkekuluissa jättämällä osan lääkkeistä ottamatta. Myös julkiseen hammashoitoon pääsyssä voi olla haasteita. Työterveyshuollon palvelut ovat käyttöhetkellä ilmaisia, kun taas julkisessa terveydenhuollossa potilaat maksavat asiakasmaksuja valtaosasta palveluja.

Korkeammin koulutetuilla ihmisillä on yleensä paremmat tiedot saatavilla olevista palveluista ja oikeuksistaan käyttää niitä, mikä heijastuu myös valmiuteen käyttää digitaalisia palveluja. Hoitoon hakeutumisen on todettu pitkittyvän, mikäli palvelut sijaitsevat kaukana tai ovat vaikeasti saavutettavissa. Terveystarkastusten ja ennaltaehkäisevien palvelujen (esim. rokotusten, ikätarkastusten ja syöpäseulontojen) väliin jättäminen vaikuttaa syövän toteamiseen ja hoitotuloksiin. Lisäksi heikommassa sosioekonomisessa asemassa olevat voivat kohdata haasteita palvelujen käytössä, eikä avun saamiseen välttämättä luoteta. Terveydenhuollon ammattilaisten negatiiviset asenteet saattavat vaikeuttaa tilannetta edelleen.

3 A. Kyrönlahti. 2024. Socioeconomic aspects within childhood cancer. Akateeminen väitöskirja, Helsingin yliopisto.

Myös maahanmuuttajien osuuden kasvu väestössä vaikuttaa syöpäsairastavuuteen. Suomen väestörakenne on muuttunut merkittävästi viimeisten 30 vuoden aikana ja on edelleen muutoksessa. Vuoden 2023 lopussa vajaat seitsemän prosenttia koko väestöstä oli syntynyt muualla kuin Suomessa. Uudellamaalla joka kymmenes on syntynyt Suomen ulkopuolella. Työikäisestä (20–64 v.) väestöstä maahanmuuttajien osuus oli koko maassa 13,3 % ja Uudellamaalla jo 21,6 %.

Maahanmuuttajaväestön ikääntyessä myös syövän esiintyvyys tässä väestöryhmässä kasvaa. Muualta saapuneet voivat sairastua eri syöpiin kuin kantaväestö. Yleisimmät epäterveellisiin elintapoihin yhdistetyt syöpätyypit, eli rinta- ja suolistosyövän kaltaiset ns. elintasosyövät, ovat harvinaisempia maahanmuuttajien keskuudessa. Toisaalta taas infektioperäiset – meillä eri syistä harvinaistuneet – syövät, kuten kohdunkaulansyövät, voivat olla maahanmuuttajien keskuudessa yleisempiä ja johtaa useammin kuolemaan. Voidaan ennakoida, että väestömuutos tulee näkymään myös muutoksina tautitaakassa.

Maahan muuttaneiden osallistuminen syöpäseulontoihin on alhaisempaa kuin Suomessa syntyneiden. Osallistumattomuudelle on useita syitä. Samalla on syytä muistaa, etteivät maahanmuuttajat tai vieraskieliset muodosta selkeää ja yhtenäistä ryhmää: eri ryhmien välillä ja sisälläkin esiintyy suuria eroja.

Sosioekonomisiin eroihin vaikuttaa osaltaan suomalainen terveydenhuoltojärjestelmä, jossa perusterveydenhuolto rakentuu kolmen rinnakkaisen toimijan varaan: hyvinvointialueiden hallinnoimat julkiset terveyskeskukset, yksityiset terveysasemat ja työterveyshuolto. Vaikka kaikkia rahoitetaan eriasteisesti julkisin varoin, on nykytilanne se, että viimeksi mainittujen resursointi on erinomaista ja hoitoonpääsy nopeaa, kun taas ensin mainittu on vahvasti aliresursoitu ja hoitoonpääsyssä haasteita. Vielä julkaisemattomassa lymfoomapotilaiden hoitoonpääsyä käsittelevässä tutkimuksessa havaittiin, että diagnoosin saamiseen kuluu yksityisen puolen toimijoihin verrattuna kaksinkertainen aika, jos potilas hakeutuu oireineen julkiseen terveydenhuoltoon.

Kun vielä huomioidaan, että kattavinta työterveyshuoltoa saavat muutenkin hyvässä asemassa olevat, terveyden sosioekonomiset erot kärjistyvät entisestään. Ongelma koskee diagnostiikan lisäksi myös syöpien ennaltaehkäisyä ja hoitojen jälkeistä kuntoutusta.

Hyvinvointia ja terveyttä tulee edistää kunnissa, hyvinvointialueilla ja järjestöissä niin väestötasolla kuin eri ryhmille kohdennetustikin, ja viestiä kannattaa viedä eteenpäin yhteistyössä eri tahojen kanssa. Luottamuksen rakentaminen ja tietoisuuden kasvattaminen edellyttävät aikaa ja resursseja, ja tuloksia nähdään vasta vuosien päästä.

Eri vähemmistöryhmiä ei ole syytä mieltää erityistä palvelua ja siten resursseja edellyttävänä joukkona. Palvelemme kaikkia paremmin, kun otamme vähemmistöryhmät huomioon. Viestinnässä kannattaa lisätä selkosuomen käyttöä. Kaikki, mikä auttaa tavoittamaan mahdollisimman monia vähemmistöryhmiä, on eduksi muillekin.

Sosioekonomisiin tekijöihin liittyvät osatavoitteet ja toimenpiteet:

Tavoitteena on, että sosioekonomisten tekijöiden vaikutus syövän ennaltaehkäisyyn, diagnoosin saamiseen, hoitoonpääsyyn, hoitotuloksiin ja kuntoutumiseen vähenee. Tavoitteen toteutumista tukevat strategian seuraavat osatavoitteet: *1.2 Arvostava, inhimillinen ja yksilöllinen kohtaaminen tukee potilasta osallistumaan omaan hoitoonsa; 1.3 Selkeä ja saavutettava terveysviestintä sekä terveyslukutaidon tukeminen edistävät syövän ehkäisyä, varhaista toteamista ja hoidon vaikuttavuutta; 2.1 Syövän riskitekijöitä vähennetään ja suojaavia tekijöitä vahvistetaan yhteiskuntapoliittisin keinoin; 3.1 Kansalliset hoitosuositukset ja hoitoketjut ohjaavat yhdenvertaista, viiveetöntä ja vaikuttavaa hoitoa* ja *4.4 Vähennetään syöpätaakkaa monitieteisen tutkimuksen avulla*.

Alueellinen eriarvoisuus

Syövän hoitotulokset mittaavat koko terveydenhuoltojärjestelmän tehokkuutta: syövän ennaltaehkäisyä, seulontojen ja perusterveydenhuollon saatavuutta, viiveetöntä diagnostiikkaa ja erikoissairaanhoidon erikoisaloja yhdistävää hoitoketjua. Tavoitteena on tarjota kaikille yhdenvertaiset terveydenhuollon palvelut asuinpaikasta ja sosioekonomisesta taustasta riippumatta. Alueellinen yhdenvertaisuus on parantunut Suomessa viime vuosikymmenien aikana[4]. Syövän ilmaantuvuudessa, hoitotuloksissa ja suhteellisessa elossaoloajassa esiintyy silti edelleen suurta alueellista vaihtelua.

Tutkimukset osoittavat, että kaukana sairaalasta/maaseudulla asuvilla ihmisillä syöpä todetaan keskimäärin pidemmälle edenneenä. Syrjäseuduilla perusterveydenhuollon palvelujen saatavuus on heikompaa, väestön terveydenlukutaito huonompaa ja hoitoon hakeutuminen hitaampaa kuin kaupungeissa[5]. Myös erilainen altistuminen syöpäriskiä lisääville tekijöille, kuten radonille, asbestille, tupakalle sekä elintapoihin ja terveyskäyttäytymiseen liittyville altisteille, voi vaikuttaa syövän ilmaantuvuuden alueellisiin eroihin[6,7].

Syöpäpotilaan polku perusterveydenhuollosta jatkotutkimuksiin ja erikoissairaanhoitoon on monitahoinen ja sisältää aina useita terveydenhuollon kontakteja ja tutkimuksia. Syövän ensioireesta diagnoosiin ja hoidon aloittamiseen kuluvassa ajassa esiintyy tällä hetkellä suurta alueellista vaihtelua, joka riippuu myös siitä, mitä kautta

4 K. Seppä, N. Malila, ja J. Pitkäniemi. Variation in cancer survival between hospital districts and within them in Finland. Acta Oncologica, vol. 59, no. 11, pp. 1316–1321, Nov. 2020.
5 S. Bhatia ym. Rural–Urban Disparities in Cancer Outcomes: Opportunities for Future Research. Journal of the National Cancer Institute, vol. 114, no. 7, pp. 940–952, Jul. 2022.
6 O. Kurkela, ym. Lung cancer incidence attributable to residential radon exposure in Finland. Radiat Environ Biophys, vol. 62, no. 1, pp. 35–49, Mar. 2023.
7 S. Laaksonen, ym. Malignant pleural mesothelioma in Finland: regional and gender variation. Acta Oncologica, vol. 58, no. 1, pp. 38–44, Jan. 2019.

potilas on hakeutunut tutkimuksiin. Jollei potilas osaa itse vaatia kiireellistä hoitoa tai jos palveluketjun koordinointi on puutteellista, hoidon alkamiseen kuluva kokonaisaika saattaa venyä erittäin pitkäksi.

Syövän hoito vaatii aina erityisosaamista, ja hoidon keskittäminen osaamiskeskuksiin on tutkitusti parantanut syövän hoitotuloksia. Etenkin vaativan syöpäkirurgian tulokset ovat parhaita suuren volyymin keskuksissa. Keskittämisasetuksen (582/2017) myötä suurin osa syöpäkirurgiasta tehdään yliopistosairaaloissa. Myös syövän vaativa lääkehoito, soluterapiahoidot, sädehoito ja kliiniset lääketutkimukset on keskitetty yliopistosairaaloihin ja isoimpiin keskussairaaloihin. Suomi poikkeaa useimmista Euroopan maista harvan asutuksen, pitkien etäisyyksien ja julkisen liikenteen vähäisyyden osalta. Osalla väestöstä matka lähimpään keskussairaalaan on yli 400 km ja lähimpään yliopistosairaalaan yli 700 km. Etäisyys heikentää kaukana sairaalasta asuvien potilaiden mahdollisuutta saada pitkäkestoista ja toistuvia sairaalakäyntejä vaativaa hoitoa ja sitoutumista tällaiseen hoitoon.

Palliatiivisen sädehoidon käyttö on tutkitusti vähäisempää potilailla, jotka asuvat yli 100 km:n päässä lähimmästä sädehoitoyksiköstä[8], ja hoitotulokset ovat heikompia jo silloin, jos potilas asuu yli 50 km:n päässä hoitoyksiköstä[9]. Etäisyys hoitoyksikköön voi vaikuttaa myös muihin hoitopäätöksiin. Esimerkiksi rintasyövän leikkaustekniikka voidaan valita tavanomaista laajemmaksi, jotta vältyttäisiin sädehoidon aiheuttamalta matkustamiselta, tai potilas voi haluta tutkimuksissa mahdollisesti heikommin tehonneen hoidon, jos se voidaan toteuttaa kotona tai lähellä kotia. Alueellisesti yhdenvertaisen hoidon takaamiseksi – ja toisaalta myös matkakustannusten hillitsemiseksi – on keskittämisen ohella varmistettava, että sairaalaverkosto on riittävän tiheä. Lisäksi on huolehdittava siitä, että hoidot, jotka on mahdollista toteuttaa hajautetusti esimerkiksi etäpalveluja hyödyntämällä tai perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyötä lisäämällä, annetaan mahdollisimman lähellä potilaan kotia[10]. Harvaan asutuilla alueilla ja kaukana kaupungeista asuvien syöpäpotilaiden palliatiivinen hoito tulisi voida tarjota myös kotiin tai mahdollisimman lähelle kotia kotisairaalan kautta.

Syövän hoitokäytännöt vaihtelevat alueittain, ja samaa syöpää voidaan hoitaa eri tavoin potilaan valitsemasta hoitopaikasta riippuen. Kansalliset ja kansainväliset syövän hoitosuositukset parantavat hoidon yhdenvertaisuutta ja hoitotuloksia[11] myös alueellisen yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Hoitosuositukset mahdollistavat syövän hoidon riittävän osaamistason ja tiedon jatkuvan päivittämisen myös keskussairaaloissa, joissa syövän hoidosta vastaavalla lääkärillä on oltava perustiedot kaikista yleisimmistä syöpätyypeistä.

8 L. M. Åsli ym. Factors influencing access to palliative radiotherapy: a Norwegian population-based study. Acta Oncologica, vol. 57, no. 9, pp. 1250–1258, Sep. 2018.
9 N.-M. Paakkola, ym. Area-based disparities in non-small-cell lung cancer survival. Acta Oncologica, vol. 63, pp. 146–153, Apr. 2024.
10 M. Jääskeläinen, ym. Onkologinen ja palliatiivinen hoito etäpalveluna. Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim, vol. 139, no. 18, pp. 1429–35, 2023.
11 G. M. Boland ym. Association between adherence to National Comprehensive Cancer Network treatment guidelines and improved survival in patients with colon cancer. Cancer, vol. 119, no. 8, pp. 1593–1601, Apr. 2013.

Alueelliseen eriarvoisuuteen liittyvät osatavoitteet ja toimenpiteet:

Tavoitetilanteessa jokaisella suomalaisella on yhdenvertainen pääsy diagnostiikan ja syövänhoidon piiriin asuinpaikasta riippumatta. Tätä tavoitetta edistetään seuraavissa osatavoitteissa: *2.5 Syövät havaitaan varhaisessa vaiheessa kaikkialla terveydenhuollossa, 3.1 Kansalliset hoitosuositukset ja hoitoketjut ohjaavat yhdenvertaista, viiveetöntä ja vaikuttavaa hoitoa; 3.2 Kansallisen syövänhoidon laaturekisteri, systemaattinen tulosten tarkastelu ja vertaisarviointi tukevat vaikuttavan hoidon kehittämistä; 3.3 Kuntoutus, psykososiaalinen tuki, terveyssosiaalityö ja palliatiivinen hoito ovat vakiintunut osa syöpäpotilaan hoitoa ja yhdenvertaisesti saatavilla, 3.5 Riittävä ja osaava henkilöstö varmistaa vaikuttavan ja ihmislähtöisen syövän hoidon* ja *4.5 Uusien syöpälääkkeiden ja muiden hoitomenetelmien arviointi ja käyttöönotto on vaikuttavaa, viiveetöntä ja yhtenevää arviointitahosta riippumatta.*

Ikääntyneet

Vuonna 2022 Suomessa todettiin 37 268 uutta syöpätapausta, ja vuonna 2040 tapauksia arvioidaan olevan noin 48 500. Kasvu johtuu pääasiassa väestön ikääntymisestä. Yli 75-vuotiailla todettujen syöpien lukumäärä kasvaa yli 60 % vuoteen 2040 mennessä, ja joka viides uusi syöpä todetaan yli 85-vuotiailla.

Iäkkäiden syöpäpotilaiden suuresta määrästä huolimatta iäkkäät ovat aliedustettuina kliinisissä lääketutkimuksissa, minkä vuoksi tieteellinen näyttö syöpälääkkeiden siedettävyydestä ja tehosta iäkkäillä potilailla on puutteellista[12]. Vaikka hyväkuntoiset iäkkäät hyötyvät syöpähoidoista, osalla elimistön haurastuminen, geriatriset oireyhtymät sekä muut sairaudet heikentävät voimavaroja siinä määrin, että hoidon haitat voivat ylittää hyödyt.

Syövän diagnostiikka, hoito ja seuranta on sairauskeskeistä, ja iäkkään potilaan toimintakyvyn arviointi ja osallistuminen päätöksentekoon jää usein puutteelliseksi. Potilaita saatetaan ohjata invasiivisiin diagnostisiin, hoidollisiin ja seurantatoimenpiteisiin tunnistamatta hauraita ja/tai monisairaita potilaita, joilla tällaiset toimenpiteet edellyttäisivät kliinistä arviointia. Invasiiviset tutkimukset, kuten kolonoskopia tyhjennyksineen, voivat olla hauraille potilaille haitallisia ja epäeettisiä, eivätkä ne välttämättä ole vaikuttavia.

Geriatris-onkologinen toiminta ja koulutus on Suomessa järjestäytymätöntä. Euroopan geriatrian erikoislääkärien koulutussuositus suosittaa geriatris-onkologisen

12 M. S. Sedrak ym. Older adult participation in cancer clinical trials: A systematic review of barriers and interventions. A Cancer J Clinicians, vol. 71, no. 1, pp. 78–92, Jan. 2021.

osaamisen sisällyttämistä erikoislääkärikoulutukseen. Yliopistosairaaloissa ei ole riittävästi koulutuspaikkoja geriatriaan erikoistuville lääkäreille, eivätkä geriatriset näkökulmat tule riittävästi esille erikoistuvien syöpälääkäreiden koulutuksessa. Samat haasteet koskevat hoitohenkilöstön koulutusta.

Iäkkäiden hoidossa käytössä olevat suomenkieliset mittarit
G8-seula ja sen variaatiot
Clinical Frailty Scale (CFS)
Ravitsemustilaan liittyvät mittarit esim. MNA ja NRS2002
Practical Geriatric Assessment -lomakkeen suomennos ja validointi

Kansallisten syöpäkohtaisten hoitosuositusten tulee ohjata selvittämään iäkkään potilaan kokonaistilanne. Toimintakykytiedon tulee ohjata syövän hoitosuunnitelmaa siten, että hauraille potilaille annetaan eri hoitosuositukset kuin hyväkuntoisille, joita voidaan hoitaa kuten nuorempia. Joissakin syövissä, esimerkiksi lymfoomissa, tautitaakka voi heikentää toimintakykyä, joka korjaantuu onkologisen hoidon myötä. Osalla potilaista taas ravitsemushoito tai muu interventio voi auttaa palauttamaan toimintakykyä.

Osalla iäkkäistä syöpäpotilaista toimintakyky on peruuttamattomasti heikentynyt. Tällöin potilas ei välttämättä siedä raskaita syöpähoitoja, vaan hyötyy enemmän palliatiiviseen hoitoon ohjaamisesta.

Suomeen tarvitaan syöpäkeskustasoista kansallista ohjausta geriatrisessa onkologiassa. Kansallinen geriatrisen onkologian yhteisö tukee toimintaa ja henkilöstön kouluttamista ja tekee yhteistyötä kansainvälisten yhdistysten kanssa. Yhteisö osallistuu syöpäkohtaisten hoitosuositusten tekemiseen ja huolehtii siitä, että ikääntyneet huomioidaan niissä.

Ikääntyneisiin liittyvät osatavoitteet ja toimenpiteet:

Tässä luvussa esitettyjen tavoitteiden toteutumista edistetään seuraavissa osatavoitteissa: *3.1 Kansalliset hoitosuositukset ja hoitoketjut ohjaavat yhdenvertaista, viiveetöntä ja vaikuttavaa hoitoa; 3.3 Kuntoutus, psykososiaalinen tuki, terveyssosiaalityö ja palliatiivinen hoito ovat vakiintunut osa syöpäpotilaan hoitoa ja yhdenvertaisesti saatavilla; 3.4 Toimintakykytieto ohjaa ikääntyneiden syöpäpotilaiden diagnostiikkaa ja hoitoa* ja *3.5 Riittävä ja osaava henkilöstö varmistaa vaikuttavan ja ihmislähtöisen syövän hoidon.*

Lasten ja nuorten syövät

Syöpään sairastuu Suomessa vuosittain noin 200 alle 18-vuotiasta. Lasten ja nuorten syövän diagnostiikka, hoidon suunnittelu ja pääosin myös hoidon toteutus on keskitetty yliopistosairaaloihin. Lasten allogeeniset kantasolujensiirrot on keskitetty kansallisesti HUSiin, mistä hoitovastuu palautuu omaan yliopistosairaalaan. Hoitojen päättyessä yliopistosairaala suunnittelee potilaan yksilöllisen seurannan, joka toteutuu yhteistyössä keskussairaaloiden kanssa. Merkittävälle osalle kasvuiässä syöpähoitoja saaneista kehittyy myöhäisiä haittavaikutuksia, minkä vuoksi kaikille potilaille laaditaan yliopistosairaalassa hoitoyhteenveto ja aikuisiän seurantasuositus[13]. Jokainen syöpähoitoa antava yksikkö seuraa omaa toimintaansa ja voi verrata sitä kansainväliseen tasoon lasten syöpien laaturekisterityökalun (BCB-Medical) sekä kansainvälisten hoitotutkimusten avulla.

Lasten ja nuorten syöpäsairaudet kuuluvat harvinaissairauksiin, ja jokaisen diagnoosiryhmän (International Classification of Childhood Cancer) potilaiden hoito toteutetaan kansainvälisten hoito-ohjeiden mukaisesti. Potilaat hoidetaan pääosin kansainvälisissä akateemisissa kliinisissä hoitotutkimuksissa, joista valtaosaa koordinoi eurooppalainen konsortio, SIOPE (The European Society for Paediatric Oncology)[14]. Riskiluokitus, diagnostiikka (molekyyligeneettiset tutkimukset mukaan lukien) ja strukturoitu seuranta toteutetaan näiden hoitotutkimusten ohjeistamana. Hoitotutkimuksia tehdään pääosin säätiörahoituksella ja lahjoitusvaroin. Lisäksi kantasolujen siirtotoiminnalta edellytetään akkreditointistatuksen ylläpitoa ja dokumentointia. Suomalaiset hoitotulokset ovat vakiintuneen toimintamallin ansiosta korkealla tasolla[15]. Riskiryhmien parempi tunnistaminen molekyylityypityksen avulla mahdollistaa hoitojen keventämisen ja myöhäisvaikutusten vähentämisen. Näitä vaikutuksia on tärkeää seurata myös aikuisiässä, jolloin ennenaikaista sairastuvuutta ja kuolleisuutta voidaan ehkäistä oikea-aikaisilla interventioilla[16].

Syövän molekyylityypitys mahdollistaa kohdennetun lääkehoidon, mutta täsmä- ja immunologisten hoitojen indikaatiot alaikäisille vahvistuvat hitaasti. Tutkimusta edistetään kansainvälisissä verkostoissa, kuten ITCC:ssä (Innovative Therapies for Children and Adolescents for Cancer). Suomessa on kaksi ITCC-keskusta, joissa vakiintunut kliinisen tutkimuksen yksikkö (CTU) mahdollistaa varhaisvaiheiden kliiniset lääketutkimukset. Pieni rekrytoitavissa olevien potilaiden lukumäärä voi kuitenkin rajoittaa yritysten halukkuutta investoida maahamme.

13 The International Late Effects of Childhood Cancer Guideline Harmonization Group, IGHG. www.ighg.org
14 The European Society for Paediatric Oncology. https://siope.eu/
15 C. Allemani, ym. Global surveillance of trends in cancer survival 2000–14 (CONCORD-3): analysis of individual records for 37 513 025 patients diagnosed with one of 18 cancers from 322 population-based registries in 71 countries. The Lancet, Volume 391, Issue 10125, 1023 – 1075.
16 Erdmann F, ym. Childhood cancer: Survival, treatment modalities, late effects and improvements over time. Cancer Epidemiol. 2021 Apr;71(Pt B):101733.

Syöpäalttiuteen johtavien geenivirheiden tunnistaminen lapsuusiän syövissä on tärkeää hoitojen ja seurantasuunnitelmien yksilöimiseksi[17, 18]. Eksomin ja kokogenomin sekvensointi yleistyy diagnostiikassa, mutta geneettisen neuvonnan resurssit ovat riittämättömiä.

Potilaille ja heidän läheisilleen tarjottava psykososiaalinen tuki vaihtelee alueittain ja riippuu myös perheen taustasta. Kansainväliset standardit[19] eivät toteudu täysin, mikä on jo vaikuttanut hoitotuloksiin[20], ja sosioekonomiset erot uhkaavat jäädä pysyviksi[21]. Suomalaisessa sairaalasuunnittelussa on alettu huomioida nuorten ikäspesifejä tarpeita, ja erityistyöntekijöiden lukumäärää on lisätty, mutta kehityksen tulee jatkua eurooppalaisen suosituksen mukaisesti[22].

Tavoitetila

Tavoitteena on syöpähoitojen huipputaso: Kansainväliset kliiniset hoitotutkimukset takaavat parhaan diagnostiikan, hoidon ja seurannan. Kliinisen tutkimusten yksiköiden toimintaa on vahvistettu siten, että hoitotutkimusten hallinnollisista prosesseista huolehditaan strukturoidusti, ja Suomi on uskottava kumppani lasten faasin I–III tutkimuksissa. Syövänhoidon nykyaikaisin teknologia (muun muassa sädehoidon eri modaliteetit, kuten protonihoito) on esteettä suomalaisten potilaiden saatavilla. Suuria tietoaineistoja ja tekoälyä hyödynnetään diagnostiikan ja kohdennettujen hoitojen kehittämisessä.

Geenivirheiden tunnistus: Syöpäalttiuteen johtavien geenivirheiden iturata tutkimukset ovat osa rutiinidiagnostiikkaa potilailla, joiden syöpätyyppi, liitännäislöydökset tai sukuhistoria antavat niihin aihetta[23]. Tutkimusten ansiosta hoito voidaan suunnitella yksilöidysti ja suvussa esiintyvät syöpäalttiuteen johtavat geenivirheet tunnistaa, jolloin geenivirhettä kantaville henkilöille voidaan luoda tarvittavat seurantaohjelmat[24]. Myös perinnöllisyysneuvonta on olennaisen tärkeää (testitulosten ymmärtäminen, psykologisten vaikutusten hallinta).

Psykososiaalinen tuki: Sosioekonomisiin ja kulttuurisiin taustatekijöihin liittyvät lasten ja nuorten syövän ennusteiden eroavaisuudet tasoittuvat tai poistuvat.

17 J. R. Hansford, ym. Update on Cancer Predisposition Syndromes and Surveillance Guidelines for Childhood Brain Tumors. Clin Cancer Res. 2024 Jun 3;30(11):2342-2350.
18 T. Ripperger, ym. Childhood cancer predisposition syndromes-A concise review and recommendations by the Cancer Predisposition Working Group of the Society for Pediatric Oncology and Hematology. Am J Med Genet A. 2017 Apr;173(4):1017-1037.
19 Wiener L, ym. Standards for the Psychosocial Care of Children With Cancer and Their Families: An Introduction to the Special Issue. Pediatr Blood Cancer. 2015 Dec;62 Suppl 5:S419-24.
20 A. Tolkkinen, ym. Impact of parental socioeconomic factors on childhood cancer mortality: a population-based registry study. Acta Oncol. 2018 Nov;57(11):1547-55.
21 Kyrönlahti, A: Socioeconomic Aspects Within Childhood Cancer 2024. Väitöskirja, Helsingin yliopisto.
22 U. Kosir, ym. Recommendations and Implementation Roadmap for Minimum Standards of Specialist Adolescent and Young Adult (AYA) Cancer Care Units. Youth Cancer Europe, 2024.
23 K. Zelley, ym. Update on Genetic Counselor Practice and Recommendations for Pediatric Cancer Predisposition Evaluation and Surveillance. Clin Cancer Res. 2024 Sep 13;30(18):3983-9.
24 S. B. Dixon, ym. The Future of Childhood Cancer Survivorship: Challenges and Opportunities for Continued Progress. Pediatr Clin North Am. 2020;67:1237-51.

Laadukas psykososiaalinen tuki tavoittaa kaikki lapsena ja nuorena syöpään sairastuneet, ja hoitavissa yksiköissä panostetaan psyko-onkologiseen erityisosaamiseen.

Myöhäisvaikutusten hallinta: Myöhäisvaikutuksia kokevien syöpäpotilaiden aikuisiän fyysisen ja psykososiaalisen kuntoutumisen HYVA-palvelupolku, joka on suunniteltu valtakunnallisen työryhmän toimesta, toteutuu tasapuolisesti erikoissairaanhoidon koordinoimana.

Kansainvälinen yhteistyö: Suomella on vahva rooli kansainvälisissä tutkimus- ja asiantuntijaverkostoissa (mm. SIOPE, ITCC, PanCare).

Lasten ja nuorten syöpiin liittyvät osatavoitteet ja toimenpiteet:

Tässä luvussa esitettyjen tavoitteiden toteutumista edistetään muun muassa seuraavissa osatavoitteissa ja niihin liittyvissä toimenpiteissä: *3.1 Kansalliset hoitosuositukset ja hoitoketjut ohjaavat yhdenvertaista, viiveetöntä ja vaikuttavaa hoitoa; 3.2 Kansallisen syövänhoidon laaturekisteri, systemaattinen tulosten tarkastelu ja vertaisarviointi tukevat vaikuttavan hoidon kehittämistä; 3.3 Kuntoutus, psykososiaalinen tuki, terveyssosiaalityö ja palliatiivinen hoito ovat vakiintunut osa syöpäpotilaan hoitoketjua ja yhdenvertaisesti saatavilla; 3.5 Riittävä ja osaava henkilöstö varmistaa vaikuttavan ja ihmislähtöisen syövän hoidon; 4.2 Vahvistuva kliininen syöpätutkimus on tiivis osa jokaisen potilaan hoitoa* ja *4.3 Suomi on yksilöllisen lääketieteen edelläkävijä*.

Harvinaiset syövät ja perinnölliset syöpäalttiusoireyhtymät

Harvinaiset syövät

Syöpä luokitellaan harvinaiseksi, mikäli uusia tapauksia todetaan vuosittain alle 6/100 000 henkilöä. Harvinaisia syöpiä esiintyy kaikissa ikäryhmissä ja ne koskettavat kaikkia elinryhmiä. Noin viidenneksellä syöpäpotilaista sairaus luokitellaan harvinaiseksi, joten harvinaiseen syöpään sairastuu Suomessa vuosittain noin 7000 henkilöä. Harvinaisen syövän haasteet ovat moninaiset ja osin erilaiset eri syövissä.

Tavanomaisesta syövästä poikkeava ilmiasu tai epämääräiset oireet viivästyttävät hoitoon pääsyä erityisesti silloin, kun syöpään sairastutaan nuorella iällä. Diagnostiikka saattaa edellyttää erityismenetelmiä ja lisätutkimuksia, joiden teettämiseksi ammattilaisen on osattava epäillä harvinaista syöpää. Huomattava osa potilaista käy monen lääkärin luona ennen oikean diagnoosin saamista. Lisäksi monet potilaat saavat ensin yhden tai useamman virheellisen diagnoosin. Oikeaan diagnoosiin vaadittavaa patologian ja genetiikan erityisosaamista ei myöskään löydy kaikilta hyvinvointialueilta.

Kun diagnoosiin on päädytty, hoitosuositusten puute tai vaikeudet saada potilaalle toimivaa lääkitystä voivat vaikeuttaa hoidon toteuttamista. Erityisesti kohdennettujen lääkehoitojen tiedetään toimivan tavanomaista useammin harvinaisissa tautidiagnooseissa. Syöpäoireyhtymien eri syöpätyypit saattavat myös jakaa yhteisen molekyylimekanismin, joihin hoito tehoaisi syöpätyypistä riippumatta. Usein päätös mahdollisen lääkkeen korvattavuudesta kuitenkin puuttuu, ja tehokas hoito olisi annettava virallisen käyttöaiheen ulkopuolelta (ns. off-label).

Harvinaista syöpää sairastavien on myös muita vaikeampi löytää tietoa sairaudestaan, tai tietoa sairaudesta ei ole saatavilla. Lisäksi potilaat jäävät herkemmin vaille vertaistukea ja ovat siten alttiimpia psyykkisille ja sosiaalisille ongelmille. Vaikka harvinaiset syövät ovat moninaisia ja keskenään erilaisia sairauksia, monet harvinaisuudesta johtuvat haasteet yhdistävät niitä. Haasteiden ratkaisemiseksi harvinaisia syöpiä on syytä käsitellä yhtenä kokonaisuutena, ja tunnistettuihin ongelmakohtiin on suunniteltava toimivia ratkaisuja.

Suomessa on viime vuosina kehitetty kansallista yhteistyötä harvinaisten syöpien ja syöpäalttiusoireyhtymien hoidon parantamiseksi FICAN Southin ja FICAN Midin koordinoimassa kansallisessa hankkeessa. Kehittämistyössä keskeisiksi haasteiksi on tunnistettu erityisesti diagnoosiviiveet, hoitopolun kokonaisuuden selkeys, seurannan yhdenmukaisuus sekä asiantuntijaosaamisen ja lääkkeiden saatavuus. Lisäksi ohjaaminen kolmannen sektorin palveluihin toteutuu puutteellisesti. Näiden haasteiden ratkaiseminen edellyttää kansallisesti koordinoituja toimintamalleja harvinaisten syöpien diagnostiikan, hoidon ja seurannan tueksi myös jatkossa.

Suomalaisia yliopistosairaaloita on jäseninä seuraavissa eurooppalaisissa harvinaissyöpien verkostoissa: ERN EURACAN (HUS, Tays, Tyks), ERN EuroBloodNet (HUS), ERN Genturis (HUS, OYS, Tyks) sekä ERN PaedCan (kaikki yliopistosairaalat). Syövän hoidossa voidaan tarvittaessa konsultoida eurooppalaisia kollegoita ja hyödyntää suuren verkoston mukanaan tuomaa tietoa ja osaamista. Eurooppalaisten osaamisverkostojen työhön osallistuminen sekä konsultointimahdollisuuksien hyödyntäminen on kuitenkin tällä hetkellä vaikeaa Suomessa toimivien ammattilaisten vähäisen työaikaresurssin vuoksi.

HUSissa toimii harvinaisten syöpien ja syöpäalttiusoireyhtymien asiakasraati, jossa on potilaita myös Helsingin ulkopuolelta. Potilaat osallistuvat ratkaisujen ideoimiseen ja kehittämiseen sekä tiedon tuottamiseen esimerkiksi verkkosivuja tai tietolehtisiä varten. Potilaat myös toimivat puhujina erilaisissa koulutustilaisuuksissa.

Tavoitetila

Tavoitteena on, että syöpästrategian toimeenpanoa toteuttavilla tahoilla on harvinaisiin syöpiin ja syöpäalttiusoireyhtymiin liittyvää asiantuntemusta ja henkilöstöä, joka koordinoi potilaiden erityistarpeiden toteutumista omilla alueillaan sekä ylläpitää kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä. Asiantuntijat tuottavat rekisteritasoista näkemystä harvinaisten syöpien lukumääristä ja hoitotuloksista, tunnistavat tieteellisiä

tutkimustarpeita sekä järjestävät harvinaisia syöpiä ja syöpäalttiusoireyhtymiä koskevaa koulutusta.

Harvinaisten syöpien hoitopolut sekä niitä koskevat erityisohjeet (mukaan lukien erityisen tuen tarve, kansalliset ja kansainväliset konsultaatiomahdollisuudet kuten EURACAN ja GENTURIS, ORPHA-koodaus hoitotietoihin ja varhainen molekyyliprofilointi mahdollisten hoitokeinojen kartoittamiseksi) on määritelty ja kaikkien ammattilaisten tiedossa. Kolmannen sektorin palvelut on integroitu palvelupolkuihin. Suomessa toimii harvinaisten syöpien asiakasraati, jossa on mukana potilaita kattavasti ympäri maata.

Harvinaisiin syöpiin ja syöpäalttiusoireyhtymiin on Suomessa tarjolla sekä akateemisia että yrityslähtöisiä kliinisiä lääketutkimuksia. Potilaiden osallistumiselle Suomen ulkopuolella toteutettaviin kliinisiin lääketutkimuksiin (mm. EURACAN- ja GENTURIS-yhteistyö) on selkeä toimintaohje.

Suomessa on toimiva järjestelmä, joka mahdollistaa tunnetusti tehokkaan lääkityksen antamisen harvinaista syöpää sairastaville riippumatta siitä, mikä on kyseisen lääkkeen virallinen käyttöaihe tai korvaustaso.

Ammattilaisille on varattu työaikaa kansainväliseen verkostotoimintaan osallistumiselle ja kansainvälisten konsultointimahdollisuuksien hyödyntämiselle. Kansainvälistä vuorovaikutusta pidetään harvinaisten syöpien ja syöpäalttiusoireyhtymien hoidon strategisena tavoitteena.

Harvinaisiin syöpiin liittyvät osatavoitteet ja toimenpiteet:

Syöpästrategian toimeenpanoa toteuttavilla tahoilla tulee olla asiantuntemusta harvinaisista syövistä, mikä tukee tässä luvussa esitettyjen tavoitteiden toteutumista. Harvinaisia syöpiä koskevat lisäksi seuraavat osatavoitteet: *3.1 Kansalliset hoitosuositukset ja hoitoketjut ohjaavat yhdenvertaista, viiveetöntä ja vaikuttavaa hoitoa; 3.2 Kansallisen syövänhoidon laaturekisteri, systemaattinen tulosten tarkastelu ja vertaisarviointi tukevat vaikuttavan hoidon kehittämistä; 4.2 Vahvistuva kliininen syöpätutkimus on tiivis osa jokaisen potilaan hoitoa ja 4.3 Suomi on yksilöllisen lääketieteen edelläkävijä* ja *4.5 Uusien syöpälääkkeiden ja muiden hoitomenetelmien arviointi ja käyttöönotto on vaikuttavaa, viiveetöntä ja yhtenevää arviointitahosta riippumatta.*

Perinnölliset syöpäalttiusoireyhtymät

Harvinaiset syöpäalttiusoireyhtymät esiintyvät tavallisten syöpien joukossa molekyyligeneettisesti eriytyvinä syöpinä. Syöpäalttiusoireyhtymät ovat nykykeinoin vaikeasti tunnistettavissa. Tiettyjen harvinaisten alatyyppien osalta kasvainten seulonta molekulaaristen poikkeavuuksien osalta on kustannusvaikuttavaa, mutta ei toteudu

puutteellisten diagnostisten resurssien vuoksi, tai toiminta on epäorganisoitunutta (esimerkiksi MMR-värjäykset). Nuorella iällä alkavissa syövissä potilaiden ohjautuminen hoitosuositusten mukaiseen perinnöllisyysneuvontaan ja geneettiseen testaukseen ontuu. Harvinaiseksi luokiteltujen, korkean syöpäriskin geneettisten muutosten kantajien (esimerkiksi Lynchin oireyhtymä ja polypoosit) rekisteröinnin on todettu parantavan ennaltaehkäisevän diagnostiikan, seurannan ja hoidon laatua, mutta lainsäädäntö ei mahdollista kansallista laaturekisterityötä, terveydenhuollon yhteydenottoja eikä keskitettyä hoidon ohjausta. Lisääntyvä kasvaintestaus ja geenisekvensointi kasvattavat syövälle altistavien geenivirheiden kantajien määrää, ja onkin tiedossa, ettei periytyvien syöpäoireyhtymien kantajista valtaosaa ole tunnistettu terveydenhuollossa aiemmin.

Tavoitetila

Tavoitteena on, että kasvainten molekulaarista ja/tai molekyyligeneettistä profilointia lisätään kustannusvaikuttavasti harvinaisten syöpien tunnistamiseksi. Jos aihetta on, perinnöllisten syöpäalttiusoireyhtymien mahdollisuus selvitetään ituradan geenitestauksella, ja lähisukulaiset kontaktoidaan perinnöllisyysneuvontaa varten. Erityisesti nuorella iällä alkavissa syövissä geneettiset selvittelyt tulisi toteuttaa poikkeuksetta, ja jokainen halukas saisi vähintään neuvontaa geenitestausta koskevan päätöksen pohjaksi. Jokaisessa syöpää hoitavan erikoissairaanhoidon toimipisteessä tulisi olla asiantuntija, joka on perehtynyt yleisimpien harvinaisten kasvainten diagnostiikkaan ja hoitoon. Henkilöitä, joilla on kohonnut syöpäriski, seurataan hoitosuositusten mukaisesti.

Yleisimpien monogeenisesti periytyvien syöpäalttiuksien geenivirheen kantajat (kuten *MLH1, MSH2, MSH6, PMS2, BRCA1, BRCA2, PALB2, APC*) sekä periytyvän syöpäalttiuden kliinisen määritelmän täyttävät ovat kansallisissa laatu- ja seurantarekistereissä, joiden avulla ennaltaehkäisyä ja syöpien varhaista toteamista parannetaan keskitetysti, mikä vähentää kustannuksia. Lainsäädännön tulee mahdollistaa myös harvinaisten syöpien ja perinnöllisten syöpäalttiusoireyhtymien laaturekisteritoiminta. Niiden avulla diagnostiikan, seurannan ja hoidon seurantaa voidaan johtaa keskitetysti kansallisella ja hyvinvointialueiden tasolla.

Tavoitteen toteutumista voi seurata esimerkiksi rekisteröityjen harvinaissyöpien ja terveiden tunnistettujen geenivirheen kantajien lukumäärän kehittymistä kuvaavilla mittareilla sekä seuraamalla suositusten mukaisesti toteutunutta ennaltaehkäisyä ja seurantaa, syöpien ilmaantuvuutta ja elossaoloa.

Geneettisten korkean riskin varianttikantajien tunnistamista tulee tehostaa ohjeistamalla kasvaintestauksen vähimmäisvaatimuksia (esim. MMR- ja HRD-testaukset), varhaisella iällä sairastuvien syöpäpotilaiden geneettistä diagnostiikkaa ja lähisukulaisten kaskaditestausta. Verrokkina voi toimia esimerkiksi Tanskan periytyvän kolorektaalisyövän rekisterin toiminta. Mittarina voi olla laaturekistereistä tai syövän tietovarannosta osoitettujen tavanomaista nuoremmalla iällä syöpään sairastuneen ohjautuminen perinnöllisyysneuvontaan tai geenitestaukseen.

Kansallisiin hoitosuosituksiin on tärkeää sisällyttää periytyvien syöpäalttiusoireyhtymien diagnostiikkaa, seurantaa ja hoitoa. Lisäksi on otettava käyttöön uusia menetelmiä, joilla tunnistetaan patogeeninen variantti (esimerkiksi biopankkitutkimuksissa kertyneen tiedon palauttaminen). Perinnölliselle syöpäalttiudelle nimetään paikalliset vastuuhenkilöt yksiköittäin ja oireyhtymäkohtaisesti (ns. local champions). Tässä esimerkkiä voi ottaa Isosta-Britanniasta.

Perinnöllisiin syöpäalttiusoireyhtymiin liittyvät osatavoitteet ja toimenpiteet:

Tässä luvussa esitettyjen tavoitteiden toteutumista edistetään muun muassa seuraavissa osatavoitteissa ja niihin liittyvissä toimenpiteissä: *2.4 Lainsäädäntö ja rekisteritieto mahdollistavat laadukkaan, kustannusvaikuttavan ja riskiperusteisen seulonnan; 2.5 Syövät havaitaan varhaisessa vaiheessa kaikkialla terveydenhuollossa; 3.1 Kansalliset hoitosuositukset ja hoitoketjut ohjaavat yhdenvertaista, viiveetöntä ja vaikuttavaa hoitoa; 3.2 Kansallisen syövänhoidon laaturekisteri, systemaattinen tulosten tarkastelu ja vertaisarviointi tukevat vaikuttavan hoidon kehittämistä; 4.2 Vahvistuva kliininen syöpätutkimus on tiivis osa jokaisen potilaan hoitoa; 4.3 Suomi on yksilöllisen lääketieteen edelläkävijä* ja *4.5 Uusien syöpälääkkeiden ja muiden hoitomenetelmien käyttöönotto on vaikuttavaa, viiveetöntä ja yhtenevää arviointitahosta riippumatta.*

Huonon ennusteen syövät

Suomessa syöpäpotilaiden selviytyminen on parantunut merkittävästi, ja maamme on syövän hoidossa kansainvälistä huipputasoa. Tietyt syövät, kuten haima-, maksa-, sappirakko-, sappitie-, keuhko-, ruokatorvi- ja mahasyövät, kuuluvat kuitenkin edelleen kansainvälisestikin huonon ennusteen syöpiin. Nämä syövät diagnosoidaan usein vasta edenneessä vaiheessa, jolloin hoidot eivät enää ole parantavia ja ennuste on huomattavasti heikompi. Eri hoitovaihtoehtojen teho on usein rajallinen, ja valitettavasti suurin osa potilaista menehtyy syöpään.

Huonon ennusteen syöpien oireet voivat olla epämääräisiä, mikä saattaa alkuvaiheessa johtaa puutteisiin diagnostiikassa ja viivästyttää hoitoon pääsyä. Myös esimerkiksi tupakointiin ja keuhkosyöpään liittyvä stigma ja oletus hoitojen heikosta tehosta voivat viivyttää hoitoon hakeutumista ja pääsyä. Osa näistä syövistä on myös vaikea havaita varhaisessa vaiheessa nykyisillä diagnostisilla menetelmillä. Tietyissä syövissä riskiryhmien seuranta on tärkeä osa varhaista diagnostiikkaa, ja esimerkiksi perinnöllisestä haimasyövästä on juuri julkaistu kansalliset seurantasuositukset. Lainsäädännölliset esteet, kuten toisiolaki, ovat vaikeuttaneet kansainvälistä tutkimusyhteistyötä. Vain pieni osa potilaista hoidetaan kliinisissä hoitotutkimuksissa.

Tavoitetila

Tavoitteena on, että kymmenen vuoden kuluttua huonoennusteisten syöpien diagnostiikka ja hoito ovat kehittyneet merkittävästi. Riskiryhmät pystytään tunnistamaan entistä tehokkaammin ja kustannusvaikuttavammin. Oireiset henkilöt hakeutuvat ja pääsevät tutkimuksiin ja hoitoon ilman turhia viiveitä. Varhainen diagnostiikka on tarkentunut esimerkiksi leikekuvantamistekniikan ja tekoälyn avulla. Käytettävissä on uusia ja tehokkaampia hoitoja, ja merkittävä osa potilaista hoidetaan kliinisissä hoitotutkimuksissa. Elossaolo on parantunut merkittävästi ja yhä useampi potilas saadaan parantavan hoidon piiriin.

Kansallinen syöpärekisteri on kehittynyt aiempaa kattavammaksi ja kansainvälisesti yhteensopivaksi. Tämä mahdollistaa tiiviin yhteistyön muiden Pohjoismaiden ja kansainvälisten tutkimuskonsortioiden kanssa sekä edistää tiedon vaihtoa ja parhaita käytäntöjä. Lainsäädäntö tukee tätä tavoitetta ja sujuvoittaa aiheesta tehtävää jatkotutkimusta.

Seuraavien kymmenen vuoden aikana on erityisen tärkeää keskittyä alla kuvattuihin osa-alueisiin.

Panostaminen varhaiseen diagnosointiin

Tavoitteena on riskiryhmien yhä laajempi tunnistaminen sekä näyttöön perustuva seuranta ja seulonta, esimerkiksi kuvantamisseurannan kohdentaminen vain tarkoin määriteltyyn joukkoon. Diagnostiikassa hyödynnetään uutta laitetekniikkaa ja kehittyvää tekoälyä. Tekoälyn avulla voidaan parantaa kuvantamis- ja histopatologisten tutkimusten tarkkuutta ja havaitsemiskykyä.

Väestön yleinen tietoisuus on tärkeä tekijä tiettyjen huonoennusteisten syöpien ehkäisyssä. Erityisesti alkoholin, tupakoinnin, ravitsemusohjeiden ja liikunnan osalta tietoisuuden lisäämisestä voi olla hyötyä. Myös stigman vähentäminen ja tiedon lisääminen kehittyvistä hoidoista voi parantaa hoitoon hakeutumista ja pääsyä. Myös terveydenhuoltohenkilöstön jatkuva koulutus on tärkeää, jotta tutkimuksia vaativat oireet osataan tunnistaa. Lisäksi hoitoon pääsyn viiveiden minimointi edellyttää riittävää resursointia. Tulevaisuudessa verikokeet, joiden avulla voidaan tunnistaa useita eri syöpiä (multi-cancer early detection eli MCED), saattavat edistää useiden syöpätyyppien varhaista toteamista. Niiden käyttöönotto kuitenkin edellyttää, että meneillään olevat tutkimukset osoittavat niiden voivan vähentää syöpäkuolleisuutta kustannusvaikuttavasti.

Mittareita varhaisen diagnostiikan toteutumisesta ovat taudin lähtötilanteen levinneisyys, hoitoonpääsyajat, paranemiseen tähtäävästi hoidettujen osuus ja elossaolo.

Tutkimuksen ja kehityksen vahvistaminen

Syöpätutkimus on avainasemassa huonoennusteisten syöpien ennusteen parantamisessa. Muiden syöpähoitojen kehittyminen on antanut toivoa siitä, että myös huonoennusteisten syöpien varhaiseen toteamiseen ja hoitoon voitaisiin löytää tehokkaampia ratkaisuja. Tutkijalähtöiset tutkimukset ja yhteistyö lääkeyritysten kanssa laajentavat tutkimusrintamaa. Kansallisen tutkimusrahoituksen kohdentaminen huonon ennusteen syöpien tutkimukseen on tärkeää. Lainsäädännöllisten esteiden poistaminen edesauttaa liittymistä kansainvälisiin tutkimuskonsortioihin. Myös kansainvälisiin hanke- ja tutkimusrahoitushakuihin resursointi on keino tehostaa kansainvälistä tutkimusyhteistyötä. Kliinisten lääke- ja hoitotutkimusten toteuttamista sekä potilasrekrytointia edistetään riittävän henkilöstöresursoinnin ja sujuvien prosessien kautta.

Mittareita ovat saatu tutkimusrahoitus, julkaisut, hoitotutkimusten ja niihin rekrytoitujen potilaiden lukumäärä sekä alueellinen kattavuus. Huonoennusteisten syöpien kohdalla tulosten voidaan odottaa näkyvän nopeasti myös potilaiden diagnostiikassa, hoitoon pääsyssä ja elossaolossa.

Hoitoketjut ja yhteistyö

Hoitoketjun sujuvuus ja eri ammattiryhmien välinen yhteistyö vaikuttavat keskeisesti potilaan saamaan hoitoon. Moniammatillisten kokousten avulla pyritään siihen, että potilas saa parasta mahdollista ja kansallisesti tasalaatuista hoitoa. Harvinaisten huonoennusteisten syöpien hoidossa on tärkeää keskittää hoidon suunnittelu ja tietyt hoitotoimenpiteet erikoistuneisiin keskuksiin.

Laaturekisterit ovat keskeisiä hoidon laadun ja tehokkuuden seuraamisessa. Rekisterien päivitys esimerkiksi Pohjoismaiden kanssa yhteneviksi voi parantaa tiedon keruuta ja hoitotulosten vertailua.

Seurannan ja hoidon räätälöinti riskiryhmille on myös erittäin tärkeää. Esimerkiksi haimasyövässä on todettu, että ensimmäisen vuoden aikana paranemiseen tähtäävän leikkaushoidon jälkeen kolmen kuukauden välein tehty TT-tutkimus voi pidentää elossaoloaikaa jopa viidellä kuukaudella.

Myös palliatiivisen hoidon varhainen aloittaminen on olennainen osa huonoennusteisten syöpien hoitoa. Palliatiivinen hoito voi parantaa potilaan elämänlaatua ja pidentää elinaikaa. Riittävän varhain tapahtuva oireenmukaiseen hoitoon siirtyminen on potilaan etu, jolloin myös vältetään raskaat hoidot ja toimenpiteet, jotka eivät kohenna elinaikaennustetta tai elämänlaatua. Potilaan ja läheisten psykososiaalinen tuki on keskeistä läpi hoitoprosessin.

Mittareita ovat hoitoonpääsyajat, syövän levinneisyys ja hoitotuloksia kuvaavat mittarit: paranemiseen tähtäävää hoitoa saaneiden potilaiden osuus ja elossaolo. Objektiiviset mittarit mahdollistavat kansallisen ja kansainvälisen vertailun ja edistävät yhdenvertaisuutta.

Huonon ennusteen syöpiin liittyvät osatavoitteet ja toimenpiteet:

Tässä kappaleessa esitettyjen tavoitteiden toteutumista edistetään muun muassa seuraavissa osatavoitteissa ja niihin liittyvissä toimenpiteissä: *2.5 Syövät havaitaan varhaisessa vaiheessa kaikkialla terveydenhuollossa; 3.1 Kansalliset hoitosuositukset ja hoitoketjut ohjaavat yhdenvertaista, viiveetöntä ja vaikuttavaa hoitoa; 3.2 Kansallisen syövänhoidon laaturekisteri, systemaattinen tulosten tarkastelu ja vertaisarviointi tukevat vaikuttavan hoidon kehittämistä; 3.3 Kuntoutus, psykososiaalinen tuki, terveyssosiaalityö ja palliatiivinen hoito ovat vakiintunut osa syöpäpotilaan hoitoketjua ja yhdenvertaisesti saatavilla; 4.2 Vahvistuva kliininen syöpätutkimus on tiivis osa jokaisen potilaan hoitoa; 4.3 Suomi on yksilöllisen lääketieteen edelläkävijä* ja *4.5 Uusien syöpälääkkeiden arviointi ja käyttöönotto on viiveetöntä ja yhtenevää arviointitahosta riippumatta.*

Toimenpiteet tiekartalla

1. Vahvistetaan osallisuutta ja kehitetään ihmislähtöisiä palveluja

1.1 Asiakkaat, potilaat ja läheiset osallistuvat syövän ehkäisyn, hoidon ja palveluiden kehittämiseen

Toimenpide 1.1.1 Vahvistetaan asukkaiden, asiakkaiden ja potilaiden osallistumista ja osallistumismahdollisuuksia väestölle suunnattujen seulontojen, rokotusohjelmien ja muiden ennaltaehkäisevien palveluiden kehittämisessä

Seulonta- ja rokotusohjelmien sekä ennaltaehkäisevien palvelujen suunnittelussa on mukana maallikkoedustajia ja/tai kohderyhmää edustavia henkilöitä (tässä toimenpiteessä jatkossa asiakkaat ja potilaat), jotta palvelut vastaavat paremmin väestön tarpeita ja odotuksia ja ovat helposti lähestyttäviä. Osallisuuden vahvistaminen perustuu sekä kansainvälisiin suosituksiin että kotimaiseen lainsäädäntöön. Nykytilassa osallistuminen on hajanaista ja vaihtelee alueittain, minkä vuoksi tarvitaan kansallisesti yhtenäisiä toimintamalleja ja pysyviä rakenteita. Asiakkaiden ja potilaiden näkökulmien hyödyntäminen parantaa syövän ehkäisyä, seulontojen saavutettavuutta ja hoitopolkujen sujuvuutta.

Tavoitteena on, että tulevaisuudessa asiakkailla ja potilailla on vahva ja näkyvä rooli ennaltaehkäisevien palveluiden kehittämisessä. Palvelujen järjestäjät tarjoavat aktiivisesti tietoa osallistumismahdollisuuksista ja tekevät osallisuudesta osan organisaatioiden toimintakulttuuria. Kehittämistoimintaan rekrytoidaan monimuotoinen joukko osallistujia, jotka edustavat eri ikäryhmiä, sukupuolia, etnisiä ja sosioekonomisia taustoja ja maantieteellisiä alueita.

Osallisuuden vahvistaminen lisää luottamusta palveluihin ja tukee kansalaisten aktiivista osallistumista seulontoihin ja rokotusohjelmiin. Kansainväliset esimerkit osoittavat, että potilas- ja kansalaispaneelit parantavat palveluiden hyväksyttävyyttä ja kohdentumista, ja samaa lähestymistapaa vahvistetaan Suomessa.

Vastuutaho: THL, STM, hyvinvointialueet ja HUS, kunnat, järjestöt, seulontojen osalta myös FICAN ja Syöpärekisteri.

Resurssi: Arvioitu tarvittava määräraha 1 500 000 €. Rahoitusta kohdennetaan seulonnoista ja rokotusohjelmista päättävien tahojen ja asiantuntijaryhmien, kuntien ja hyvinvointialueiden henkilöstöresursseihin. Yhteiskehittämiseen aikaansa antaville maallikkoedustajille korvataan työhön käytetty aika ja matkakustannukset.

Aikataulu:
2026–2028: Luodaan yhteistyömallit asiakkaiden ja/tai potilaiden kuulemiseen seulonta- ja rokotusohjelmien suunnittelussa.
2029–2031: Asiakkaita ja/tai potilaita kuullaan suunnitelmallisesti seulonta- ja rokotusohjelmien suunnittelussa.

Mittari: Syöpäseulontojen ja syövän ehkäisyyn liittyvien rokotusohjelmien kehittämisessä mukana olevat ja moninaistuvaa yhteiskuntaa edustavat asiakkaat ja/tai potilaat (mukana olevien edustajien lukumäärä ja osuus).

Mittari: Seulontoihin osallistumisasteen parantuminen siten, että äidinkielenään muita kieliä kuin suomea ja ruotsia puhuvan väestön osallistumisaste saavuttaa suomen- ja ruotsinkielisen väestön tason.

Mittari: HPV-rokotuskattavuuden parantuminen siten, että rokotuskattavuustavoite (90 % alakoulun päättäneillä) saavutetaan jokaisella hyvinvointialueella ja Helsingissä.

Toimenpide 1.1.2 Vahvistetaan potilasedustajien osallistumista syöpäkohtaisten hoito- ja muiden suositusten sekä hoitopolkujen laatimiseen

Osatavoitteessa 3.1 käsiteltävät hoitosuositukset ovat julkisia, ja niistä tehdään potilasversiot. Sairausryhmää edustavia potilaita tai heidän läheisiään (jatkossa potilasedustajat) on mukana hoitosuositusten laatimisessa esimerkiksi Käypä hoito -suosituksissa ja Hotus-hoitosuosituksissa hyväksi havaittujen mallien mukaisesti. Lisätään potilasedustajien osallistumista alueellisten hoitopolkujen laatimiseen esimerkiksi asiakasraatien kautta.

Osallisuuden vahvistaminen on linjassa sekä kansainvälisten ohjeistusten että kotimaisen lainsäädännön kanssa, ja sen avulla voidaan kehittää sekä hoitosuosituksia että hoitopolkuja entistä ihmislähtöisemmäksi.

Potilasedustajien osallistumista terveydenhuollon suositusten laatimiseen laajennetaan, ja hoitosuositusten sekä Palkon suositusten laatimisessa kuullaan ja kehittämistyöhön kutsutaan mahdollisuuksien mukaan monimuotoinen joukko eri ikäisiä, eri taustoista ja alueilta tulevia henkilöitä. Näin edistetään yhdenvertaisuutta ja varmistetaan, että suositusten sisältö ja hoitopolut kehittyvät vastaamaan potilaiden tarpeita. Suositusten osalta tavoitteena on erityisesti, että suosituksissa käsitellään potilaille merkityksellisiä asioita ja että niissä on huomioitu potilaiden näkemyksiä ja arvoja esimerkiksi hoitojen suhteen.

Lisäksi voidaan hyödyntää kansainvälisiä esimerkkejä digitaalisista osallistumisen muodoista. Sellaisia ovat esimerkiksi virtuaaliset asiakas- ja potilasfoorumit, etäyhteydellä toteutettavat potilaiden ja ammattilaisten yhteistä ymmärrystä lisäävät keskustelutilaisuudet sekä palautekanavat, jotka mahdollistavat osallistumisen myös niille, joilla ei ole mahdollisuuksia päästä kasvokkaisiin tilaisuuksiin. Näin osallisuus ei jää

yksittäisten aktiivisten potilaiden varaan, vaan siitä tulee aidosti saavutettavaa ja laajasti edustavaa.

Vastuutaho: Hyvinvointialueet ja HUS, järjestöt, hoitosuosituksia ja muita terveydenhuollon suosituksia laativat tahot.

Resurssi: Arvioitu tarvittava määräraha 1 500 000 €. Rahoitusta kohdennetaan hoitosuosituksia ja muita terveydenhuollon suosituksia toteuttaville tahoille osallisuuden vahvistamiseen sekä suosituksia koskevien, yhtenäisten ja läpinäkyvien toimintamallien kehittämiseen (luku 3.3.1). Yhteiskehittämiseen aikaansa antaville potilasedustajille korvataan työhön käytetty aika ja matkakustannukset.

Aikataulu:
2026–2028: Kehitetään potilaiden osallistumisen malleja osana syövän hoitosuositusprosessia.
2029–2031: Potilasedustajat osallistuvat hoitosuositusten ja muiden terveydenhuollon suositusten laatimiseen tuomalla niihin potilasnäkökulmaa.

Mittari: Suosituksia valmistelevissa työryhmissä tai viiteryhmissä mukana olevat potilasedustajat (prosentuaalinen osuus suosituksista tai työryhmistä, joissa potilasedustajia).

Toimenpide 1.1.3 Syöpää hoitavat yksiköt kuvaavat osallisuuden organisaatiorakenteissa, toimintasuunnitelmissa sekä hoito- ja palveluprosesseissa

Asiakas- ja potilasosallisuus ilmenee konkreettisina toimina vastuutahojen strategioissa ja toimintasuunnitelmissa. Tällaisia toimia voivat olla esimerkiksi asiakas-, potilas- ja tutkimusraatien sekä kokemustoimijoiden selkeästi kuvatut roolit ja mahdollisuus antaa palautetta hoidosta ja palveluista. Laki hyvinvointialueesta edellyttää, että hyvinvointialueen asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa hyvinvointialueen toimintaan. Tällä hetkellä osallistuminen ei kuitenkaan toteudu systemaattisesti, ja alueelliset erot ovat merkittäviä. Siksi tarvitaan rakenteita ja kansallisia hyviä käytänteitä, jotka varmistavat, että asiakkaiden, potilaiden ja läheisten näkökulmat tulevat huomioiduiksi yhdenvertaisesti koko maassa.

Palvelu- ja hoitoprosesseja sekä kliinisiä tutkimuksia suunnitellaan ja kehitetään asiakkaiden, potilaiden ja läheisten sekä terveydenhuollon ja sosiaalihuollon ammattilaisten kanssa yhdessä. Palauteprosessit on tehty näkyviksi, palautteiden merkitys palvelujen ja hoidon kehittämiseksi on tunnustettu ja toimintaa kehitetään saadun palautteen perusteella. Palautteita käsitellään asiakas-, potilas- tai tutkimusraadeissa yhteisen kehittämisen hengessä. Kehittämisessä otetaan mallia hyviksi havaituista kansallisista ja kansainvälisistä osallisuutta vahvistavista käytännöistä sekä syövänhoidosta että muilta erikoisaloilta ja yhteiskunnan sektoreilta.

Palvelujen järjestäjät tarjoavat aktiivisesti tietoa osallistumisen mahdollisuuksista, ja osallisuuden edistäminen on kiinteä osa toimintakulttuuria. Asiakas- ja potilasosallisuuden toteutumista arvioidaan vuosittain, ja sen perusteella tehdään kehittämistyötä yhteistyössä asiakas-, potilas- ja tutkimusraatien, kokemustoimijoiden sekä järjestöjen kanssa.

Vastuutaho: Hyvinvointialueet ja HUS, järjestöt.

Resurssi: Arvioitu tarvittava määräraha 1 500 000 €. Rahoitusta kohdennetaan osallisuustoiminnasta vastaavien vastuuhenkilöiden palkkaamiseen hyvinvointialueella, sairaalassa ja järjestöissä. Yhteiskehittämiseen aikaansa antaville asiakkaille ja potilaille korvataan työhön käytetty aika ja matkakustannukset.

Aikataulu:
2026–2028: Hyvinvointialueilla ja HUSissa on syövän hoitoon liittyvä asiakas- tai potilasraati ja toiminnasta vastaava henkilö.
2029–2031: Kansallisesti hyviä toimintamalleja on kehitetty ja jaettu. Toiminta on vakiintunutta ja sitä kehitetään tarpeiden ja palautteen perusteella.

Mittari: Toiminnassa olevat syövän hoidon kehittämiseen keskittyvät asiakas-, potilas- ja tutkimusraadit (asiakas-, potilas- ja tutkimusraateja perustaan alueille, joissa niitä ei vielä ole).

Toimenpide 1.1.4 Hyvinvointialueet, HUS ja järjestöt tekevät aiempaa tiiviimpää yhteistyötä osallisuustoiminnan kehittämiseksi

Hyvinvointialueet, HUS ja järjestöt määrittelevät selkeät roolit ja tehtävät, joiden avulla tuetaan asiakas- ja potilasosallisuuden toteutumista, osallistujien rekrytointia sekä perehdytystä ja tukemista kokemustoimijana, vapaaehtoisena tai raadin jäsenenä toimimisessa. Yhteistyö hyvinvointialueiden, HUSin ja järjestöjen välillä on aktiivista ja vastavuoroista.

Vastuutaho: Hyvinvointialueet, HUS ja järjestöt

Resurssi: Arvioitu tarvittava määräraha sisältyy edelliseen toimenpiteeseen, jossa rahoitusta kohdennetaan osallisuus-, asiakasraati- ja potilasedustajatoiminnasta vastaavien vastuuhenkilöiden palkkaamiseen hyvinvointialueilla, sairaaloissa ja järjestöissä. Yhteiskehittämiseen aikaansa antaville kansalaisille ja potilaille korvataan työhön käytetty aika ja matkakustannukset.

Aikataulu:
2026–2028: Järjestösektoria kartoitettu alueellisesti ja kansallisesti, tunnistettu yhteistyömahdollisuuksia ja luotu pohjaa yhteistyölle paitsi syöpäjärjestökentän, myös muiden toimijoiden, esimerkiksi maahanmuuttajajärjestöjen kanssa.
2029–2031: Hyvinvointialueet tekevät monipuolista, kattavaa ja dynaamista yhteistyötä erilaisten sote-alan ja maahanmuuttajajärjestöjen kanssa.

1.2 Arvostava, inhimillinen ja yksilöllinen kohtaaminen tukee potilasta osallistumaan aktiivisesti omaan hoitoonsa

Toimenpide 1.2.1 Hoitosuosituksiin lisätään osio, joka tukee jaettua päätöksentekoa

Hoitopäätösten lähtökohtana ovat paitsi tutkittuun tietoon perustuvat hoitosuositukset- ja -käytännöt myös potilaan voimavarojen, tiedon tason sekä elämäntilanteen huomioiminen. Jaetun päätöksenteon tueksi lääkäri esittää riittävästi tietoa hoitovaihtoehdoista ja niiden hyödyistä ja haitoista. Jaetun päätöksenteon periaatteet koskevat myös muita syövän hoidon ammattilaisia. Potilas kertoo omista arvoistaan, toiveistaan ja elämäntilanteestaan.

Jaetun päätöksenteon ja potilaan kokonaisvaltaisen tukemisen periaatteet tehdään näkyväksi ja kiinteäksi osaksi hoitopolkua. Hoitosuositukset, joita käsitellään toimenpiteessä 3.3.1, sisältävät jaettua päätöksentekoa tukevan osion. Hoitosuosituksista tehdään potilasversiot, joissa on ymmärrettävää, tutkimukseen pohjautuvaa tietoa eri hoitovaihtoehtoista ja niiden mahdollisista hyödyistä ja haitoista.

Jaetun päätöksenteon ohjeistuksen laatimisessa hyödynnetään olemassa olevia, kansainvälisiä ja kansallisia malleja sekä ohjeistuksia. Tieto on koottu yhteen paikkaan, ja sitä tarjotaan kulttuurisensitiivisesti eri kielillä. Hoitoon liittyvät päätöksentekokriteerit, hoitovaihtoehdot sekä -suositukset ovat läpinäkyvästi tiedossa ja esillä.

Syövän hoidon ammattilaisten koulutuksessa tunnistetaan potilaan osallisuuden tukemisen ja jaetun päätöksenteon hyödyt potilaan hoidolle, hoitokokemukselle ja hoitoon sitoutumiselle. Lääkäreitä ja muita terveydenhuollon ammattilaisia koulutetaan jaetun päätöksenteon menetelmistä.

Vastuutaho: FICAN, hyvinvointialueet ja HUS, lisäksi muut hoitosuosituksia laativat tahot ja oppilaitokset sekä järjestöt.

Resurssi: Arvioitu tarvittava määräraha sisältyy toimenpiteeseen 1.1.2 (1 500 000 €). Rahoitusta kohdennetaan hoitosuosituksia toteuttaville tahoille osallisuuden vahvistamiseen sekä suosituksia koskevien toimintamallien kehittämiseen (osatavoite 3.1) ja toteutukseen (kieliversiot mukaan lukien). Yhteiskehittämiseen aikaansa antaville kansalaisille ja potilaille korvataan työhön käytetty aika ja matkakustannukset.

Aikataulu:
2026–2028: Kehitetään jaetun päätöksenteon mallia osana syövän hoitosuositusprosessia.
2029–2031: Jaetun päätöksenteon ohjeistus on vakiintunut osa hoitosuosituksia. Hoitosuosituksista tehdään potilasversiot.

Mittari: Hoitosuosituksiin lisätään osio jaetusta päätöksenteosta (prosentuaalinen osuus syövän hoitosuosituksista, joissa osio jaetusta päätöksenteosta).

Mittari: Hoitosuositukset ovat julkisia (prosentuaalinen osuus syövän hoitosuosituksista, jotka ovat julkisia).

Toimenpide 1.2.2 Otetaan käyttöön olemassa olevat mittarit, jotka mittaavat potilaan kokemusta omaan hoitoonsa osallistumisesta

Potilaiden kokemusta hoidosta ja omaan hoitoonsa osallistumisesta mitataan systemaattisesti. Potilaan osallistuminen omaan hoitoonsa edellyttää, että vastaanottokäynnille on varattu riittävästi aikaa ja että tarvittavat tiedot ovat niin potilaan kuin lääkärinkin (ja tarvittaessa myös läheisten) saatavilla. Tapaamisissa potilasta kannustetaan kertomaan hoidon sujumisesta ja esimerkiksi mahdollisista lääkehoitojen haittavaikutuksista. Luottamuksellinen ilmapiiri tukee potilaan voimaantumista, rohkaisee jakamaan tietoa ja edistää osallistumista hoitoa koskevaan päätöksentekoon. Yhteydenpitoa voidaan tiivistää digitaalisten sovellusten ja vointikyselyjen avulla. Hoitavat tahot varmistavat, että niiden tekniset valmiudet mahdollistavat digitaalisten sovellusten käytön osana tarjottua kokonaisvaltaista hoitoa. Toimintaa kehitetään potilailta ja läheisiltä saadun palautteen ja kerätyn tiedon perusteella.

Vastuutaho: Hyvinvointialueet ja HUS, syöpäpotilaita hoitavat yksiköt.

Resurssi: Olemassa olevat resurssit syöpään sairastuneita hoitavissa yksiköissä.

Aikataulu:
2026–2028: Potilaiden kokemusta hoidosta (Net Promoter Score eli NPS) ja hoitoon osallistumisesta (Hoitotyön potilaspalaute eli HoPP) mitataan yhtenäisesti.
2029–2031: Potilastyytyväisyyskyselyiden (NPS) tulokset julkaistaan avoimesti.

Mittari: Potilaiden kokemus hoidosta (NPS, HoPP) syöpää hoitavissa yksiköissä (kokemuksia kerätään ja raportoidaan kaikissa yksiköissä, NPS-luku yli 80 ja HoPP-tulokset yli 4,7).

Toimenpide 1.2.3 Luodaan toimintamalli ja ohjeistus syövän hoidon koordinaatiosta vastaavan, nimetyn työntekijän mallista

Selvitetään olemassa olevia syövän hoidon koordinaation malleja sekä niiden vaikuttavuutta, ja laaditaan selvityksen pohjalta ohjeistus syövän hoidon koordinaation toimintamalleista (esimerkiksi vastaavan nimetyn työntekijän mallista tai omatiimimallista). Selvityksessä kartoitetaan, missä hoidon vaiheessa ja mille potilasryhmille hoidon koordinaatiosta vastaava työntekijä olisi tärkeintä kohdentaa.

Nimetty työntekijä tai tiimi vahvistaa potilaan edellytyksiä osallistua omaan hoitoonsa. Potilaalle nimetyn ammattilaisen rooli riippuu ammattinimikkeestä ja sen tuomista vastuista. Tärkeintä on että potilas tietää, kenellä on kokonaiskuva hänen hoidostaan, ja miten hän voi tarpeen mukaan olla yhteydessä hoitavaan yksikköön. Hoidon koordinaatiossa voidaan hyödyntää myös digitaalisia hoitopolkuja ja -kanavia.

Nimetty työntekijä tai tiimin jäsen tunnistaa potilaan yksilölliset tuen tarpeet (psykologinen tai psykososiaalinen tuki, terveyssosiaalityön tai kuntoutusohjauksen tarve, ravitsemus, liikunta, seksuaalineuvonta, taloudelliset asiat) hoitojen aikana sekä kuntoutuksessa ja koordinoi niiden sekä omahoidon tuen toteutumista. Nimetty työntekijä toimii potilaalle yhteytenä sairaanhoitoon ja vastaa hoitoon liittyvän kommunikaation johdonmukaisuudesta ja jatkuvuudesta.

Nimetty työntekijä, tuttu tiimi ja pitkäaikaiset hoitosuhteet tukevat osallisuuden toteutumista ja potilaan luottamusta sekä sitoutumista hoitoon. Osallisuutta tukevalla hoitopolulla potilas on mukana oman hoito- ja kuntoutussuunnitelmansa laatimisessa, tuntee sen sisällön ja on sitoutunut siihen. Lisäksi potilas tuntee omahoidon mahdollisuudet ja merkityksen hyvinvoinnin tukena ja on motivoitunut omahoitoon.

Toimenpiteen toteutuksessa huomioidaan STM:n koordinoiman perusterveydenhuollon omalääkäriohjelman ja hoidon jatkuvuusmallien kehittämisestä saatuja kokemuksia[25].

Vastuutaho: FICAN (ohjeistuksen laatiminen), hyvinvointialueet ja HUS.

Resurssi: Arvioitu tarvittava määräraha 100 000 €. Rahoitusta kohdennetaan ohjeistuksen laatimiseen.

Aikataulu:
2026–2028: Ohjeistus syövän hoidon koordinaatiosta vastaavan nimetyn lääkärin, hoitajan tai erityistyöntekijän mallista.
2029–2031: Hyvinvointialueet ovat ottaneet tämän ohjeistuksen käyttöön.

Mittari: Syövän hoidon koordinaatiosta vastaavan, nimetyn työntekijän toimintamallin käyttö hyvinvointialueilla ja HUSissa.

25 Omalääkäriohjelma: Tavoitteena parempi hoidon saatavuus ja jatkuvuus. Sosiaali- ja terveysministeriö

Mittari: Potilaiden kokemus hoidosta (NPS, HoPP) syöpää hoitavissa yksiköissä (kokemuksia kerätään ja raportoidaan kaikissa yksiköissä, NPS-luku yli 80 ja HoPP-tulokset yli 4,7).

1.3 Selkeä ja saavutettava terveysviestintä sekä terveyslukutaidon tukeminen edistävät syövän ehkäisyä, varhaista toteamista ja hoidon vaikuttavuutta

Toimenpide 1.3.1 Parannetaan eri kieliryhmiin kuuluvien väestöryhmien osallistumista rokotuksiin sekä syöpäseulontoihin kohdennetun ja yhteisölähtöisen viestinnän avulla

Hyödynnetään olemassa olevia materiaaleja ja tuotetaan yhteistyössä monikielistä, selkokielistä ja kulttuurisesti sensitiivistä materiaalia (kuten esitteitä, videoita ja sosiaalisen median sisältöjä), jotka korostavat seulontojen ja HPV-rokotusten tärkeyttä ja niihin liittyviä käytäntöjä eri kieliryhmille. Lisäksi kehitetään toimintamalleja kohdennetun viestinnän toteuttamiseksi yhteistyössä kieli- ja kulttuurivähemmistöjen ja vammaisjärjestöjen sekä jo nyt maahanmuuttajataustaisten ihmisten parissa terveydenedistämistyötä tekevien sote-järjestöjen kanssa. Yhteistyö eri kieli- ja kulttuurivähemmistöjen kanssa on keskeistä, sillä se auttaa tavoittamaan juuri ne ryhmät, jotka usein jäävät viestinnän ulkopuolelle. Ammattikorkeakoulut voivat osaltaan toimia viestintäkäytäntöjen kehittäjinä ja pilotointiympäristöinä yhteistyössä hyvinvointialueiden ja järjestöjen kanssa.

Vastuutaho: Hyvinvointialueet, Helsingin kaupunki ja HUS, järjestöt, Syöpärekisteri, THL.

Resurssi: Arvioitu tarvittava määräraha 400 000 €. Rahoitusta kohdennetaan järjestöille sekä hyvinvointialueille, Helsingin kaupungille ja HUSille, jotka tekevät terveydenedistämistyötä eri kieli- ja kulttuurivähemmistöjen sekä vammaisjärjestöjen kanssa.

Aikataulu:
2026–2028: Kohderyhmän kanssa jo yhteiskehitettyjä viestintämateriaaleja seulonnoista ja rokotuksista hyödynnetään ja uutta materiaalia tuotetaan tarpeen mukaan eri kielillä.
2029–2031: Terveydenedistämistyö julkisen sektorin ja eri kieli- ja kulttuurivähemmistöjä edustavien järjestöjen kanssa on vakiintunutta.

Mittari: Seulontoihin osallistumisasteen parantuminen siten, että äidinkielenään muita kieliä kuin suomea ja ruotsia puhuvan väestön osallistumisaste saavuttaa suomen- ja ruotsinkielisen väestön tason.

Mittari: HPV-rokotuskattavuuden parantuminen siten, että rokotuskattavuustavoite (90 % alakoulun päättäneillä) saavutetaan jokaisella hyvinvointialueella ja Helsingissä.

Toimenpide 1.3.2 Edistetään varhaista hoitoon hakeutumista kansallisella viestintäsuunnitelmalla, joka keskittyy lisäämään tietoisuutta syöpien oireista

Laaditaan ja toteutetaan kansallinen syöpien oiretietoisuutta lisäävä viestintäsuunnitelma. Suunnitelman laatimisessa hyödynnetään hyviä esimerkkejä muista maista ja strategioista (esimerkiksi Isossa-Britanniassa toteutettu Be Clear on Cancer -kampanja[26], jossa kohderyhmänä olivat erityisesti ne sosioekonomiset ryhmät, joiden hoitoon hakeutumisessa tai pääsyssä oli havaittu viiveitä). Suunnitelmaa toteutetaan monikanavaisesti eri toimijoiden (Syöpäjärjestöt, FICAN, THL) välisessä yhteistyössä perinteistä mediaa, sosiaalista mediaa ja verkkosivuja hyödyntäen. Myös ammattikorkeakoulut voivat toimia viestintäkäytäntöjen kehittäjinä ja pilotointiympäristöinä yhteistyössä hyvinvointialueiden ja järjestöjen kanssa. Keskeisiä viestejä ovat tietoisuus mahdollisesti syöpään viittaavista oireista sekä se, miten näitä oireita havainneiden tulisi hakeutua arvioitavaksi. Kokemusasiantuntijoita hyödynnetään syöpään liittyvän stigman vähentämisessä ja luottamuksen rakentamisessa. Terveyslukutaidon kehittäminen on olennaista myös hoidon onnistumisen, hoitoon sitoutumisen ja jaetun päätöksenteon kannalta. Viiveetön pääsy perusterveydenhuoltoon tukee varhaista hoitoon hakeutumista.

Vastuutaho: FICAN, hyvinvointialueet, HUS ja Helsingin kaupunki (varhainen hoitoon pääsy), Syöpäjärjestöt, lisäksi muut sote-alan järjestöt, THL ja ammattikorkeakoulut.

Resurssi: Arvioitu tarvittava määräraha 400 000 €. Rahoitusta kohdennetaan vastuutahoille asiantuntija- ja viestintäresursseihin kansallisen viestintäkampanjan toteuttamiseksi.

Aikataulu:
2026–2028: Viestintästrategian suunnitelma valmisteltu yhteistyössä vastuutahojen kanssa.
2029–2031: Viestintästrategia valmis ja pilotoitu kansallisesti.

Mittari: Syövistä 70 % diagnosoidaan luokissa I–II vuoteen 2035 mennessä.

26 Cancer Research UK. Be Clear on Cancer.

Toimenpide 1.3.3 Vahvistetaan palliatiivisen hoidon tunnettuutta ja myönteistä asenneilmapiiriä selkeällä ja yhdenmukaisella viestinnällä

Palliatiivinen hoito parantaa elämänlaatua ja tarjoaa merkittävää tukea potilaille ja heidän läheisilleen. Tietoisuutta palliatiivisen hoidon myönteisistä vaikutuksista ja asemasta osana syövän hoidon kokonaisuutta tulee lisätä, jotta ammattilaiset osaavat tarjota sekä potilaat ja heidän perheensä myös paremmin pyytää hoitoa ja hyödyntää sen tarjoamia mahdollisuuksia. Kolmannen sektorin palveluilla ja toiminnalla voidaan täydentää julkisia palveluja ja parantaa esimerkiksi ikääntyneiden ja heidän läheistensä psykososiaalisen tuen yhdenvertaista saatavuutta.

Suunnitellaan ja organisoidaan viestinnälliset toimenpiteet, joilla välitetään tietoa ja vaikutetaan kansalaisten ja terveydenhuollon ammattilaisten asenteisiin palliatiivisen hoidosta sekä lisätään ymmärrystä sen hyödyistä syöpäpotilaille hoidon eri vaiheissa. Toteutetaan viestintää kohdennetusti, systemaattisesti ja monikanavaisesti mahdollisimman hyvän vaikuttavuuden saavuttamiseksi, ja tuotetaan potilasohjaukseen yhdenmukaista materiaalia palliatiivisesta hoidosta ja sen puheeksi ottamisesta.

Vastuutaho: Syöpäjärjestöt sekä potilas- ja omaisjärjestöt, palliatiivisen hoidon asiantuntijajärjestöt, HUS ja hyvinvointialueet, lisäksi THL.

Resurssi: Arvioitu tarvittava määräraha 400 000 €. Rahoitusta kohdennetaan asiantuntijaresursseihin, materiaali- ja järjestämiskuluihin toimenpidettä toteuttaville tahoille.

Aikataulu:
2026–2028: Viestintästrategia valmis ja pilotoitu alueellisesti.
2029–2031: Viestintätoimet laajentuneet valtakunnalliseksi.

2. Vähennetään syöpätaakkaa ehkäisyn ja varhaisen toteamisen avulla

2.1 Syövän riskitekijöitä vähennetään ja suojaavia tekijöitä vahvistetaan yhteiskuntapoliittisin keinoin

Toimenpide 2.1.1 Sisällytetään kattava syövän ehkäisyä tukeva terveys- ja terveyserovaikutusten arviointi säädös- ja budjettiesityksiin

Vahvistetaan Terveys kaikissa politiikoissa -ajattelua valtioneuvoston kaikessa säädös-, ohjelma- ja budjettivalmistelussa. Lisäksi vahvistetaan arkiliikuntaan rohkaisevaan yhdyskuntarakenteeseen vaikuttavien kaavoitus- ja liikennesuunnitteluesitysten valmistelua siten, että esitykset sisältävät nykyistä tarkemmat ja laajemmat terveys- ja terveyserovaikutusten arvioinnit, erityisesti syöpään vaikuttavat tekijät mukaan

lukien. Selvitetään vaikutusarviointien hyvinvointi- ja terveysvaikutuksia käsittelevien osuuksien nykykattavuus, tarve kapasiteetin vahvistamiseen, tehdään tarvittavat vahvistamistoimet ja seurataan terveys- ja terveyserovaikutusarviointien kehitystä ja vaikutusarviointien hyödyntämistä päätöksenteossa. Vaikutustenarvioissa tulee huomioida erityisryhmät kuten ikääntyneet, lapset ja nuoret, sekä sosioekonomiset ja alueelliset erot.

Vastuutaho: Valtioneuvoston kanslia (VNK), ministeriöt (erityisesti STM, oikeusministeriö (OM) lainvalmistelun ohjeistusten osalta) ja kunnat. Synergia: Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen 2030 -periaatepäätös[27]*.

Resurssi: Virkatyönä THL:ssa, ministeriöissä ja kunnissa.

Aikataulu:
2026–2028: Ajantasainen tieto säädösvaikutusten ja budjettiesitysten terveys- ja terveyseroarvioinnista on koottu ja asetettu lähtötasoksi. Ministeriöiden vaikutusarviointiosaamisen vahvistamistarve selvitetty.
2029–2031: Vaikutusarviointien osaamista vahvistettu. Terveys- ja terveyserovaikutuksen arviointi on lähtötasoa kattavampaa ja vaikuttaa päätöksiin.

Toimenpide 2.1.2 Laajennetaan terveysperusteista verotusta

Ulotetaan puolivuosittaiset veronkorotukset tupakkatuotteiden lisäksi kaikkiin nikotiini- ja alkoholituotteisiin. Laajennetaan terveysperustaista verotusta korottamalla runsaasti kovaa rasvaa, suolaa ja sokeria sisältävien tuotteiden verotusta aloittaen laajasta sokeriverotuksesta. Alennetaan samanaikaisesti terveyttä edistävien elintarvikkeiden kuten kasvisten, marjojen ja hedelmien sekä täysjyväviljavalmisteiden verotusta.

Vastuutaho: Valtiovarainministeriö (VM), STM.

Resurssi: Virkatyönä ministeriöissä.

Aikataulu:
2026–2028: Tupakka- ja nikotiinituotteiden verotusta korotetaan puolivuosittain. Alkoholin verotusta on kiristetty. Elintarvikkeiden terveysperusteista verotusta varten on perustettu valmistelutyöryhmä, jonka tehtävänä on mallintaa laaja-alaisen terveysperustaisen verotuksen pohjaa.
2029–2031: Alkoholin verotusta korotetaan vuosittain. Työryhmä on antanut raportin elintarvikkeiden terveysperusteisesta verotuksesta ja veropäätökset on valmisteltu.

27 Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen 2030
Valtioneuvoston periaatepäätös. Valtioneuvoston julkaisuja 2021:14.

Mittari: Tupakka- ja nikotiinituotteiden verotuksen nosto puolivuosittain ja alkoholituotteiden verotuksen nosto vuosittain, tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttö loppuu lainsäädännössä asetetun tavoitteen mukaisesti.

Toimenpide 2.1.3 Suunnitellaan ja toteutetaan kansallinen ravitsemuksen ja liikunnan toimintaohjelma yhteistyössä keskeisten toimijoiden kanssa

Valmistelun pohjaksi arvioidaan kansallisen lihavuusohjelman[28] (2012–2015, jatkettu 2016–2018[29]) saavutukset ja toimeenpanon haasteet. Ohjelma valmistellaan siten, että keskeiset toimijat sitoutuvat tavoitteisiin ja toimeenpanoon. Ohjelmassa edistetään terveellisiä elintarvikevalintoja mm. kehittämällä informatiivisia pakkausmerkintöjä, vahvistamalla ruokapalveluiden ravitsemuksellista laatua sekä rajoittamalla epäterveellisten elintarvikkeiden markkinointia erityisesti lapsille, myös sosiaalisessa mediassa. Lisäksi edistetään terveyttä edistävien tuotteiden saatavuutta ja sijoittelua myyntipisteissä.

Liikunnan osalta parannetaan mahdollisuuksia arkiliikuntaan myös kaavoituksen ja liikennesuunnittelun keinoin sekä vahvistetaan kuntien liikuntatoimien, liikuntajärjestöjen ja hyvinvointialueiden yhteistyötä ja ennaltaehkäisevää liikuntaneuvontaa. Mahdollistetaan liikuntaharrastus erityisesti lapsille, nuorille, työttömille ja maahanmuuttajille.

Vastuutaho: STM, maa- ja metsätalousministeriö (MMM), opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM), valtion liikuntaneuvosto, liikuntajärjestöt, lisäksi valtion ravitsemusneuvottelukunta, kunnat, työpaikat, elintarviketeollisuus. Synergia: Terveydeksi-ohjelma[30] ja lapsistrategia[31], Suomi liikkeelle -ohjelma[32].

Resurssi: Arvioitu tarvittava määräraha 1 000 000 €.

Aikataulu:
2026–2028: Toimintaohjelma on uudistettu, ja keskeiset toimijat on sitoutettu sen toimeenpanoon. Ravitsemussuositukset on otettu käyttöön kattavasti. Markkinointirajoitusten toteutuminen on arvioitu, ja mahdolliset lisätoimet identifioitu. Yhteistyörakenteet liikunnan edistämiseksi on luotu.
2029–2031: Toimintaohjelmaa toteutetaan suunnitelmien mukaisesti, elintarvikkeiden uudet pakkausmerkintäkäytännöt on otettu käyttöön, ja liikuntaharrastuksen saavutettavuus lapsille, nuorille, työttömille ja maahanmuuttajille on parantunut.

Mittari: Ylipaino ja lihavuus eivät enää yleisty väestössä.

28 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Lihavuus laskuun - Hyvinvointia ravinnosta ja liikunnasta - Kansallinen lihavuusohjelma 2012-2015. Ohjaus 13/2013.
29 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Lihavuus laskuun – Hyvinvointia ravinnosta ja liikunnasta Kansallinen lihavuusohjelma. Toiminta- ja toimeenpanosuunnitelma 2016–2018. TYÖPAPERI 18/2016
30 Sosiaali- ja terveysministeriö. Terveydeksi – kansallinen terveys- ja hyvinvointiohjelma 2024-2027.
31 Sosiaali- ja terveysministeriö. Kansallinen lapsistrategia.
32 Opetus- ja kulttuuriministeriö. Suomi liikkeelle -ohjelma.

Toimenpide 2.1.4 Asetetaan hallituskausittain tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittämistyöryhmä vahvistamaan tupakka- ja nikotiinituotteiden sääntelyä

Turvataan toimenpiteiden kattavuus ja vaikuttavuus asiantuntijoista koostuvan laaja-alaisen tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittämistyöryhmän avulla. Työryhmä asetetaan joka neljäs vuosi niin, että ehdotuksia on mahdollista integroida laadittavaan hallitusohjelmaan. Erityistä huomiota kiinnitetään nuorten suojaamiseen uusilta tuotteilta.

Vastuutaho: STM

Resurssi: Toteutus virkatyönä ministeriössä.

Aikataulu:
2026–2028: Tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittämistyöryhmä on antanut raporttinsa.
2029–2031: Uusi tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittämistyöryhmä on asetettu ja antanut raporttinsa.

Mittari: Kehittämistyöryhmä asetettu hallituskausittain

Toimenpide 2.1.5 Varmistetaan sosiaali- ja terveyspoliittisten näkökulmien huomiointi alkoholipolitiikassa ja säädetään alkoholituotteiden tuotemerkinnöistä

Arvioidaan päihde- ja riippuvuusstrategian (2021–2030) toteutumisen nykytila toimeenpanokauden puolivälissä, ja varmistetaan sen alkoholipolitiikan osuuksien toteutuminen. Varmistetaan sosiaali- ja terveyspolitiikkapohjaisen alkoholipolitiikan suuntaviivat antava tutkimuspohja, seuranta ja raportointi resursoimalla THL:n alkoholitutkimusta. Resursoidaan THL:n ehkäisevän päihdetyön ohjelmaa riittävästi.

Täsmennetään alkoholin tuotemerkintöjä niin, että ne sisältävät tuoteselosteen, alkoholin syöpävaroituksen ja kaloripitoisuuden. Edistetään tätä tavoitetta myös EU:ssa osana EU:n syöväntorjuntasuunnitelman toimeenpanoa. Vahvistetaan alkoholiin liittyviä syöpäriskejä koskevaa viestintää.

Vastuutaho: Arviointi, tutkimus ja tuotemerkintöjen edistäminen: STM, THL, VM; kansalaisviestintä alkoholin syöpäriskistä: Syöpäjärjestöt ja päihdejärjestöt. Synergia: Päihde- ja riippuvuusstrategia[33], Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma[34].

33 Sosiaali- ja terveysministeriö. Päihde- ja riippuvuustrategia. Yhteiset suuntaviivat vuoteen 2030. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2021:17.
34 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma vuosille 2026-2035. THL - Ohjaus 6/2026.

Resurssi: Arvioitu tarvittava määräraha 1 100 000 €, josta viestintäkampanja 100 000 €.

Aikataulu:
2026–2028: Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelman sisällöt on uudistettu, ja sen toteuttamiseen tarvittavat resurssit varmistettu. Alkoholin tuotemerkintöjen parantaminen etenee kansallisesti. Suomi tukee aktiivisesti EU:n syöväntorjuntasuunnitelman tavoitetta alkoholin tuotemerkintöjen parantamiseksi.
2029–2031: Päihde- ja riippuvuusstrategiaa ja uudistettua ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelmaa toteutetaan laaja-alaisesti. Alkoholin tuotemerkinnät on toteutettu kansallisesti.

Mittari: Alkoholin kokonaiskulutus laskee edelleen 2,5 % vuodessa, alkoholijuomien tuotemerkinnöissä on maininta kalorimäärästä ja varoitus alkoholiin liittyvästä syöpäriskistä.

Toimenpide 2.1.6 Parannetaan UV-säteilyltä ja radonilta suojautumista

UV-suojautumisen osalta on keskeistä, että liikuntaväylillä, harrastus- ja ulkoilupaikoilla sekä puistoissa ja pihoilla (erityisesti päiväkodit ja koulut) on riittävästi varjoja. Kaavoittajien, suunnittelijoiden ja rakentajien tulee työssään huomioida UV-suojautumisen turvaaminen lisäämällä varjopaikkoja erityisesti lasten ja nuorten käyttämille ulkoilualueille, kuten varhaiskasvatuksen ja koulujen pihoille, leikkipuistoihin sekä urheilukentille. Varjopaikkojen luominen luontoelementtien avulla lisää myös luontoaltistusta ja vähentää helteen muitakin terveyshaittoja, mikä on tärkeää myös ilmastonmuutokseen sopeutumisessa. Varmistetaan näiden toimijoiden UV-tietoisuus tiedotuskampanjoin. Viestitään kansalaisille UV-säteilyn haitoista ja suojautumiskeinoista erityisesti riskiryhmät huomioiden. Auringon UV-säteilyn työperäiset riskit huomioidaan nykyistä paremmin lisäämällä työnantajien ja työntekijöiden tietoisuutta ja kehittämällä työpaikkojen riskiarviointia niin, että auringon UV-säteily sisältyy arvioitaviin riskeihin.

Varmistetaan, että kaikissa suomalaisissa pientaloissa sekä kerros- ja luhtitalojen ensimmäisten kerrosten asunnoissa tehdään radonpitoisuuden mittaukset ja että radonaltistusta ehkäistään rakennuspaikan valinnalla ja rakennusteknisin toimin rakennuksen rakennusvaiheessa.

Toteutetaan osana keväällä 2026 julkaistua kansallista kansallista ohjelmaa UV-säteilyn aiheuttamien ihosyöpien vähentämiseksi[35] ja kansallista toimintasuunnitelmaa radonriskien ehkäisemiseksi[36].

35 A. Höytö. Kansallinen ohjelma UV-säteilyn aiheuttamien ihosyöpien vähentämiseksi 2026–2030. Säteilyturvakeskus, 2026.
36 Sosiaali- ja terveysministeriö. Kansallinen toimintasuunnitelma radonista aiheutuvien riskien ehkäisemiseksi – päivitys (KATORRE2). Raportti 2.12.2025.

Vastuutaho: Säteilyturvakeskus (STUK), Syöpäjärjestöt, viranomaisten radon-työryhmä (toimijat STUKin lisäksi: Lupa- ja valvontavirasto (LVV), Kuntaliitto, STM, ympäristöministeriö (YM), Rakennustarkastusyhdistys Ry), THL (ympäristöterveys). Synergiat: kansallinen ohjelma UV-säteilyn aiheuttamien ihosyöpien vähentämiseksi ja kansallinen toimintasuunnitelma radonriskien ehkäisemiseksi.

Resurssi: UV-säteilyyn ja radoniin liittyvät tiedotus- ja vaikuttamiskampanjat yhteensä 310 000 €, Väestön tietämystä mittaavat tutkimukset 2026–2032: 70 000 €.

Aikataulu:
2026–2028: Kansallista ohjelmaa UV-säteilyn aiheuttamien ihosyöpien vähentämiseksi on alettu toteuttaa. Kansallista toimintasuunnitelmaa radonriskien ehkäisemiseksi on toteutettu vuodesta 2020 alkaen ja toteutus jatkuu. Viestintäkampanjoita UV-säteilyltä suojautumiseksi sekä radonpitoisuuksien mittaamisesta on toteutettu. Työpaikkojen radonvalvontaa on toteutettu.
2029–2031: Työnantajia velvoittava UV-säteilyä koskeva ohjeistus on toteutettu ja auringon UV-säteily on sisällytetty työnantajien riskiarvioihin. Kotitalouksia radon-mittauksista muistuttava viestintäkampanja toteutettu. Kansallinen toimintasuunnitelma radonriskien ehkäisemiseksi on päivitetty.

Mittari: Tiedotuskampanjat UV-säteilyn ja radonin vaikutuksista toteutettu.

Toimenpide 2.1.7 Otetaan työperäisen syövän torjunta osaksi valtakunnallista työsuojelustrategiaa

Työpaikoille, työsuojeluorganisaatioille ja työterveyshuollon toimijoille tiedotetaan ja heitä koulutetaan työperäisen syövän torjunnasta. Työsuojeluviranomaisen valvonta-toimintaa kohdennetaan työpaikoille, joissa altistutaan syöpävaarallisille aineille. ASA (ammatissaan syöpävaarallisille aineille altistuneiden) -rekisteri-ilmoitusten katta-vuuden parantamiseen panostetaan lähettämällä altistusta sisältäville työpaikoille muistutteet ASA-ilmoitusvelvollisuudesta. Alihankkijoilta ja vuokrafirmoilta edellyte-tään työntekijöiden ASA-rekisteröintiä ennen sopimusta.

Vastuutaho: STM, LVV ja Työterveyslaitos (TTL).

Resurssi: Virkatyönä Lupa- ja valvontavirastossa ja Työterveyslaitoksessa (ohjeistus, koulutus).

Aikataulu:
2026–2028: Tiedotusta työpaikoille, työsuojeluorganisaatioille ja työterveyshuollolle on tehostettu. Muistutteet ASA-rekisteristä on lähetetty. Työpaikkojen valvontatoimia on tehostettu.
2029–2031: Työperäisen syövän torjunta on osa valtakunnallista työsuojelustrategiaa.

Mittari: ASA-rekisteriin ilmoitettujen työntekijöiden määrä.

Toimenpide 2.1.8 Varmistetaan keskeisten toimijoiden mahdollisuus kehittää ja jalkauttaa lasten ja nuorten elinympäristöjen terveyttä edistäviä toimintamalleja

Arjen toimintaympäristöjen tulee tukea lasten ja nuorten terveyttä. Vahvistetaan oppilaitosten terveyttä tukevia rakenteita ja toimintatapoja. Oppiaineiden (mm. kotitalous, liikunta, terveystieto) lisäksi oppilaitosympäristön tulee tukea terveellisiä elintapoja (ml. päihteettömyys, liikkuminen, terveystieto). Tuetaan päihteettömyyttä (tupakka- ja nikotiinituotteet ja alkoholi) vahvistavien toimintamallien käyttöönottoa oppilaitoksissa ja vapaa-ajan toiminnassa.

Opiskelun ja työn ulkopuolella olevien sekä oppilaitoksessa pysymiseen tukea tarvitsevien nuorten toimintakykyä vahvistetaan terveyttä edistävällä elintapaohjauksella. Ravitsemukseen, liikkumiseen ja päihteettömyyteen liittyviä elämänhallintaa tukevia malleja levitetään ja kehitetään osaksi mm. etsivää nuorisotyötä, työpajatoimintaa ja oppilaitosten tutkintoon valmistavaa koulutusta (TUVA).

Vastuutaho: Syöpäjärjestöt (kehittämistyö ja toimintamallien jalkauttaminen), yhteistyö muiden kansanterveys- ja päihdejärjestöjen, OKM:n (etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta), opetushallituksen (OPH), STM:n, kuntien ja oppilaitosten kanssa. Synergiat: Hyvinvoinnin, terveellisyyden ja turvallisuuden edistäminen 2030 -periaatepäätös[37], OPH:n strategia 2024–2027, Terveydeksi-ohjelma[38], kuntien hyvinvointisuunnitelmat.

Resurssi: Arvioitu tarvittava määräraha 1 000 000 €. Rahoitusta kohdennetaan päihteetön oppilaitos ja vapaa-aika -mallien jatkokehittämiseen ja levittämiseen sekä terveyttä (liikunta, ravitsemus, päihteet) edistävien toimintamallien jatkokehittämiseen ja levittämiseen.

Aikataulu:
2026–2028: Päihteettömyyttä edistäviä toimintamalleja on kehitetty edelleen ja levitetty oppilaitoksiin, laajemmin vapaa-ajan ympäristöihin sopiva toimintamalli on kehitetty. Toimintakykyä ja terveellisiä elintapoja edistäviä toimintamalleja on kehitetty edelleen ja levitetty etsivän nuorisotyön, työpajatoiminnan ja tutkintokoulutukseen valmentevan TUVA-toiminnan käyttöön.
2029–2031: Päihteetön oppilaitos -toimintamallien levittäminen kansallisesti jatkuu. Nuorisotyön elintapaohjausmallin levittäminen jatkuu, ja malli omaksutaan osaksi kuntien nuorisotyötä ja oppilaiden tukimalleja oppilaitoksissa.

37 Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen 2030 periaatepäätös. Valtioneuvoston julkaisuja 2021:14.
38 Sosiaali- ja terveysministeriö. Terveydeksi – kansallinen terveys- ja hyvinvointiohjelma 2024-2027.

Mittari: Toteutumista voidaan mitata toimintamallin käyttöön ottaneiden oppilaitosten ja vapaa-ajan toimijoiden lukumäärällä sekä elintapoja tukevien mallien käytön yleisyydellä (kuntien ja oppilaitosten lukumäärät).

2.2 Syöpää ehkäistään hyvinvointialueilla ja lähipalveluissa

Toimenpide 2.2.1 Selvitetään ennaltaehkäisyn painoarvon kasvattamista edelleen hyvinvointialueiden rahoituksessa

Ehkäiseviä sote-palveluita ja terveitä elintapoja tukevia toimintamalleja ei priorisoida hyvinvointialueilla nykyisellään riittävästi. Ehkäisevien palveluiden painoarvoa onkin esitetty lisättäväksi, mutta niiden riittävää resursointia on syytä seurata.

Selvitetään ehkäisevien palveluiden – erityisesti ravitsemukseen, liikuntaan ja päihteisiin liittyvän elintapaohjauksen – saatavuuden ja siihen liittyvien resurssitarpeiden ja toimintamallien toteutuminen sekä tietopohjan kattavuus vuonna 2027. Selvitetään, riittävätkö hyvinvointialueiden rahoituksen määräytymisperusteet ja rahoituslaki kannustamaan ennaltaehkäisevien palvelujen vahvistamista, sekä tehdään ehdotukset mahdollisesti tarvittavista muutoksista.

Vastuutaho: STM, VM, THL, hyvinvointialueet ja Helsingin kaupunki.

Resurssi: Toteutetaan virkatyönä ministeriöissä ja THL:ssä.

Aikataulu:
2026–2028: Laadittu selvitys ehkäisevien palveluiden nykytilasta ja resurssitarpeista. Laadittu selvitys ja ehdotukset hyvinvointialueiden rahoituksen määräytymisperusteisiin tarvittavien muutosten osalta. Selvitysten mukaisten ehdotusten toimeenpano käynnistynyt.
2029–2031: Ehdotusten toimeenpano toteutettu ja seuranta käynnistetty.

Mittari: Ehkäisevien palvelujen rahoitus hyvinvointialueilla.

Toimenpide 2.2.2 Varmistetaan kansallisten syöpää ehkäisevien toimintamallien käyttö muun muassa päihteiden, ravitsemuksen ja liikunnan osalta

Toimenpiteen tavoitteena on turvata oikea-aikainen pääsy nikotiini- ja alkoholivieroitukseen sekä ravitsemus- ja liikuntaohjaukseen näitä palveluja tarvitseville eri sosioekonomisissa ryhmissä. Toiminnassa hyödynnetään olemassa olevia toimintamalleja, joita yhtenäistetään kansallisesti. Toiminta- ja palvelumallit otetaan käyttöön osana alueellisia palvelu- ja hoitoketjuja Käypä hoito -suositukset, Hotus-hoitosuositukset sekä kansalliset ravitsemus- ja liikuntasuositukset huomioiden. Osana työtä

varmistetaan, että potilastietojärjestelmät tukevat elintapatietojen selvittämistä sekä elintapaohjausta ja -seurantaa, tupakointi ja muiden nikotiinituotteiden käyttö mukaan lukien, sekä lapsiväestön painonseurantaa.

Varmistetaan, että toimintamalleilla tuetaan kansalaisten omaehtoista terveellisten elintapojen omaksumista, ja että malleissa huomioidaan sekä kasvokkaisten että digitaalisten palveluiden tarve. Määrittelyssä hyödynnetään kansallisia linjauksia, kuten kansanterveyden neuvottelukunnan laatimaa elintapaohjauksen tarkistuslistaa[39], ja huomioidaan STM:n ennakoivaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskeva lainsäädäntövalmistelu.

Vastuutaho: STM, THL, kunnat, hyvinvointialueet, HUS, neuvolat ja kouluterveydenhuolto.

Resurssi: Arvioitu tarvittava määräraha 1 800 000 €. Rahoitusta kohdennetaan valtakunnalliseen selvitystyöhön, kansallisen elintapaohjauksen mallin määrittelyyn sekä toimintamallien yhtenäistämisen ja käyttöönoton koordinaatioon. Lisäksi varmistetaan Hyte-koordinaattoriresurssien tuki toimeenpanossa. Toimeenpanossa hyödynnetään synergioita Terveydeksi-ohjelman[40] kanssa.

2026–2028: Selvitys sote-palvelujen ehkäisevistä käytännöistä päihteiden, ravitsemuksen ja liikunnan osalta sekä suositus kansallisista yhtenäisistä toimintamalleista laadittu. Kansallisen mallin mukaiset (sovelletut) alueelliset palvelut nikotiini- ja alkoholivieroitukseen, ravitsemus- ja liikuntaohjaukseen on otettu käyttöön 50 %:lla hyvinvointialueista.

Mittari: Hyvinvointialueella kyseiset palvelut, palveluiden maksuttomuus.

Mittari: Tupakoivien ja päihteitä käyttävien osuus alueittain.

Toimenpide 2.2.3 Nostetaan HPV-rokotuskattavuutta alakouluissa koordinoidulla yhteistyöllä ja viestinnällä sekä varmistetaan rokotusten aktiivinen tarjoaminen ja täydentäminen myös yläkoulussa ja toisella asteella

Nostetaan HPV-rokotuskattavuutta vahvistamalla viestintää eri väestöryhmille eri tahojen (esim. hyvinvointialueet, HUS ja Helsingin kaupunki, Syöpäjärjestöt, maahanmuuttajajärjestöt, muut sote-järjestöt, opetusministeriö, THL) tehokkaasti koordinoituna yhteistyönä. Rokotukset tulee toteuttaa ensisijaisesti alakouluissa ja toissijaisesti

39 Sosiaali- ja terveysministeriö. Kansanterveyden neuvottelukunta, Rakenteet ja menetelmät -jaosto / Elintapahjauksen työryhmä. Elintapaohjauksen tarkistuslista 29.6.2022.
40 Sosiaali- ja terveysministeriö. Terveydeksi – kansallinen terveys- ja hyvinvointiohjelma 2024-2027.

yläkoulussa. Myös toisen asteen oppilaitoksissa on syytä olla rokotusten täydennysmahdollisuus, ja tämän toteuttamiseen on luotava selkeät menettelytavat.

Viestinnässä korostetaan ennen seksielämän aloittamista toteutettujen HPV-rokotusten merkitystä syöpien ehkäisyssä kaikille sukupuolille. Tuotetaan erilaisille kohderyhmille sopivaa viestintämateriaalia eri kielillä. Viestinnällä pyritään tukemaan erityisesti ohjelman mukaista rokottamista, jolloin kohderyhminä ovat vanhemmat, kouluterveydenhoitajat sekä alakoulun opettajat ja oppilaat.

Vastuutaho: THL, hyvinvointialueet, HUS ja Helsingin kaupunki, Syöpäjärjestöt, kunnat ja oppilaitokset.

Resurssi: Arvioitu tarvittava määräraha 150 000 €. Rahoitusta kohdennetaan kansallisen laajapohjaisen rokotusviestintäkampanjan toteutukseen ja eri kohderyhmille tarkoitettujen HPV-viestintämateriaalien tuottamiseen.

Aikataulu:
2026–2028: Kansallinen laajapohjainen rokotusviestintäkampanja on käynnistetty. HPV-viestintämateriaalia on tuotettu laajasti eri kohderyhmille. HPV-rokotusten vaikuttavuusseurannan tuloksia on hyödynnetty viestinnässä.
2029–2031: Rokotusviestintäkampanja jatkuu. Viestintämateriaalien jatkuva hyödyntäminen ja päivittäminen kattavuustavoitteen saavuttamiseksi.

Mittari: HPV-rokotuskattavuus: vähintään 90 % alakoulun päättäneistä koko maassa.

2.3 Eurooppalaiset suositukset ja kansalliset rakenteet ovat perustana vaikuttavien syöpäseulontaohjelmien suunnittelulle ja toteutukselle

Toimenpide 2.3.1 Selvennetään syöpäseulontojen kansallisen ohjausryhmän, seulontaohjelmakohtaisten asiantuntijaryhmien ja Palkon seulontajaoston välinen työnjako ja vastuut

Määritellään syöpäseulontojen suunnitteluun ja ohjaukseen pysyvä virallinen rakenne, prosessi ja aikataulut. Suunnittelun ja ohjauksen uudet rakenteet huomioivat Palkon ja sen seulontajaoston toiminnan. Vastuualueena ovat seulontojen kansallinen ohjaus, uusien seulontaohjelmien käynnistäminen, olemassa olevien seulontaohjelmien kehittäminen sekä lainsäädännön valmistelu ja uudistaminen yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa.

Vastuutaho: STM, Palko, THL / Suomen Syöpärekisteri, kansallinen syöpäseulontojen ohjausryhmä[41].

41 Kansallinen syöpäkeskus FICAN. Syöpäseulontojen ohjaus.

Resurssi: Arvioitu tarvittava määräraha 250 000 €. Määrittely tehdään virkatyönä nykyisten resurssien puitteissa, mutta kansallinen ohjausrakenne vaatii pysyvää rahoitusta.

Aikataulu:
2026–2028: Syöpäseulontojen ohjauksen virallinen rakenne määritelty ja toiminnassa.

Mittari: Seulontojen ohjauksen rakenne on määritelty ja prosessit dokumentoitu julkisesti.

Toimenpide 2.3.2 Päivitetään kriteerit syöpäseulontaohjelmien päätöksentekoon

Päivitetään kriteerit uusiin ja nykyisiin syöpäseulontaohjelmiin liittyvälle päätöksenteolle ja tähän vaadittavalle tutkimusnäytölle osana laajempaa seulontaohjelmien arviointikriteerien päivitystä. Nykyiset STM:n käyttämät kriteerit[42] ovat vuodelta 2006 ja kaipaavat päivitystä.

Olennaisia kriteerejä ovat muun muassa seulonnan syöpäkuolleisuutta vähentävä vaikutus, haittojen minimointi ja kustannusvaikuttavuus. Kriteerien pohjalta tehtävän arvioinnin tulee perustua tuoreimpaan vertaisarvioituun tutkimustietoon, ja eri toimijoiden tulee sitoutua kriteerien soveltamiseen. Kaikki valtakunnalliset seulontaohjelmat tulee arvioida yhtenäisten kriteerien mukaisesti ja yhdenmukaisia arvioinnin menetelmiä käyttäen.

Vastuutaho: STM, Palko, kansallinen syöpäseulontojen ohjausryhmä.

Resurssi: Tehdään virkatyönä nykyisten resurssien puitteissa.

Aikataulu:
2026–2028: Seulontaohjelmiin liittyvän päätöksenteon kriteerit julkaistu.
2029–2031: Kriteerejä sovelletaan johdonmukaisesti seulontaan liittyvässä päätöksenteossa.

Mittari: Seulontaohjelmiin liittyvän päätöksenteon vuonna 2006 julkaistut kansalliset kriteerit on päivitetty, ja niihin sitoudutaan päätöksenteossa.

Toimenpide 2.3.3 Laajennetaan rintasyövän seulonta 46–74-vuotiaisiin

Rintasyövän seulonnan kohdeikää tulee laajentaa nykyisestä 50–69-vuotiaista 46–74-vuotiaisiin. Euroopan unionin neuvosto suositti jo vuonna 2022, että seulonta

42 I. Autti-Rämö, ym. 2006. Lisääkö seulonta terveyttä? Suomen Lääkärilehti 27-31/2006 vsk 61.

tulisi ulottaa 45–74-vuotiaisiin. Kohdeikäryhmän laajennuksesta on julkaistu myös kotimainen mallinnustutkimus, jossa muutoksen osoitettiin olevan kustannusvaikuttava.

Rintasyövän seulonnan asiantuntijaryhmä ja kansallinen syöpäseulontojen ohjausryhmä ovat suositelleet, että ikäryhmälaajennus toteutettaisiin asteittain siten, että ensin seulontaa laajennetaan 46–48-vuotiaisiin ja vasta sen jälkeen 71–74-vuotiaisiin[43]. 46–69-vuotiaat kutsuttaisiin seulontaan kahden vuoden välein ja 70–74-vuotiaat kolmen vuoden välein.

Rintasyövän seulonnan laajentaminen on parhaillaan arvioitavana Palkossa, minkä jälkeen Palko antaa asiasta lausunnon STM:lle. Laajentaminen vaatii hyvinvointialueiden rahoituksen lisäämistä.

Vastuutaho: STM, Palko.

Resurssi: Arvioitu tarvittava määräraha 9 000 000 € lisärahoituksena hyvinvointialueille, mikä kattaa seulontaohjelman asteittaisen laajennuksen vuosina 2028–2031. Ikäryhmiä koskevan laajennuksen jälkeen tarvittava määrärahan lisäystarve on 6 000 000 € vuodessa.

Aikataulu:
2026–2028: Rintasyövän seulonnan kohdeikää on muutettu 46–74-vuotiaisiin, ja ohjelman laajennukseen on varattu rahoitus hyvinvointialueille.
2029–2031: Seulontaa toteutetaan laajemman kohdeikämäärityksen mukaisesti.

Mittari: Seulonta-asetukseen päivitetty rintasyövän seulonnan kohdeiäksi 46–74-vuotiaat.

Toimenpide 2.3.4 Perustetaan uusia valtakunnallisia seulontaohjelmia ja muokataan nykyisiä ohjelmia tutkittuun tietoon ja EU-suosituksiin pohjautuen

EU suosittaa eturauhassyövän ja pitkään tupakoineiden keuhkosyövän seulonnan pilotoimista tutkimusasetelmassa. Näitä seulontoja tutkitaan Suomessa paraikaa satunnaistetussa asetelmassa. Eturauhassyövän osalta vuodesta 2018 lähtien käynnissä olleesta, laajasta ProScreen-tutkimuksesta odotetaan tuloksia strategiakauden aikana. Keuhkosyövän seulonnan pilottitutkimus on käynnistynyt vuoden 2026 alussa Helsingissä ja kahdeksalla hyvinvointialueella.

Myös olemassa olevien seulontaohjelmien tutkimusnäyttö päivittyy säännöllisesti. Uudet seulontaohjelmat ja nykyisten seulontaohjelmien merkittävät muokkaukset käynnistetään Suomessa kansallisen ohjausryhmän esityksen perusteella.

43 Rintasyövän seulonnan asiantuntijaryhmän esitys seulonnan kohdeikäryhmän laajentamisesta 6.3.2025.

Mahdollinen uusien syöpäseulontaohjelmien kansallinen implementointi tulee toteuttaa asteittain pilotoimalla, jotta toimintamallit saadaan hiottua ja resurssien riittävyys varmistettua, ennen kuin seulontaa aletaan toteuttaa koko laajuudessaan määritetyssä kohdeväestössä.

Vastuutaho: STM, Palko, kansallinen syöpäseulontojen ohjausryhmä tai uusi määritetty ohjausrakenne, Suomen Syöpärekisteri, hyvinvointialueet ja Helsingin kaupunki.

Resurssi: Valtion talousarviossa varataan laskelmiin perustuva erillisrahoitus uusien valtakunnallisten seulontaohjelmien käynnistämiseen. Erillisrahoituksen suuruus riippuu suunnitellun seulontaohjelman toteutuksesta, joten arviota ei tässä vaiheessa esitetä.

Aikataulu:
2026–2028: Keuhkosyövän pienimuotoinen seulontapilotti on laajentunut alueellisesti, ja siihen kutsutaan EU-suosituksen edellyttämä kohdeväestö.
2029–2031: Eturauhassyövän seulontaohjelman asiantuntijaryhmä ja Palko ovat antaneet lausuntonsa eturauhassyövän lisäämisestä valtakunnalliseen seulontaohjelmaan, ja mahdollinen suunnitelma eturauhassyövän lisäämisestä valtakunnalliseen seulontaohjelmaan on valmisteltu.

Mittari: Vaikuttaviksi ja kustannusvaikuttaviksi arvioidut seulonnat on otettu osaksi valtakunnallista seulontaohjelmaa.

2.4 Lainsäädäntö ja rekisteritieto mahdollistavat laadukkaan, kustannusvaikuttavan ja riskiperusteisen seulonnan

Toimenpide 2.4.1 Otetaan seulontaohjelmien laatukäsikirjat käyttöön kattavasti palvelujen hankinnassa ja ohjauksessa

Nykyisten syöpäseulontaohjelmien laatukäsikirjat julkaistiin vuonna 2024. Laatukäsikirjojen suositukset toteutuvat kuitenkin vaihtelevasti eri alueilla. Hyvinvointialueiden tulee varmistaa laatukäsikirjojen suositusten toimeenpano sisällyttämällä ne kilpailutuskriteereihin. Käsikirjojen hyödyntämisen edistämiseksi niiden tulee olla tarjolla verkkomuotoisena perehdytyskurssina, jonka suorittamista edellytetään seulontaa toteuttavilta tahoilta.

Myös mahdollisille uusille syöpäseulontaohjelmille tulee laatia laatukäsikirjat, ja olemassa olevia tulee päivittää aktiivisesti tarpeen mukaan ja uuden tutkimustiedon kertyessä. Laatukäsikirjoissa asetettujen tavoitteiden toteutumista tulee seurata systemaattisesti.

Vastuutaho: Kansallinen syöpäseulontojen ohjausryhmä, syöpäseulontaohjelmien asiantuntijaryhmät, hyvinvointialueet ja Helsingin kaupunki, Syöpärekisteri.

Resurssi: Arvioitu tarvittava määräraha 350 000 €. Rahoitusta kohdennetaan eri seulontaohjelmien asiantuntijaryhmien toimintaan ja laatukäsikirjojen julkaisuun kurssimuotoisesti.

Aikataulu:
2026–2028: Seulontaohjelmien perehdytyskurssit julkaistu. Seulontaohjelmien laatukäsikirjat päivitetty ja laadittu uusien ohjelmien osalta.
2029–2031: Hyvinvointialueiden seulontasopimukset perustuvat laatukäsikirjojen suosituksiin.

Mittari: Seulontoihin osallistumisaste (tavoitteena vähintään 80 % osallistumisaste eri ohjelmissa kaikilla hyvinvointialueilla ja Helsingin kaupungissa).

Toimenpide 2.4.2 Uudistetaan lainsäädäntöä mahdollistamaan kustannusvaikuttava ja riskiperusteinen seulonta

Päivitetään lainsäädäntöä siten, että syöpäseulonnat voidaan toteuttaa tehokkaasti määriteltyyn riskiin perustuen, jolloin yksilöllinen tiheämpi tai harvempi seuranta kohdentaa resursseja mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti. Riskiarvioinnin tulee perustua kansallisiin rekisteritietoihin, jotta toteutustapa on yhtenäinen kaikkialla Suomessa. Se edellyttää lainsäädännön muutosta, jotta rekisteritietoja voidaan käyttää riskin määrittelyyn ja seulonnat toteuttaa riskiperusteisesti. STM selvittää näitä muutostarpeita parhaillaan ennakoivan sosiaali- ja terveydenhuollon mahdollistavan lainsäädäntöhankkeen (STM011:00/2026) yhteydessä.

Riskiperusteinen seulonta edellyttää kattavaa ja ajantasaista tietoa seulonnoista sekä niiden ulkopuolella tehdyistä seulontaluonteisista testeistä ja jatkotutkimuksista. Tämän vuoksi kaikille terveydenhuollon toimijoille tulee säätää velvoite toimittaa seulontarekisteriin tiedot kaikista seulontaluonteisista (ns. opportunistisista) testeistä.

Lainsäädännön päivittämisen yhteydessä tulee poistaa tarpeetonta sääntelyä. Esimerkiksi seulonta-asetuksessa määritelty vaatimus kahden riippumattoman radiologin lausunnoista haittaa merkittävästi tekoälyn hyödyntämistä rintasyövän seulonnan toteutuksessa.

Vastuutaho: STM, kansallinen syöpäseulontojen ohjausryhmä tai uusi määritetty ohjausrakenne.

Resurssi: Lainsäädäntömuutokset tehdään virkatyönä nykyisten resurssien puitteissa.

Aikataulu:
2026–2028: Valmistelu lainsäädännön päivitykselle käynnistetty.
2029–2031: Lainsäädännön päivitys tehty riskiperustaisen seulonnan mahdollistamiseksi.

Mittari: Seulontaan liittyvä lainsäädäntö on tavoitetilan mukainen.

Toimenpide 2.4.3 Kohdennetaan seulontaa kohdeväestön tilastollisesti arvioidun riskin perusteella, jolloin osa seulottavista voidaan kutsua seulontaan harvemmin tai useammin

Riskiperusteisen seulonnan tavoitteena on kohdentaa valtakunnallisia syöpäseulontaohjelmia siten, että seulonnan hyöty maksimoituu ja haitat sekä kustannukset minimoidaan. Tällaisen seulonnan toteuttaminen edellyttää toimenpiteessä 2.4.2 määriteltyjä muutoksia lainsäädäntöön.

Kun lainsäädännölliset muutokset on tehty, riskiperusteisen seulonnan toteuttamiseen tulee määritellä valtakunnalliset protokollat eri syöpäseulontaohjelmissa. Riskin arvioinnissa tulee voida käyttää kansallisissa rekistereissä olevia tietoja. Toteutuksen ensimmäisessä vaiheessa seulontaan kutsuttavasta väestöstä voidaan poistaa kokonaan esimerkiksi henkilöt, joilla ei mahdollisen hysterektomian tai kolektomian vuoksi ole seulonnan kohteena olevaa elintä, tai pidentää seulontaväliä esimerkiksi HPV-rokotteen saaneilla sekä hiljattain seulontatutkimuksiin tai tarkempiin diagnostisiin tutkimuksiin osallistuneilla. Myöhemmässä vaiheessa seulontaan kutsuttavaa kohdeväestöä voidaan muokata tilastollisesti mallinnetun riskin pohjalta. Riskin määrittelyssä voidaan käyttää kansallisissa rekistereissä olevia terveystietoja. Tällöin matalassa riskissä olevien henkilöiden seulontaväliä voitaisiin pidentää tai korkeassa riskissä olevien vastaavasti tihentää.

Lisäksi tulee selvittää mahdollisuudet keventää ja automatisoida seulontatiedon toimittamista esimerkiksi rekisterien välisiä integraatioita hyödyntämällä. Seulontoja koskeva ilmoitusvelvollisuus tulee huomioida mahdollisten uusien seulontaohjelmien käynnistämisen yhteydessä ja perustaa ohjelmille kansalliset rekisterit nykyisten seulontarekisterien tavoin. Seulontojen resursoinnissa tulee aina huomioida myös rekisterien perustamisen ja ylläpidon vaatimat resurssit.

Vastuutaho: Kansallinen syöpäseulontojen ohjausryhmä, syöpäseulontaohjelmien asiantuntijaryhmät, Suomen Syöpärekisteri.

Resurssi: Arvioitu tarvittava määräraha 500 000 €. Rahoitusta kohdennetaan seulonta-algoritmien suunnitteluun ja siihen tarvittavaan tiedonkeruuseen (seulontaohjelman ulkopuolisten testien rekisteröinti mukaan lukien). Riskiperusteiseen seulontaan siirtyminen tuottaa myös kustannussäästöjä, mutta näiden suuruus riippuu tarkemmasta toteutustavasta, joten arviota ei tässä yhteydessä esitetä.

Aikataulu:
2026–2028: Seulontaohjelmien laatukäsikirjoissa määriteltyjä seulontaan kutsuttavien poissulkukriteerejä sovelletaan kansallisesti.
2029–2031: Toteuttamiskelpoinen suunnitelma tilastolliseen mallinnukseen perustuvasta riskiseulonnasta valmiina.

Mittari: Seulontaluonteisten testien kattavuus seulontarekisterissä (tavoitteena on, että 100 % seulontaohjelman ulkopuolisista testeistä on rekisteröity).

Mittari: Riskiperusteista syöpäseulontaa toteuttavien ohjelmien määrä.

Toimenpide 2.4.4 Turvataan rahoitus seulontaohjelman puitteissa tehtäviin pilottitutkimuksiin

Syöpäseulontoja kehitetään uuden tutkimustiedon pohjalta. Suomen Syöpärekisterille ja hyvinvointialueille tulee ohjata lisärahoitusta seulontaohjelmien tutkimus- ja kehitystyöhön. Pilottitutkimukset toteutetaan kiinteässä yhteistyössä eri hyvinvointialueiden ja niiden seulontatoimijoiden kanssa. Tulosten perusteella voidaan päättää niiden integroimisesta kansalliseen seulontaohjelmaan.

Vastuutaho: Suomen Syöpärekisteri, hyvinvointialueet, HUS ja Helsingin kaupunki.

Resurssi: Arvioitu tarvittava määräraha 2 500 000 €. Rahoitusta kohdennetaan Suomen Syöpärekisterille sekä hyvinvointialueille syöpäseulontoihin liittyvään tutkimus- ja kehitystyöhön.

Aikataulu:
2026–2028: Uusia seulontaohjelmien toimintaan liittyviä pilottitutkimuksia käynnistetty.
2029–2031: Seulontaohjelmia muokattu pilottitutkimusten tulosten perusteella.

Mittari: Seulontaohjelmaan integroitujen pilottitutkimusten määrä.

Toimenpide 2.4.5 Määritetään toimintamallit, joiden avulla seulontarekistereissä olevaa tietoa hyödynnetään seulontaohjelman kehittämisessä yhdessä hyvinvointialueiden kanssa

Vuosittain julkistettavat seulontatilastot sisältävät jo nyt hyvinvointialuekohtaisia tietoja, mutta tiedon julkaisu tapahtuu viiveellä, koska tilastot sisältävät myös mahdollisten jatkotutkimusten tiedot. Kaikki seulonnoista kertyvä tieto tulee raportoida kuukausittain seulontarekistereihin, ja Syöpärekisterin tulee tarjota hyvinvointialueille niiden pohjalta ajantasaista tilannekuvaa seulontojen toteutumisesta. Tämä vaatii seulonnan toteuttajilta sitoutumista laadukkaan tiedon toimittamiseen ja Syöpärekisteriltä hyvinvointialuekohtaisen raportoinnin kehittämistä.

Seulonnan pohjalta kertyvää tilastotietoa tulee hyödyntää toiminnan kehittämisessä aiempaa laajemmin. Luodaan toimintamallit, jossa seulontatietoa hyödynnetään systemaattisesti ja seulonnan eri vaiheita kuvaavaa tietoa tuotetaan soveltuvin osin jo varhaisemmassa vaiheessa. Lisäksi tarjotaan eri seulontatoimijoille foorumi oman toimintansa vertaamiseen suhteessa muihin, kehittämiskohteiden löytämiseen ja parhaiden käytäntöjen jakamiseen seulontojen toteuttamisessa.

Vastuutaho: Suomen Syöpärekisteri, kansallinen syöpäseulontojen ohjausryhmä ja seulontaohjelmakohtaiset asiantuntijaryhmät, hyvinvointialueet ja Helsingin kaupunki.

Resurssi: Arvioitu tarvittava määräraha 300 000 €. Rahoitusta kohdennetaan raportoinnin kehittämiseen ja vuosittaisen kansallisen syöpäseulonnan laatupäivän järjestämiseen.

Aikataulu:
2026–2028: Suunnitelma seulontatiedon hyödyntämisestä ja vertaiskehittämisestä laadittu.
2029–2031: Suunnitelman mukaiset toimintamallit vakiinnutettu.

2.5 Syövät havaitaan aiempaa varhaisemmassa vaiheessa kaikkialla terveydenhuollossa

Toimenpide 2.5.1 Parannetaan hoitoonpääsyä lisäämällä lääkäriresurssia perusterveydenhuoltoon esimerkiksi laajentamalla omalääkärimalli valtakunnalliseksi

Syöpien varhainen havaitseminen edellyttää toimivaa ja jatkuvaa hoitosuhdetta perusterveydenhuollossa. Hoidon jatkuvuus vahvistaa potilaan ja ammattilaisen välistä luottamusta, mahdollistaa oireiden kokonaisvaltaisen arvioinnin ja tukee varhaista diagnostiikkaa.

Syövän varhaisen toteamisen näkökulmasta on keskeistä, että lääkärien saatavuutta perusterveydenhuollossa vahvistetaan ja hoidon jatkuvuutta tukevien mallien, kuten omalääkäri-omahoitaja-mallin, käyttöönottoa vahvistetaan valtakunnallisesti.

Toteutus: Lisätään perusterveydenhuollon lääkärikapasiteettia ja tuetaan omalääkärimallien käyttöönottoa valtionavustuksilla sekä muilla ohjauskeinoilla. Varmistetaan, että omalääkäri-omahoitaja-työparimalli ja moniammatillinen tiimityö tukevat sujuvaa jatkotutkimuksiin ohjaamista ja nopeaa diagnostiikkaa. Seurataan hoidon jatkuvuuden kehittymistä ja sen vaikutuksia varhaiseen diagnostiikkaan ja hoitoonpääsyn viiveisiin.

Vastuutaho: STM (omalääkäriohjelman[44] kansallinen toimeenpano, ohjaus ja rahoitus), hyvinvointialueet, HUS ja Helsingin kaupunki (omalääkärimallien käyttöönotto).

Resurssi: Toimenpide toteutetaan osana kansallista omalääkäriohjelmaa.

Aikataulu:
2026–2028: Omalääkäriohjelman toimeenpano laajenee, ja hoidon jatkuvuusmallit kattavat kasvavan osan väestöstä kaikilla hyvinvointialueilla.
2028–2031: Hoidon jatkuvuusmallit vakiintuneesti käytössä kaikilla hyvinvointialueilla. Perusterveydenhuollon lääkärikapasiteetti vahvistunut ja hoitoonpääsyn viiveet lyhentyneet.

Toimenpide 2.5.2 Tuetaan sujuvaa siirtymää erikoissairaanhoitoon määrittämällä kansallisiin hoitoketjuihin kuuluvat standardoidut lähetekriteerit, joiden täyttyessä mahdollisista syöpäoireista kärsivät potilaat ohjataan nopeasti tarvittaviin diagnostisiin tutkimuksiin

Syövän varhainen toteaminen edellyttää, että perusterveydenhuollosta erikoissairaanhoitoon siirtyminen on sujuvaa ja yhdenmukaista koko maassa. Osana kansallisia syöpäkohtaisia hoitoketjukuvauksia (toimenpide 3.1.2) määritellään selkeät, standardoidut lähetekriteerit ja toimintamallit, jotka tukevat perusterveydenhuollon ammattilaisia syövän varhaisessa tunnistamisessa, diagnostiikan käynnistämisessä ja jatkotutkimuksiin ohjaamisessa. Lisäksi kehitetään tekoälyn tarjoamia mahdollisuuksia syövän varhaisessa toteamisessa (toimenpide 3.5.3.).

Toteutus: Kehitetään ja otetaan käyttöön muissa Pohjoismaissa (esim. Tanskan Kræftpakkeforløb[45]; Ruotsin standardiserade vårdförlopp [SVF][46]; Norjan Pakkeforløp – kreft[47]) käytössä olevien toimintamallien mukaisia rakenteita hoitoketjujen ja niiden yhteydessä laadittavien oire- ja lähetekriteereiden määrittämiseen. Kuvataan oirelähtöiset toimintamallit, perusterveydenhuollon tutkimusvastuut, suorat tutkimusreitit sekä tarvittaessa nopeat hoitoon pääsyn ratkaisut. Standardoidut lähetekriteerit ja toimintamallit integroidaan osaksi kansallisia syöpäkohtaisia hoitoketjukuvauksia (toimenpide 3.1.2).

Toimintamallien vaikuttava käyttöönotto edellyttää perusterveydenhuollon ammattilaisten osaamisen systemaattista vahvistamista syövän varhaisessa tunnistamisessa, diagnostiikan käynnistämisessä ja jatkotutkimuksiin ohjaamisessa. Hoitoketjujen, ohjeiden ja toimintamallien jalkautumista sekä ammattilaisten osaamista edistetään säännöllisellä ja ajantasaisella koulutuksella.

44 Sosiaali- ja terveysministeriö. Omalääkäriojelma: Tavoitteena parempi hoidon saatavuus ja jatkuvuus.
45 Sundhedsstyrelsen. Kræftpakkeforløb.
46 RCC i samverkan. Standardiserade vårdförlopp i cancervården (SVF).
47 Helsedirektoratet. Kreft – forebygging, diagnostikk og behandling.

Vastuutaho: FICAN (kehitystyön koordinaatio ja toimintamallien jalkauttaminen ja toimeenpanoalueilla) yhteistyössä kansallisten moniammatillisten syöpäryhmien kanssa.

Resurssi: Toteutetaan osana osatavoitteen 3.1 mukaista kansallista hoitoketju- ja hoitosuositustyötä.

Aikataulu:
2026–2028: Standardoidut lähetekriteerit ja oirelähtöiset toimintamallit sisällytetty vähintään viiden yleisimmän syövän kansallisiin hoitoketjukuvauksiin. Pilotointi ja käyttöönotto käynnistetty hyvinvointialueilla.
2029–2031: Standardoidut lähetekriteerit ja toimintamallit sisällytetty kaikkiin merkittäviin syöpäkohtaisiin hoitoketjukuvauksiin. Käyttöönotto laajennettu valtakunnallisesti ja seuranta vakiintunut osaksi hoitoketjujen hallintaa.

Mittari: Vähintään 70 % syövistä diagnosoidaan levinneisyysluokissa I–II vuoteen 2035 mennessä.

Mittari: Ohjeistukset (lähetekriteerit ja toimintamallit) on sisällytetty osaksi kaikkia valtakunnallisia hoitoketjuja.

Toimenpide 2.5.3 Luodaan toimintamallit syöpäriskiryhmien tunnistamiseksi ja varhaisdiagnostiikan parantamiseksi geenitiedon avulla

Syövän ehkäisy ja varhainen toteaminen voivat tehostua merkittävästi tunnistamalla henkilöt, joilla on tavanomaista suurempi riski sairastua syöpään. Geenitiedon hyödyntäminen tarjoaa uusia mahdollisuuksia syöpäriskiryhmien tunnistamiseen sekä syövän ehkäisyn ja varhaisen toteamisen tehostamiseen.

Osa syövistä liittyy perinnölliseen alttiuteen, mutta syöpäalttiusoireyhtymien tunnistaminen on edelleen puutteellista. Lisäksi geneettiseen neuvontaan ohjautuminen ja kasvainten molekyyligeneettinen testaus vaihtelevat tällä hetkellä alueittain. Kansallisesti yhtenäisten toimintamallien puute kuitenkin heikentää geenitiedon systemaattista hyödyntämistä syöpäriskiryhmien tunnistamisessa ja seurannassa.

Toteutus: Käynnistetään kansallinen ohjelma, jonka tavoitteena on selvittää korkean riskin syöpäalttiusgeenitiedon mahdollisuuksia syöpien ehkäisyn ja varhaisen toteamisen tukemiseksi. Ohjelma tuottaa suositukset ja toimintamallit, jotka tukevat yhdenmukaisten käytäntöjen kehittämistä syöpäriskiryhmien tunnistamiseksi sekä syöpien ehkäisyn ja varhaisdiagnostiikan tehostamiseksi geenitiedon avulla.

Vastuutaho: FICAN (ohjelman käynnistäminen ja koordinointi).

Resurssi: Arvioitu tarvittava määräraha 1 000 000 €. Rahoitusta kohdennetaan kansallisen ohjelman koordinointiin, nykytilan kartoitukseen sekä suositusten ja toimintamallien valmisteluun ja pilotointiin.

Aikataulu:
2026–2028: Hankkeen / työryhmän selvitysraportti valmis.
2029–2031: Toimintamallien pilotointi käynnistetty alueellisesti.

Mittari: Ohjeistukset (lähetekriteerit ja toimintamallit) on sisällytetty osaksi kaikkia valtakunnallisia hoitoketjuja.

3. Varmistetaan yhdenvertainen ja vaikuttava syövänhoito

3.1 Kansalliset hoitosuositukset ja hoitoketjut ohjaavat yhdenvertaista, viiveetöntä ja vaikuttavaa hoitoa

Toimenpide 3.1.1 Luodaan kansallinen mekanismi sekä pysyvä rahoitus syöpäkohtaisten hoitosuositusten ylläpitoon

Otetaan käyttöön muiden pohjoismaiden mallien (esim. Tanska[48], Ruotsi[49], Norja[50]) mukaisesti kansallisesti koordinoitu mekanismi syöpäkohtaisten hoitosuositusten laadintaan, päivittämiseen ja ylläpitoon. Hoitosuositukset kattavat hoitoketjun kaikki vaiheet aina ehkäisystä ja varhaisesta diagnostiikasta seurantaan, huomioiden myös kuntoutumiseen ja elämänlaadun tukeen sekä palliatiiviseen hoitoon liittyvät näkökulmat. Näin varmistetaan, että kaikilla merkittävillä syöpäryhmillä on ajantasainen, kattava, kansallisesti hyväksytty hoitosuositus, joka linkittyy kansallisiin hoitoketjukuvauksiin, palveluvalikoiman linjauksiin ja laaturekisterin avulla toteutettavaan kansalliseen vertailuun ja seurantaan.

Toteutus: Nimetään (tunnistaen olemassa olevat ja puuttuvat) kansalliset hoitosuosituksia laativat monialaiset syöpäryhmät, joille määritellään selkeät tehtävät ja vastuut sekä koordinaatiotuki. Laaditaan sopimuksellinen pohja suositustyöhön (ml. hoitoketjukuvaukset) osallistuvien toimijoiden välille. Laaditaan kansallinen toimintamalli ja käsikirja hoitosuositustyöhön olemassa olevia kansallisia menetelmiä ja pohjoismaisia esimerkkejä hyödyntäen. Käsikirja määrittää hoitosuositustyön vaiheet, metodologian, päivityssyklin ja julkaisukäytännöt sekä linkitykset hoitoketjutyöhön sekä laaturekisterin kautta tapahtuvaan prosessi- ja tulosseurantaan. Suunnittelussa huomioidaan hoitosuosituksien nopea päivitystarve, asiantuntijoiden työajan järjestäminen,

48 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG): Kliniske retningslinjer.
49 RCC i samverkan. Nationella vårdprogram cancer.
50 Helsedirektoratet. Kreft – forebygging, diagnostikk og behandling.

hallinnollinen tuki (koordinaatio), menetelmäasiantuntijoiden tuki (metodologia), selkeä julkaisualusta ja viestintä. Lisäksi suunnittelussa varmistetaan, että hoitosuositukset huomioidaan julkisen palveluvalikoiman käyttöä koskevien kriteerien ja suositusten (Palko) laatimisessa ja vastavuoroisesti palveluvalikoiman suositukset hoitosuosituksissa. Tämän mahdollistamiseksi hoitosuositusprosessin ja kansallisten hoitoketjukuvauksien (3.1.2) suunnittelussa varaudutaan mukautumaan suunnitteilla oleviin sisällönohjauksen menetelmiin (kansallinen palvelureformi[51], palveluvalikoiman määrittelyn[52] ja HTA-arvioinnin kehittämistyö, yhtenäiset hoidon perusteet -päivitystyö) ja osallistumaan tähän kokonaisuuteen liittyvään kehittämistyöhön. Tämä edellyttää yhteensovittavaa koordinaatiota ja resurssia em. toimijoiden (STM, THL) kanssa. Myös uudet kehittyvät menetelmät tulee huomioida osana kansallisia hoitosuosituksia, ja niiden hallittu yhdenmukainen käyttöönotto tulee varmistaa (esimerkiksi potilasryhmäkohtaiset suositukset molekyylidiagnostisille tutkimuksille). Kokonaisuuden toteutusta ja seurantaa ohjaamaan perustetaan kansallinen syövän diagnostiikan ja hoidon ohjausryhmä.

Vastuutaho: FICAN (kansallinen koordinaatio, prosessin hallinta, asiantuntijaryhmien nimeäminen ja tukitoiminnot sekä alueellinen käyttöönotto ja seuranta), yhteistyössä kansallisten monialaisten syöpäryhmien kanssa (suositusten sisällöt), Duodecim (menetelmätuki ja ohjaus), Palko (palveluvalikoiman linjausten yhteensovittaminen).

Resurssi: Arvioitu tarvittava määräraha 5 000 000 € / vuosi (yhteensä 25 000 000 € / 5 vuotta, mikä kattaa myös toimenpiteiden 2.5.2, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4 sekä 4.3.2 toteutuksen). Rahoitusta kohdennetaan kansallisten hoitosuositus- ja hoitoketjutyön hallinto- ja koordinaatiorakenteiden muodostamiseen, syöpäkohtaisen asiantuntijaryhmän työskentelyn tukemiseen mukaan lukien metodologinen osaaminen, julkaisualustan teknisten ratkaisujen kehitys sekä alueellisten syöpäkeskusten käyttöönotto- ja seurantarakenteiden vahvistaminen ja hoitoketjujen toteutus hyvinvointialueilla. Käynnistysvaiheen rahoituksen tavoitteena on luoda pysyvä kansallinen mekanismi. Toiminnan vakiinnuttaminen edellyttää tämän jälkeen pysyvää vuosittaista rahoitusta, joka sisällytetään valtion rahoitusohjaukseen osana keskittämisasetuksessa osoitettua syövän ehkäisyn, diagnostiikan, hoidon ja kuntoutuksen valtakunnallista suunnittelu- ja yhteensovittamistehtävää.

Aikataulu:
2026–2028: Kansalliset syöpäryhmät nimetty ja roolit määritelty; Sopimuksellinen pohja eri toimijoiden välille luotu; Kansallinen syövän hoitosuositusprosessin käsikirja on laadittu ja ensimmäinen uuden yhdenmukaisen mallin mukainen syöpäkohtainen hoitosuositustyö on julkaistu.

51 Sosiaali- ja terveysministeriö. Kansallinen palvelureformi.
52 Sosiaali- ja terveysministeriö. Sosiaalihuollon ja terveydenhuollon palveluvalikoiman määrittäminen.

2029–2031: Ensimmäiset 10 monialaista syöpäryhmää ovat saaneet ensimmäiset yhdenmukaisen hoitosuositusprosessin mukaiset hoitosuositukset valmiiksi, ja suositusten päivitysten tarve arvioidaan systemaattisesti (tarvittaessa ja vähintään kerran vuodessa).

Mittari: Ajantasaisten kansallisten hoitosuositusten ja hoitoketjujen saatavuudessa ollaan pohjoismaisella tasolla (hoitosuositusten osuus suhteessa pohjoismaisiin verrokkeihin, %).

Toimenpide 3.1.2 Laaditaan syöpäkohtaiset hoitoketjukuvaukset, ja niiden pohjalta sovelletut alueelliset hoitoketjut, sekä mekanismi niiden ylläpitoon ja hallintaan

Laaditaan kansalliset syöpäkohtaiset hoitoketjukuvaukset osana toimenpiteessä 3.1.1 kuvattua kansallista mekanismia. Kansalliset hoitoketjut kuvataan hyödyntäen pohjoismaissa kehitettyjä malleja. Tällaisia ovat Tanskan Kræftpakkeforløb[53], Ruotsin standardiserade vårdförlopp (SVF)[54] ja Norjan Pakkeforløp - kreft[55], joissa kansalliset hoitosuositukset ja standardoidut hoitopolut muodostavat yhtenäisen, kansallisesti johdetun kokonaisuuden. Hoitoketjujen tarkoituksena on määrittää, miten hoitosuositukset toteutetaan käytännössä ja tehdä niistä mitattava, johdettava ja yhdenvertaisesti toteutettava kokonaisuus. Hoitoketjuissa tehdään näkyväksi ja toimeenpantavaksi hoitosuositusten keskeinen sisältö siten, että ne määrittävät selkeästi hoitoprosessin vaiheet epäilystä diagnostiikkaan, hoidon aloitukseen, hoitoon ja seurantaan. Ketjuissa määritellään ja sovitaan mm. työnjaosta eri toimijoiden välillä, tavoitelluista hoitoonpääsyajoista, keskeisistä laatu- ja vaikuttavuusindikaattoreista sekä kirjaamis- ja koodistokäytännöistä. Hoitoketjujen tarkoituksena on varmistaa, että näyttöön perustuvat hoitosuositukset sekä hoitoon pääsyn tavoiteajat toteutuvat yhdenvertaisesti ja mitattavasti koko maassa. Hoitoketjujen tulee olla linjassa kansallisten palveluvalikoimaa koskevien linjausten ja suositusten kanssa, ja niiden kehittämistyössä varaudutaan mukautumaan suunnitteilla oleviin sisällönohjauksen menetelmiin (ks. 3.1.1).

Toteutus: Kansalliset hoitoketjukuvaukset ja niiden soveltaminen ja alueellinen käyttöönotto toteutetaan osana toimenpiteessä 3.1.1 muodostettavia kansallisia ja alueellisia koordinaatio- ja seurantarakenteita. Kansallinen syövän diagnostiikan ja hoidon ohjausryhmä vastaa kansallisten hoitoketjukuvausten periaatteiden ja rakenteiden määrittelystä. Kansalliset hoitoketjut sovitetaan alueellisiin rakenteisiin määrittäen ja sopien alueellisesti työnjaosta sekä yhteistyö- ja toimintakäytännöistä yhdenvertaisen hoidon toteutumisen varmistamiseksi hoitoketjun eri vaiheissa.

53 Sundhedsstyrelsen. Kræftpakkeforløb.
54 RCC i samverkan. Standardiserade vårdförlopp i cancervården (SVF).
55 Helsedirektoratet. Kreft – forebygging, diagnostikk og behandling.

Vastuutaho: FICAN (kansallinen koordinaatio, prosessin hallinta ja tukitoiminnot sekä alueellinen käyttöönotto ja seuranta) yhteistyössä kansallisten monialaisten syöpäryhmien kanssa (hoitoketjujen sisällöt), hyvinvointialueet ja HUS (hoitoketjujen toteutus).

Resurssi: Toteutetaan osana toimenpiteessä 3.1.1 kuvattua kokonaisresursointia.

Aikataulu:
2026–2028: Kansalliset hoitoketjukuvaukset tehty viidestä syövästä ja syöpäkohtaiset hoitoonpääsyajat on määritetty. YTA- ja hyvinvointialueilla sekä HUSissa alueellisten hoitoketjujen vastuunjaosta on sovittu sopimuksellisesti (YTA-sopimukset).
2029–2031: Kansalliset hoitoketjukuvaukset laadittu kaikista merkittävistä syövistä/syöpäryhmistä. Seurannan ja hoitoketjun hallinnan avulla arvioidaan jatkuvasti annettujen hoitojen (interventioiden) vaikuttavuutta ja hoitoonpääsyä ja reagoidaan lääketieteellisiin ja alue- tai organisaatiokohtaisiin muutoksiin, joilla voi olla vaikutusta potilaan hoitoon.

Mittari: Potilaat pääsevät hoitoon tavoiteaikojen puitteissa.

Toimenpide 3.1.3 Luodaan kansallisesti yhtenäiset linjaukset kustannusten ja muiden yhteiskunnallisten vaikutuksien huomioimiseksi hoitovalinnoissa

Huomioidaan STM:n Sosiaalihuollon ja terveydenhuollon palveluvalikoiman periaatteiden määrittäminen -hankkeessa[56] julkaistavat palveluvalikoiman periaatteet, ja sovelletaan niitä syövän hoitosuosituksissa ja hoitoketjujen laatimisessa. Integroidaan palveluvalikoiman periaatteet osaksi kansallista hoitosuositusprosessia. Yhteiskunnallisissa vaikutuksissa huomioidaan mahdollisuuksien mukaan myös ympäristövaikutukset ja ekologinen kestävyys.

Vastuutaho: STM, Palko ja muut arviointiviranomaiset yhteystyössä arviointiviranomaiset yhteistyössä FICANin sekä kansallisten monialaisten syöpäryhmien kanssa.

Resurssi: Toteutetaan osana toimenpiteessä 3.1.1 kuvattua kokonaisresursointia.

Aikataulu:
2026–2028: Huomioitu palveluvalikoiman periaatteet syövän hoitosuositusprosessin kehittämisessä.
2029–2031: Syövän hoitosuositukset ja muu suositustoiminta ovat keskenään linjassa.

56 Sosiaali- ja terveysministeriö. Sosiaalihuollon ja terveydenhuollon palveluvalikoiman periaatteiden määrittäminen.

Toimenpide 3.1.4 Määritellään kansalliset laatu- ja vaikuttavuustavoitteet ja seurantamittarit hoitoketjujen seurannan mahdollistamiseksi

Määritellään kansallisesti yhtenäiset syöpäkohtaiset laatu- ja vaikuttavuustavoitteet ja niitä seuraavat indikaattorit osana toimenpiteessä 3.1.1 määriteltyä kansallista mekanismia. Laatu- ja vaikuttavuustavoitteet muodostavat sisällöllisen perustan kansalliselle vertailulle, vertaiskehittämiselle ja tulosparannukselle. Laatu- ja vaikuttavuustavoitteet tulisi ensisijaisesti määrittää suurimmille ja yleisimmille syöville, joiden kansanterveydellinen vaikutus sekä osuus sosiaali- ja terveydenhuollon budjetista kansallisella tasolla on merkittävin ja joissa on tunnistettu tarve ja mahdollisuus parantaa Suomen hoitotuloksia.

Toteutus: Määritellään syöpäkohtaiset laatu- ja vaikuttavuustavoitteet samoissa rakenteissa ja samojen moniammatillisten kansallisten syöpäryhmien toimesta, jotka vastaavat hoitosuosituksista ja hoitoketjuista (toimenpiteet 3.1.1 ja 3.1.2). Tavoitteiden ja mittarien määrittely tehdään samassa prosessissa kuin hoitoketjukuvaukset, jotta sisältö, prosessi ja seuranta muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden. Indikaattoreiden tuotanto ja raportointi toteutetaan osana kansallista syöpien laaturekisteritoimintaa (osatavoite 3.2). Syöpäkohtaisten tavoitteiden ja indikaattoreiden rinnalle määritetään yhteiset tavoitteet ja indikaattorit. Yhteisten tavoitteiden ja indikaattoreiden tulee olla kansainvälisesti vertailtavia, potilaille ja ammattilaisille sekä yhteiskunnallisesti merkityksellisiä. Yhteisten indikaattoreiden määrittely toteutetaan osana kansallisen syövän diagnostiikan ja hoidon ohjausryhmän toimintaa. Indikaattoreiden laadintaprosessissa hyödynnetään THL:n osaamista ja laaturekisterityössä rakennettuja toimintamalleja.

Vastuutaho: FICAN (kansallinen koordinaatio ja tavoitteiden määrittelyn ohjaus) yhdessä kansallisen syövän diagnostiikan ja hoidon ohjausryhmän (yhteiset indikaattorit) sekä kansallisten monialaisten syöpäryhmien kanssa (syöpäkohtaiset laatu- ja vaikuttavuustavoitteet sekä indikaattorit), THL (indikaattorien määrittelyn metodologinen tuki ja ohjaus).

Resurssi: Toteutetaan osana toimenpiteessä 3.1.1 kuvattua kokonaisresursointia.

Aikataulu:
2026–2028: Kansalliset laatu- ja vaikuttavuusindikaattorit sekä tavoitteet määritetty vähintään viidelle suurimmalle syöpäryhmälle; Syöpäkohtaiset ja yhteiset indikaattorit määritelty.
2029–2031: Kansalliset laatu- ja vaikuttavuusindikaattorit sekä -tavoitteet määritelty kaikille merkittäville syöpäryhmille, ne ovat käytössä ja mahdollistavat vertailukelpoisen tiedon tuottamisen hoidon kehittämisen ja päätöksenteon tueksi.

Mittari: Kansalliset ja yhtenäiset tavoitteet ja keskeisimmät vaikuttavuuden seurantamittarit määritetty sovittuihin syöpiin.

3.2 Kansallisen syövänhoidon laaturekisteri, systemaattinen tulosten tarkastelu ja vertaisarviointi tukevat vaikuttavan hoidon kehittämistä

Toimenpide 3.2.1 Luodaan lainsäädännöllinen pohja THL:n Syöpärekisterin yhteyteen perustettavalle syövän hoidon laaturekisterille

Perustetaan THL:n Syöpärekisterin yhteyteen kansallinen syövän hoidon laaturekisteri. Perustamisessa hyödynnetään käynnissä olevan tutkimushankkeen aikana kehitettäviä malleja sekä hankkeen tuottamia tuloksia. Alkuvaiheessa laaturekisteritoimintaa kehitetään viiden syövän osalta tutkimushankkeen tulosten perusteella. Laaturekisteritoiminnan laajentaminen uusiin syöpiin arvioidaan osana laaturekisteritoiminnalle perustettavaa pysyvää ohjausta, THL:n kehittämiä toimintamalleja ja kriteeristöjä hyödyntäen. Syöpäkohtaisten laaturekisterien asiantuntijaryhminä toimivat edellä (toimenpiteet 3.1.1, 3.1.2) kuvatut kansalliset monialaiset syöpäryhmät, joiden toimintaa FICAN tukee ja koordinoi. Kansallisen syövän laaturekisterin kehityksessä tulee jatkossa huomioida myös kehitteillä oleva kansallinen terveyden tietovaranto ja pyrkiä laajentamaan tietopohjaa myös sen tavoitteiden mukaisesti sekä syöpätutkimusta tukien.

Toteutus: Päivitetään STM:n asetus THL:n laaturekistereistä sisältämään syöpäsairaudet ja huomioimaan sen eri toimijat. Kohdennetaan laaturekisterityöhön valtionosuus, jolla katetaan sen perustamiseen (ml. tutkimushanke) ja ylläpitämiseen liittyvät kustannukset osapuolien välisen työnjaon mukaisesti. Jatketaan käynnissä olevan THL–Syöpärekisteri–FICAN -tutkimushankkeen toteutusta vuoden 2027 loppuun asti, minkä jälkeen hyödynnetään hankkeen tuloksia pysyvän laaturekisteritoiminnan perustamisessa.

Vastuutaho: STM (asetusmuutos), THL/Suomen Syöpärekisteri (syövän laaturekisterin perustaminen ja ylläpito), FICAN.

Resurssi: Arvioitu tarvittava määräraha 2 500 000 €. Rahoitusta kohdennetaan syövän laaturekisterin tietopohjan rakentamiseen, analyysi- ja raportointitietokantojen sekä toiminnan ja raportoinnin kehittämiseen sekä tarvittaviin juokseviin investointeihin ja infrastruktuurin kehittämiseen. Käynnistysvaiheen rahoituksen tavoitteena varmistetaan pysyvän laaturekisteritoiminnan käynnistäminen. Toiminnan vakiinnuttaminen edellyttää tämän jälkeen pysyvää vuosittaista rahoitusta, joka sisällytetään valtion rahoitusohjaukseen osana kansallista laaturekisteritoimintaa.

Aikataulu:
2026–2028: Laaturekisteriasetus on päivitetty koskemaan syöpäsairauksia.
2029–2031: Syövän laaturekisteri tuottaa vähintään viiden eri syövän vuosittaiset raportit, ja niistä saatu tieto ohjaa tavoiteperusteisesti kansallisen ja alueellisen syövänhoidon kehittämistä ja palvelujärjestelmän toimintaa.

Mittari: Laaturekisterin tietopohja (ml. levinneisyystieto) mahdollistaa laadun ja vaikuttavuuden luotettavan arvioinnin ja vertailun (tietopohjan kattavuus 90 %); Kliinisten syöpäilmoitusten määrä (tavoitteena 90 % tapauksista automatisoidusti vuoteen 2030 mennessä).

Toimenpide 3.2.2 Määritetään ja käynnistetään vertaiskehittämisen prosessit, jolla laaturekisterin tuottamaa tietoa vertaillaan ja tarkastellaan systemaattisesti

Ensisijaisena tavoitteena on vertaiskehittäminen ja tulosten tarkastelu kansallisesti. Siten voidaan tunnistaa kehityskohteita ja jakaa hyviä käytäntöjä tulosten parantamiseksi ja erojen kaventamiseksi (benchmarking) hyvinvointialueiden kesken. Vertaiskehittämistoiminnan pitkän tähtäimen tavoitteena on potilaille merkittävien tulosten parantaminen sekä hoidon kustannusvaikuttavuuden ja yhdenvertaisuuden parantaminen.

Toteutus: Luodaan ja käynnistetään syövänhoidon syöpäkohtainen kansallinen vertaisarviointi ja -kehittämistoiminta. Kansallisen vertaisarvioinnin ja -kehittämisen käynnistämisessä hyödynnetään tutkimushankkeessa kehitettyjä sekä THL:n laaturekistereiden ympärille rakennettuja toimintamalleja vertaiskehittämistoimintaan. Tuloksia tarkastellaan kansallisesti ja vertaisarvioinnit toteutetaan kerran vuodessa. Vertaiskehittämistoiminnan prosesseja ylläpidetään osana kansallisten hoitosuositusten ja -ketjujen ympärille muodostettavia koordinaatio- ja tukirakenteita.

Vastuutaho: FICAN (vertaisarviointi ja -kehittämistoiminnan järjestäminen), THL.

Resurssi: Arvioitu tarvittava määräraha 300 000 €. Rahoitusta kohdennetaan vertaiskehittämistoiminnan järjestämiseen. Käynnistysvaiheen rahoituksen tavoitteena on luoda ja ottaa käyttöön kansallisen syöpien vertaiskehittämisen toimintamallit. Toiminnan vakiinnuttaminen edellyttää tämän jälkeen pysyvää vuosittaista rahoitusta, joka sisällytetään valtion rahoitusohjaukseen osana keskittämisasetuksessa osoitettua syövän ehkäisyn, diagnostiikan, hoidon ja kuntoutuksen valtakunnallista suunnittelu- ja yhteensovittamistehtävää.

Aikataulu:
2026–2028: Vertaisarvioinnin ja -kehittämisen prosessit ja toimintamallit on määritelty ja käynnistetty ensimmäisen viiden syövän osalta.

2029–2031: Vertaisarvioinnin ja -kehittämisen prosessit ovat vakiintuneet ja niitä kehitetään jatkuvasti. Arvioinnin alueellisia eroja seurataan systemaattisesti julkisesti raportoitavilla mittareilla. Arvioinnin tuloksia verrataan systemaattisesti kansainvälisiin verrokkeihin sovituin mittarein. Syövän hoidon tuloksissa, kustannusvaikuttavuudessa ja/tai yhdenvertaisuudessa havaitaan myönteistä kehitystä.

Mittari: Syöpäkohtaisten tietojen kirjaaminen laaturekisteriin.

Mittari: Vertaiskehittämistoiminta käytössä (syöpätyyppien lukumäärä, joista tieto laaturekistereissä).

Mittari: Saatavilla on luotettavaa tietoa syövän diagnostiikka- ja hoitokäytäntöjen alueellisista eroista, minkä avulla voidaan kaventaa eroja hoitotuloksissa.

Toimenpide 3.2.3 Määritetään ja käynnistetään ohjaus- ja johtamismekanismit, joilla vertaisarvioinnin tuloksiin ja mahdollisiin puutteisiin reagoidaan

Ensisijaisena tavoitteena on, että vertaiskehittäminen ja tulosten tarkastelu yhdessä kansallisessa foorumissa auttavat tunnistamaan kehityskohteita ja löytämään hyvinvointialueiden kesken hyviä käytäntöjä, joiden käyttöönoton myötä nähdään tulosparannuksia. Tämän lisäksi on kuitenkin varmistettava yhdenmukaiset rakenteet ja toimintamallit systemaattiseen tulosten tarkasteluun ja mahdollisiin tulospoikkeamiin reagointiin alueilla. Syöpäkohtaiset tavoitteet, laaturekisterin tuottama tieto ja vertaiskehittämisen tuottama kentän näkemys muodostavat tietopohjan, jonka avulla alueellinen syöpäkeskus pystyy seuraamaan syövän hoidon pitkän tähtäimen tavoiteperusteista kokonaiskuvaa hyvinvointialueilla ja reagoimaan siihen tarvittavilla toimilla. Tavoitteena on varmistaa, että laaturekisterin tuottama tieto ei jää raportoinnin tasolle, vaan johtaa tarvittaessa konkreettisiin kehittämistoimiin hyvinvointialueilla ja kansallisella tasolla.

Toteutus: Määritetään FICANin olemassa olevia rakenteita hyödyntäen kansallisesti yhdenmukaiset ohjaus- ja johtomekanismit, joiden avulla tuloksiin ja mahdollisiin poikkeamiin pystytään reagoimaan hyvinvointialueilla ja kansallisesti. Näissä mekanismeissa huomioidaan myös tarve voimakkaampaan sisällölliseen ohjaukseen, joista raportoitaisiin STM:lle tai muille viranomaisille. Ohjaus- ja johtomekanismeista sovitaan kansallisen syöpäkeskuksen johtoryhmässä, jossa ovat edustettuina myös STM:n toimijat.

Vastuutaho: FICAN (ohjaus- ja johtomekanismien sekä prosessien määrittäminen ja käyttöönotto), STM (tiedon hyödyntäminen sisällön ohjauksessa).

Resurssi: Arvioitu tarvittava määräraha 3 000 000 €. Rahoitusta kohdennetaan alueelliseen sekä kansalliseen ohjaus- ja johtomekanismien koordinaatioon ja raportointirakenteiden ylläpitoon. Käynnistysvaiheen rahoituksen tavoitteena on luoda ja ottaa käyttöön pysyvät ohjaus- ja johtomekanismit. Toiminnan vakiinnuttaminen edellyttää tämän jälkeen pysyvää vuosittaista rahoitusta, joka sisällytetään valtion rahoitusohjaukseen osana keskittämisasetuksessa osoitettua syövän ehkäisyn, diagnostiikan, hoidon ja kuntoutuksen valtakunnallista suunnittelu- ja yhteensovittamistehtävää.

Aikataulu:
2026–2028: Sovittu yhdessä toimintamallit tulosten tarkasteluun poikkeamiin reagoimiseen alueellisissa ja kansallisissa johtamis- ja ohjausrakenteissa.
2029–2031: Toimintamallit ovat käytössä ja ohjaus- ja johtomekanismi vakiintunut; tulospoikkeamiin reagointi toteutuu systemaattisesti kaikilla alueilla; kehittämistoimien vaikutuksia seurataan kansallisesti.

Mittari: Saatavilla on luotettavaa tietoa syövän diagnostiikka- ja hoitokäytäntöjen alueellisista eroista, minkä avulla voidaan kaventaa eroja hoitotuloksissa.

Toimenpide 3.2.4 Selkeytetään syövän hoidon laaturekisteritoimintaan osallistuvien toimijoiden roolit ja vastuut, laaditaan sopimuksellinen pohja sekä varmistetaan pysyvä rahoitus laaturekisteritoiminnalle

Syövän hoidon laaturekisteritoiminnan pitkäjänteisen ja vaikuttavan toteutuksen varmistamiseksi määritellään selkeästi kansallisten toimijoiden roolit, vastuut ja työnjako. Käynnissä olevan tutkimushankkeen tuloksia hyödynnetään toimijoiden roolien tarkentamisessa ja pysyvän yhteistyömallin rakentamisessa. Tavoitteena on luoda selkeä, sopimuksellinen ja pysyvä toimintamalli, joka tukee laaturekisteritoiminnan kehittämistä, kansallista vertailua ja ohjausta sekä tutkimuksen hyödyntämistä. Samalla varmistetaan laaturekisteritoiminnan pysyvä rahoitus.

Toteutus: Käynnissä olevan tutkimushankkeen aikana valmistellaan strategian linjaukset huomioiden toimijoiden välinen sopimuksellinen pohja, jossa määritellään mm. rekisterinpitäjän vastuut, analytiikan ja raportoinnin vastuut sekä tietojen hyödyntäminen ohjauksessa ja tutkimuksessa laaturekisteritoiminnan pysyvä rahoitus huomioiden. Tutkimushankkeen tulosten ja erikseen laadittujen sopimusten pohjalta siirrytään syövän hoidon laaturekisterin pysyvään toimintamalliin vuoden 2028 alusta.

Vastuutaho: THL, Syöpärekisteri, FICAN, STM (kansallinen ohjaus ja rahoitusratkaisut).

Resurssi: Toteutetaan virkatyönä.

Aikataulu:
2026–2028: Toimijoiden roolit ja vastuut täsmennetty tutkimushankkeen pohjalta; sopimuksellinen yhteistyömalli laadittu ja hyväksytty; pysyvän rahoituksen malli sovittu.
2029–2031: Sopimuksellinen toimintamalli käytössä; rahoitus sisällytetty pysyvästi kansalliseen ohjaus- ja rahoitusjärjestelmään.

3.3 Kuntoutus, psykososiaalinen tuki, terveyssosiaalityö ja palliatiivinen hoito ovat vakiintunut osa syöpäpotilaan hoitoketjua ja yhdenvertaisesti saatavilla

Toimenpide 3.3.1 Laaditaan kansallisesti yhdenmukaiset käytännöt ja mittarit syöpäpotilaiden oireiden, elämänlaadun, toimintakyvyn ja yksilöllisten tuen tarpeiden arvioimiseksi

Laaditaan kansallisesti yhtenäinen suositus ja käytännöt sekä määritellään geneeriset sekä syöpäkohtaiset mittarit potilaiden raportoimien oireiden, elämänlaadun, toimintakyvyn sekä tuen tarpeen arviointiin. Integroidaan mittareiden tuottama elämänlaatu-, toimintakyky- ja oiretieto rakenteisesti potilastietojärjestelmiin ja OmaKantaan digitaalisia ratkaisuja hyödyntäen. Hyödynnetään tietoa jatkossa myös hoitojen/palvelujen laadun ja vaikuttavuuden arvioinnissa ja seurannassa osana kansallista syöpien laaturekisteriä.

Toteutus: Hyödynnetään STM:n valitsemaa ja THL:n laaturekistereissä yhteisesti käytettävää kansallista geneeristä PROM-mittaria (EQ-5D-5L) syöpäpotilaiden itse-arvioidun terveydentilan, elämänlaadun ja toimintakyvyn arvioinnissa THL:n koordinoiman GenPROM-toimeenpanon[57] mukaisesti. Kootaan kansallinen asiantuntijaryhmä toteuttamaan arvio syöpäkohtaisten vointimittareiden (PROM) tarpeesta niihin syöpiin ja hoitopolun vaiheisiin, joissa lisämittarit tuottavat olennaista, kliinisesti hyödynnettävää lisätietoa esimerkiksi oirekuorman, hoidon haittojen, toimintakyvyn muutosten tai tuen tarpeen tunnistamiseen. Kansallinen asiantuntijaryhmä laatii hyvinvointialueiden ja syöpää hoitavien ammattilaisten käyttöön suunnitelman ja toimintamallin, joka ohjaa kansallisten syöpäkohtaisten PROMien käyttöönottoon, käyttöön ja PROM-tiedon hyödyntämiseen. Toteutetaan arviointitiedon rakenteinen integraatio järjestelmiin yhteistyössä THL:n, hyvinvointialueiden ja järjestelmätoimittajien kanssa. Osana syöpien laatu- ja vaikuttavuustavoitteiden sekä seurantamittareiden määrittelyä (toimenpide 3.1.4) huomioidaan PROM-tietoon perustuvat vertailuun ja ohjaukseen soveltuvat indikaattorit osaksi kansallista syöpien laaturekisteriä.

57 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Geneerisen PROMin valinta ja käyttöönotto terveydenhuollossa (GenPROM).

Vastuutaho: THL (GenPROM toimeenpano, tiedon rakenteinen integraatio), FICAN (syöpäkohtaisten ja palliatiivisen hoidon vaiheen PROMien arviot ja käyttöönotto), hyvinvointialueet ja HUS (mittareiden käyttöönotto ja tiedonkeruu).

Resurssi: Arvioitu tarvittava määräraha 500 000 €. Rahoitusta kohdennetaan kansallisesti koordinoituun asiantuntijatyöhön syöpäkohtaisten PROM- ja oiremittareiden määrittelemiseksi ja yhteensovittamiseksi sekä käyttöönoton tukeen hyvinvointialueilla. Mittareiden käyttöönotto edellyttää myös digitaalisten ratkaisujen kehitystä hyvinvointialueilla (toimenpide 3.5.3).

Aikataulu:
2026–2028: EQ-5D-5L käytössä syövän hoidossa GenPROM-mallin mukaisesti; tarvearvio syöpäkohtaisista PROM- ja oiremittareista toteutettu ja mittareiden määrittelytyö käynnistetty.
2029–2031: Syöpäkohtaiset mittarit määritetty ja otettu kansallisesti käyttöön ensimmäisen kolmen syöpätyypin sekä palliatiivisen hoidon vaiheen osalta; työ arviointitiedon integroimiseksi järjestelmiin käynnistetty.

Mittari: Niiden syöpäpotilaiden osuus, joista on saatavilla oire-, elämänlaatu- ja toimintakykytieto (%).

Toimenpide 3.3.2 Määritetään kansallinen syöpäpotilaiden tukipalveluiden palveluvalikoima (ml. kolmannen sektorin palvelut) ja suositukset tukipalveluiden henkilöstömitoituksesta sekä varmistetaan suositusten mukaiset ja saumattomat tukipalveluiden palveluketjut

Selvitetään syöpään sairastuneiden, heidän perheidensä ja läheistensä psykososiaalisen tuen, terveyssosiaalityön, kuntoutuksen (ml. fyysistä aktiivisuutta ja liikuntaa tukevat palvelut) ja palliatiivisen hoidon palveluiden saatavuuden ja järjestämisen nykytila (palvelut, vastuuyksiköt, tiimit ja vastuuhenkilöt, kolmannen sektorin yhteistyö) hyvinvointialueilla ja HUSissa huomioiden jo tehty selvitystyö mm. palliatiivisen hoidon palveluketjun osalta. Selvityksen perusteella määritetään kansallisesti yhdenmukainen syöpäpotilaiden tukipalveluiden palveluvalikoima, joka kattaa keskeiset terveyssosiaalityön, psykososiaalisen tuen ja kuntoutuksen sekä palliatiivisen hoidon tukipalvelut, vertaistuen sekä kolmannen sektorin ja seurakuntien (hengellinen ja eksistentiaalinen tuki) tarjoaman tuen ja niiden järjestämisvastuut. Lisäksi määritellään suositukset tukipalveluiden henkilöstömitoituksista hyvinvointialueilla. Hyvinvointialueet vastaavat riittävien resurssien varmistamisesta sekä kolmannen sektorin yhteistyöstä saumattoman palveluketjun kattamiseksi. Tukipalvelut integroidaan osaksi syövän hoitoketjuja (toimenpide 3.1.2), joissa selkeytetään palveluihin ohjaamisen käytännöt.

Toteutus: Kootaan kansallinen asiantuntijaryhmä (ml. kolmannen sektorin edustajat) vastaamaan tukipalveluiden nykytilan selvittämisestä ja palveluvalikoiman sekä palveluketjukuvauksen valmistelusta ja käyttöönoton tuesta hyvinvointialueille ja HUSiin. Kansallisen tukipalveluiden palveluvalikoiman valmistelussa hyödynnetään Palkon asiantuntemusta erityisesti julkisen sektorin vastuulle kuuluvien tukipalveluiden määrittelyssä ja rajauksissa.

Vastuutaho: FICAN (asiantuntijaryhmän työskentelyn koordinaatio), Palko (palveluvalikoiman rajaukset ja arviointi), Syöpäjärjestöt, potilasjärjestöt ja Kirkkohallitus (palveluiden järjestäminen), hyvinvointialueet, Helsingin kaupunki ja HUS (palveluiden järjestäminen).

Resurssi: Arvioitu tarvittava määräraha 350 000 €. Rahoitusta kohdennetaan asiantuntijatyöryhmän työskentelyyn ja koordinaatioon, selvitysten toteuttamiseen sekä kansallisen palveluvalikoiman ja -ketjun kuvaamiseen. Tukipalveluiden henkilöstöresurssien tarve hyvinvointialueilla täsmentyy kansallisen palveluvalikoiman ja henkilöstömitoitussuositusten valmistumisen jälkeen. Selvitysten perusteella valmistellaan erillinen ehdotus tukipalveluiden resurssivajeen korjaamiseksi ja rahoituksen kohdentamiseksi hyvinvointialueille.

Aikataulu:
2026–2028: Selvitys tukipalveluiden saatavuuden ja järjestämisen osalta laadittu.
2029–2031: Suositukset kansallisesta syöpäpotilaiden tukipalveluiden palveluvalikoimasta ja henkilöstömitoituksesta laadittu sekä tukipalveluiden palveluketjujen perusrakenne ja järjestämisvastuut kuvattu. Ehdotus tukipalveluiden resurssivajeen korjaamiseksi laadittu.

Mittari: Yksiköiden osuus, joissa saatavilla psykososiaalisia, sosiaalisia, henkisiä/hengellisiä, palliatiivisen hoidon ja kuntoutuksen palveluita (%).

Mittari: Palliatiivisten hoitolinjauksien määrät syöpään kuolleista potilaista (%) sekä palliatiivisten hoitolinjauksien ajankohta suhteessa kuolemaan (vrk).

Toimenpide 3.3.3 Laaditaan ja otetaan käyttöön kansalliset ohjeistukset ja vaikuttavat toimintamallit syöpään sairastuneiden työ- ja toimintakyvyn sekä oikea-aikaisen palliatiivisen hoidon varmistamiseksi kaikissa ikäryhmissä

Toimintamallien käyttöönotto perustuu toimenpiteissä 3.3.1 ja 3.3.2 luotuihin arviointi- ja tukipalvelurakenteisiin, jotka mahdollistavat toimintamallien yhtenäisen ja vaikuttavan toimeenpanon.

Lasten ja nuorten myöhäisseuranta. Vakiinnutetaan lasten, nuorten ja nuorten aikuisten syövän myöhäisseurantaan tarkoitettu psykososiaalisen tuen ja kuntoutumisen HYVA-palvelupolku käyttöön kansallisesti. Palvelupolku sisältää strukturoituja

avainkäyntejä, joissa huomioidaan potilaan fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky sekä tunnistetaan yksilölliset tuen ja kuntoutuksen tarpeet. Palvelupolku kattaa myös siirtymän lasten ja nuorten yksiköistä aikuisten terveydenhuoltoon ja tukee katkeamattoman hoito- ja tukiketjun toteutumista.

Työkyvyn ja työhön paluun tuki. Otetaan kansallisesti käyttöön TYÖOTE-toimintamalli[58] työikäisten syöpäpotilaiden työkyvyn tukemiseksi ja työhön paluun edistämiseksi. Toimintamalli toteutetaan yhteistyössä erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon, työterveyshuollon sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon kanssa. Hyvinvointialueet sovittavat mallin alueellisiin rakenteisiin ja laativat selkeät prosessikuvaukset, joissa määritellään eri toimijoiden vastuut ja yhteistyökäytännöt.

Kuntoutumista tukeva suunnitelma ja fyysisen aktiivisuuden edistäminen. Laaditaan kansallisesti yhtenäiset suositukset ja toimintamallit syöpäpotilaiden toimintakykyarvioon perustuvaan kuntoutuksen suunnitteluun ja toteutukseen. Toimintamallien tueksi laaditaan yhtenäinen kuntoutumista tukeva suunnitelmapohja, joka otetaan käyttöön kaikissa syövän hoitoa tarjoavissa yksiköissä ja integroidaan potilastietojärjestelmiin. Osana kuntoutumisen tukea vahvistetaan fyysisen aktiivisuuden ja liikunnan roolia omahoidon ja toimintakyvyn tukemisessa elintapaohjauksen ja liikuntaneuvonnan keinoin ja varmistetaan, että sairastuneiden fyysistä aktiivisuutta tukevat toimintamallit, esimerkiksi Liikkumisresepti[59], ovat kiinteä osa hoitoketjua diagnoosista hoitojen jälkeiseen aikaan.

Varhainen palliatiivinen hoito. Laaditaan kansalliset kriteerit ja ohjeistukset varhaisen rinnakkaisen palliatiivisen hoidon toteuttamiseksi syöpäpotilaan hoitopolulla. Ohjeistuksissa määritellään selkeät lähetekriteerit ja toimintaperiaatteet palliatiivisen hoidon integroimiseksi syövän hoitoon jo varhaisessa vaiheessa. Lisäksi laaditaan kansallinen ohjeistus palliatiivisen hoitolinjan asettamisesta sekä kansallinen malli elämän loppuvaiheen ennakoivasta hoitosuunnitelmasta osana syöpäpotilaiden hoitoa, ja integroidaan se potilastietojärjestelmiin. Ohjeistukset huomioidaan osana kansallisia syöpäkohtaisia hoitosuosituksia ja -ketjuja.

Toteutus: Perustetaan kansalliset asiantuntijaryhmät puuttuvien ohjeistusten ja toimintamallien laatimiseksi sekä olemassa olevien vaikuttavien mallien yhteensovittamiseksi. Asiantuntijaryhmät varmistavat yhdessä syöpäkohtaisten asiantuntijaryhmien kanssa, että toimintamallit integroidaan osaksi syöpäkohtaisia hoitoketjuja (toimenpide 3.1.2). Tuetaan toimintamallien käyttöönottoa ja jalkauttamista HUSissa ja hyvinvointialueilla osaksi alueellisia palvelurakenteita alueellisten syöpäkeskusten kautta koulutusten, ohjeistusten ja kansallisen koordinaatiotuen avulla.

Vastuutaho: FICAN (asiantuntijaryhmien koordinaatio ja toimintamallien jalkautus/käyttöönoton tuki alueilla) yhteistyössä Työterveyslaitoksen sekä Suomen palliatiivisen lääketieteen yhdistyksen kanssa, hyvinvointialueet ja HUS (toimintamallien käyttöönotto).

58 Työterveyslaitos. TYÖOTE-toimintamalli.
59 UKK-instituutti. Liikkumisresepti.

Resurssi: Ehdotettu määräraha 1 140 000 €. Rahoitus kohdennetaan kansallisten asiantuntijaryhmien työskentelyyn ja koordinaatioon toimintamallien laatimiseksi. Lisäksi rahoitusta kohdennetaan toimintamallien käyttöönoton ja käytön tukeen alueilla.

Aikataulu:
2026–2028: TYÖOTE-malli ja HYVA-palvelupolun käyttöönoton suunnittelu aloitettu; toimintamalli kuntoutuksen ja fyysisen aktiivisuuden/liikunnan huomioimiseksi osana hoitoa -laadittu; palliatiivisen hoidon ohjeistukset ja mallit luotu.
2029–2031: Toimintamallit integroitu syöpäkohtaisiin hoitoketjuihin ja käytössä 70 %:ssa hyvinvointialueista.

Mittari: Niiden syöpäpotilaiden osuus, joille laadittu yksilöllinen suunnitelma kuntoutumisen tueksi (%).

Mittari: Levinnyttä syöpää sairastavien potilaiden osuus, joille laadittu elämän loppuvaiheen ennakoiva hoitosuunnitelma (%).

Mittari: Levinnyttä syöpää sairastavien potilaiden osuus, joilla palliatiivinen hoito aloitettu jo sairauden hoidon rinnalla (%).

Mittari: Syöpäpotilaiden osuus, jotka saivat syöpään kohdistuvaa hoitoa viimeisen elinkuukauden aikana (%).

Toimenpide 3.3.4 Selvitetään sosiaaliturvauudistuksen yhteydessä syöpään sairastuneiden erityiset toimeentulon haasteet ja tarvittavat toimenpiteet sekä syöpäpotilaiden lainojen ja vakuutusten saantiin liittyvät säädösmuutostarpeet Suomessa (Oikeus tulla unohdetuksi -lainsäädäntö)

Selvitetään työryhmässä syöpään sairastuneiden erityiset toimeentulon haasteet, ja laaditaan toimenpide-ehdotukset sosiaaliturvan pirstaleisuuden parantamiseksi. Viedään toimenpiteet osaksi sosiaaliturvauudistusta.

Selvitetään Oikeus tulla unohdetuksi -lainsäädännön tarvetta Suomessa, ja kartoitetaan tarvittavat lait ja säädökset, joilla varmistetaan syövästä selviytyneiden yhdenvertainen pääsy rahoituspalveluihin kuten asuntolainoihin, muihin lainoihin ja vakuutuksiin. Kartoitetaan toimintatapoja ja niiden vaikutuksia muissa Euroopan maissa, jossa on Oikeus tulla unohdetuksi -tyyppistä lainsäädäntöä.

Toteutus: Kootaan kansallinen työryhmä selvittämään syöpään sairastuneiden erityiset toimeentulon haasteet ja tekemään toimenpide-ehdotukset seuraavalle hallitukselle sekä toteuttamaan selvitykset Oikeus tulla unohdetuksi -lainsäädäntötarpeiden osalta. Työryhmään osallistuvat STM, OM, potilasjärjestöt, viranomaiset, pankit ja vakuutusyhtiöt.

Vastuutaho: Syöpäjärjestöt sekä potilasjärjestöt, STM, THL, Kela, Valvira, Finanssialan keskusliitto.

Resurssi: Arvioitu tarvittava määräraha 50 000 €. Rahoitusta kohdennetaan työryhmän työskentelyyn ja selvityksen laatimiseen. Mahdolliset lainsäädäntötarpeet toteutetaan virkatyönä.

Aikataulu:
2026–2028: Syöpäsairauden taloudellinen vaikutus yksilötasolla selvitetty ja huomiot viety sosiaaliturvauudistuksen valmisteluun; Oikeus tulla unohdetuksi -lainsäädännön tarve on selvitetty ja lainsäädäntövalmistelu aloitettu.
2029–2031: Syöpäpotilaiden erityistarpeet on huomioitu sosiaaliturvauudistuksessa; Syöpään sairastuneiden yhdenvertaisuus on lailla varmistettu lainojen ja vakuutusten yhteydessä.

Mittari: Syöpään sairastuneiden näkökulmat huomioidaan sosiaaliturvaa uudistettaessa.

Mittari: Oikeus tulla unohdetuksi -lainsäädännön valmistelu etenee.

3.4 Toimintakykytieto ohjaa ikääntyneiden syöpäpotilaiden diagnostiikkaa ja hoitoa

Toimenpide 3.4.1 Otetaan systemaattinen toimintakyvyn arviointi käyttöön kaikissa iäkkäitä syöpäpotilaita hoitavissa yksiköissä

Geriatrisen arvioinnin hyödyistä syöpäpotilaan hoidossa on vahvaa näyttöä[60, 61, 62, 63, 64, 65]. Potilaat ohjautuvat geriatriseen arvioon G8-seulalla[66], joka otetaan systemaattiseen käyttöön kaikissa syöpää hoitavissa yksiköissä. Seulonnasta normaalin tuloksen saaneet ohjataan suoraan hoitovastuussa olevan lääkärin vastaanotolle. Poikkeavan tuloksen saaneet ohjataan sairaanhoitajan ja geriatrin vastaanotolle kokonaisvaltaiseen arvioon,

60 M. Hamaker ym. Geriatric assessment in the management of older patients with cancer – A systematic review (update). Journal of Geriatric Oncology, vol. 13, no. 6, pp. 761–777, Jul. 2022.
61 D. Li. ym. “Geriatric Assessment–Driven Intervention (GAIN) on Chemo-therapy-Related Toxic Effects in Older Adults With Cancer: A Randomized Clinical Trial,” JAMA Oncol, vol. 7, no. 11, p. e214158, Nov. 2021.
62 P.Soubeyran, ym. Screening for vulnerability in older cancer patients: the ONCODAGE Prospective Multicenter Cohort-Study. PLoS One. 2014;9:e115060.
63 W.K. Soo, ym. Integrated Geriatric Assessment and Treatment Effectiveness (INTEGERATE) in older people with cancer starting systemic anticancer treatment in Australia: a multicentre, open-label, randomised controlled trial. Lancet Heal Longev. 2022;3:e617–27.
64 S.G. Mohile, ym. Communication With Older Patients With Cancer Using Geriatric Assessment. JAMA Oncol. 2020;6:196.
65 S. Akseer S, et al: Cost-Utility of Geriatric Assessment and Management in Older Adults With Cancer: Model-Based Economic Evaluation. J Clin Oncol 44:92–102, 2026.
66 R. Laine, ym. Geriatriset oireyhtymät ovat yleisiä iäkkäillä syöpäpotilailla. Suom Lääkäril 2022;77:e32141.

jota hyödynnetään syövän hoidon päätöksenteossa. Arvion pohjalta laaditaan yksilöllinen hoito- ja kuntoutussuunnitelma. Siinä huomioidaan potilaan muiden sairauksien ja geriatristen oireyhtymien hoito, ja se sisältää usein huomioita ravitsemustilan kohentamisesta ja liikunnallisen aktiivisuuden tukemisesta sekä tarvittavista tukipalveluista. Tarvittaessa potilas ohjataan ravitsemusterapeutin, fysioterapeutin tai sosiaalityöntekijän vastaanotolle.

Vastuutaho: Hyvinvointialueet ja HUS.

Resurssi: Arvioitu tarvittava määräraha 750 000 €. Resurssi kohdennetaan selvitystyöhön ja toimintamallien käyttöönottoon.

Aikataulu:
2026–2028: Geriatris-onkologisten toimintamallien pystyttäminen ja kouluttaminen.
2029–2031: Geriatris-onkologisten toimintamallien vakiintuminen kattaen kaikki hoidon tasot ja ammattiryhmät. Ammattilaisten kouluttamisen vakiintuminen ja laajentaminen.

Mittari: G8-seulan käyttö ja sen hyödyntäminen syövänhoidon eri aloilla. Niiden syöpää hoitavien yksiköiden määrä Suomessa, joissa toteutetaan iäkkäiden potilaiden geriatrista seulontaa ja arviointia (%).

Toimenpide 3.4.2 Toimintakykytietoa kerätään jo perusterveydenhuollossa ja se kirjataan lähetteeseen

Syöpäepäily herää usein perusterveydenhuollossa, joka vastaa myös esikuntoutuksesta (prehabilitaatio), jatkohoidosta ja kuntoutuksesta. Perusterveydenhuollon lääkäri kuvaa lähetteessä sanallisesti ja käytössä olevilla testeillä (G8, Clinical Frailty Scale) potilaan toimintakyvyn, jonka tulee ohjata diagnostisten tutkimusten suunnittelua erikoissairaanhoidossa. Perusterveydenhuollon lääkärillä tulisi olla mahdollisuus konsultoida geriatris-onkologista tiimiä jo diagnostisessa vaiheessa.

Vastuutaho: Hyvinvointialueet, HUS ja Helsingin kaupunki, sekä niiden perusterveydenhuollosta ja syövänhoidosta vastaavat yksiköt.

Resurssi: Arvioitu tarvittava määräraha 1 000 000 €. Resurssi kohdennetaan alueellisiin koulutuksiin, täydennyskoulutuksiin ja ohjeistuksiin.

Aikataulu:
2026–2028: Systemaattisen toimintakykytiedon laatukriteeristön luominen.
2029–2031: Toimintamallin jalkauttaminen kaikille hyvinvointialueille ja HUSiin.

Mittari: Toimintakykytiedon sisältyminen lähetteisiin.

Toimenpide 3.4.3 Lisätään geriatris-onkologisten potilaiden toimintakyvyn kokonaisvaltaista arviointia hoitoketjun eri vaiheissa

Syövänhoitoon osallistuvat useat erikoisalat, kuten syöpätaudit, hematologia, keuhkosairaudet ja kirurgiset alat gynekologia mukaan lukien. Valtaosa hoitosuosituksista tehdään monialaisissa tiimeissä (multidisciplinary team, MDT). Geriatrin osallistuminen MDT-kokouksiin on suositeltavaa varsinkin raskasta ja vaativaa kirurgiaa suunniteltaessa. Syövänhoitoon osallistuvilla aloilla suositellaan geriatrisia ongelmia seulovan G8-testin käyttöönottoa (ks. toimenpide 3.4.1).

Ikääntyneiden syöpäpotilaiden hoitopäätökset perustuvat toimintakyvyn laaja-alaiseen arviointiin, eivätkä yksinomaan ikään tai toimintakyvyn subjektiiviseen arviointiin (ECOG). Hauraiden potilaiden kliinistä arviointia ja osallistamista jaettuun päätöksentekoon ennen invasiivisia toimenpiteitä lisätään. Jo syöpäepäilyn yhteydessä arvioidaan potilaan kokonaistilanne ja toimintakyky G8-seulaa hyödyntäen. Mikäli iäkäs potilas on hyvin hauras, on tärkeää arvioida invasiivisten diagnostisten tutkimusten hyöty suhteessa niiden aiheuttamaan kärsimykseen.

Vastuutaho: Hyvinvointialueet ja HUS.

Resurssi: Arvioitu tarvittava määräraha 1 000 000 €. Resurssia kohdennetaan erikoissairaanhoitovetoisten geriatris-onkologisten tiimien toimintaan hyvinvointialueilla.

Aikataulu:
2026–2028: G8-seulan käyttö ja sen hyödyntäminen syövänhoidon eri aloilla on lisääntynyt.
2029–2031: Perusterveydenhuollolla mahdollisuus konsultoida geriatrisen onkologian tiimiä jo syövän diagnostiikkavaiheessa.

Mittari: Niiden hyvinvointialueiden osuus, jossa kaikille soveltuville ikääntyneille syöpäpotilaille tehdään geriatris-onkologinen arviointi (%).

Mittari: Niiden hyvinvointialueiden osuus, joissa perusterveydenhuollolla on mahdollisuus konsultoida geriatrisen onkologian tiimiä jo syövän diagnostiikkavaiheessa (%).

3.5 Riittävä ja osaava henkilöstö varmistaa vaikuttavan ja ihmislähtöisen syövän hoidon

Toimenpide 3.5.1 Luodaan kestävät strategiat syövän hoitoon osallistuvan henkilöstön riittävyyden varmistamiseksi

Arvioidaan syövän diagnostiikkaan (erityisesti molekyylidiagnostiikkaan) ja hoitoon osallistuvien ammattilaisten resurssi- ja koulutustarve realistisesti. Arvion pohjalta

koulutustarpeet ja -resurssit suunnitellaan vastaamaan tätä tarvetta, ja turvataan näin palveluiden valmius syövän kehittyvän diagnostiikan ja hoidon kasvaviin vaatimuksiin. Varmistetaan, että kaikilla alueilla on riittävästi osaavaa henkilöstöä, jotta potilaat saavat tarvitsemaansa hoitoa asuinpaikasta riippumatta.

Toteutus: Varmistetaan syövän hoitoon osallistuvan henkilöstön riittävyys osana STM:n Hyvän työn ohjelman[67] toimeenpanoa hyödyntämällä siinä toteutettuja ja valmisteilla olevia kansallisia henkilöstö- ja koulutustarveselvityksiä[68]. Selvitys erikoislääkärikoulutuksen tarpeesta ohjelman puitteissa on aloitettu, aikaisempi selvitys[69] on laadittu vuonna 2022. Riittävien molekyylidiagnostiikan resurssien varmistamiseksi laaditaan selvitys sairaalageneetikkojen ja -solubiologien (terveydenhuollon nimikesuojattuihin ammatteihin johtavat koulutukset) koulutustarpeista. Huolehditaan, että selvityksissä esiin nousseet syövän hoitoon osallistuvan henkilöstön resurssitarpeet huomioidaan koulutusmäärien mitoituksessa.

Lisäksi alueilla kehitetään ja toimeenpannaan ratkaisuja, joilla varmistetaan syövän hoidon ammattilaisten riittävä määrä ja osaaminen erityisesti syrjäseuduilla. Tällaisia ratkaisuja ovat esimerkiksi syövän hoidon osaamisalueisiin kohdennettu rekrytointi (sitouttamissopimukset, yhdistelmävirat tai taloudelliset kannustimet alueille), erikoistumiskoulutuksen vahvistaminen (virkapohjien ja koulutuspaikkojen lisääminen), kiertävät asiantuntijamallit sekä digitaaliset-/etäratkaisut (esim. patologian lausunnot, hoidon suunnittelu) sekä koulutuksen alueellisesta kattavuudesta huolehtiminen läsnäoloa vaativissa koulutuksissa.

Vastuutaho: Terveydenhuollon ammattihenkilöiden neuvottelukunta[70] ja sen alaiset erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen sekä yleislääketieteen erityiskoulutuksen koordinaatiojaosto 2026–2029[71] sekä hoitohenkilöstön koulutuksen koordinaatiojaosto 2024–26[72]; Hyvän työn ohjelma (selvitysten toteuttaminen); yliopistot ja ammattikorkeakoulut (koulutuksen järjestäminen ja osaamisen arviointi); yliopistosairaalat ja hyvinvointialueet (koulutuspaikkojen järjestäminen ja alueellisten ratkaisujen kehittäminen).

Resurssi: Arvioitu tarvittava määräraha 8 500 000 €. Rahoitusta kohdennetaan tarvittavien syövän hoitoon ja tutkimukseen osallistuvien terveydenhuollon ammattihenkilöiden koulutusmäärien lisäämiseen ja vahvistamiseen sekä koulutus- ja ohjausresurssien vahvistamiseen.

67 Sosiaali- ja terveysministeriö. Hyvän työn ohjelma – Vetoa ja pitoa sote-alalle.
68 L. Karhe, ym. Kliinisesti erikoistuneiden sairaanhoitajien ennakoitu tarve vuosille 2024–2028 Selvitystyö. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2024:9.
69 J. Rellman, ym. Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäritilanne ja koulutustarve vuoteen 2035. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2022:21.
70 Sosiaali- ja terveysministeriö. Terveydenhuollon ammattihenkilöiden neuvottelukunta 2023-2026.
71 Sosiaali- ja terveysministeriö. Erikoislääkäri-ja erikoishammaslääkärikoulutuksen sekä yleislääketieteen erityiskoulutuksen koordinaatiojaosto 2026-2029.
72 Sosiaali- ja terveysministeriö. Hoitohenkilöstön koulutuksen koordinaatiojaosto 2024-26.

Aikataulu:
2026–2028: Erikoislääkärikoulutuksen tarveselvitys valmistuu; selvitys sairaalageneetikkojen ja -solubiologien koulutustarpeesta laaditaan; syövän hoidon henkilöstötarpeet huomioidaan koulutusmäärien suunnittelussa ja rahoituksen valmistelussa osana Hyvän työn ohjelmaa; hyvinvointialueet laativat suunnitelmat syövän hoidon henkilöstön riittävyyden turvaamiseksi syrjäseuduilla.
2029–2031: Koulutusmäärien ja erikoistumiskoulutuksen mahdolliset lisäykset toteutuvat ja syöpätautien diagnostiikkaan ja hoitoon osallistuvien terveydenhuollon ammattilaisten koulutustarve on sovitettu yhdessä koulutusta antavien oppilaitosten kanssa tarve-ennustetta vastaavalle tasolle. Alueelliset ratkaisut ovat käytössä kaikilla hyvinvointialueilla. Arvioidaan toimenpiteiden vaikutukset henkilöstövajeisiin ja alueellisiin eroihin.

Mittari: Ammattilaisten alueellinen jakautuminen, sairauspoissaolot ja työtyytyväisyyskyselyt.

Toimenpide 3.5.2 Kehitetään ja lisätään syövän hoitoon osallistuvien ammattilaisten jatkuvaa koulutusta ja erikoistumismahdollisuuksia sekä määritellään kansalliset yhtenäiset ammatti- ja tehtävänimikkeet

Syövän hoidon parissa työskentelevien ammattilaisten jatkuvaa koulutusta ja erikoistumismahdollisuuksia vahvistetaan kaikissa keskeisissä ammattiryhmissä. Koulutusta kehitetään vastaamaan työelämän tarpeita, syövän diagnostiikan ja hoidon kehittyviä käytäntöjä (mukaan lukien digitaaliset työkalut, tekoälyn hyödyntäminen ja yksilöllinen hoito) sekä moniammatillisen työskentelyn vaatimuksia.

Toteutus:
Erikoislääkärikoulutus. Selvitetään uusien syövän varhaiseen toteamiseen ja hoitoon liittyvien erikoislääkärikoulutuksen lisäkoulutusohjelmien perustamistarvetta, ja laaditaan ehdotukset uusien ohjelmien perustamisesta selvitykseen perustuen.

Hoitohenkilöstö ja muut ammattiryhmät. Varmistetaan syövän hoitoon osallistuvan hoitohenkilöstön (mm. sairaanhoitajat, kätilöt, fysioterapeutit, toimintaterapeutit, röntgenhoitajat, bioanalyytikot) erikoistumiskoulutuksen, asiantuntijanimikkeiden ja uramallien kehittäminen osana hoitohenkilöstön erikoistumiskoulutusta koskevan selvitysraportin[73] pohjalta valmisteilla olevaa toimenpideohjelmaa. Ohjelman tavoitteena on varmistaa väestön palvelutarpeita vastaava hoitohenkilöstön erikoisosaaminen ja asiantuntijarakenteiden kehittyminen.

Sairaalageneetikot ja sairaalasolubiologit. Varmistetaan sairaalageneetikkojen ja sairaalasolubiologien riittävät koulutusmäärät vaativan molekyylidiagnostiikan tarpeisiin.

73 M. Välimäki, ym. Hoitohenkilöstön erikoistumiskoulutus: Nykytilanne ja toimenpide-ehdotukset. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2025:7.

Vastuutaho: Hoitohenkilöstön koulutuksen koordinaatiojaosto (valmisteilla olevan hoitohenkilöstön erikoistumiskoulutuksen toimenpideohjelman valmistelu syövän hoidon osaamis- ja erikoistumistarpeet huomioiden), erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen sekä yleislääketieteen erityiskoulutuksen koordinaatiojaosto 2026–2029, valtakunnallinen ammatillisen jatkokoulutuksen toimikunta VAJT yhteistyössä erikoisala- ja hoitajayhdistysten kanssa (lisäkoulutusohjelmien tarpeen arviointi ja kehittämisehdotukset), yliopistot ja ammattikorkeakoulut (koulutuksen toteutus ja osaamisen arviointi), hyvinvointialueet ja HUS, FICAN (osaamisen ja hyvien käytänteiden jakaminen valtakunnallisesti).

Resurssi: Valmistelu toteutetaan virkatyönä osana STM:n koordinaatiojaostojen sekä VAJT:n toimintaa. Hoitohenkilöstön erikoistumiskoulutusta koskevassa toimenpideohjelmassa sekä erikoislääkärien lisäkoulutusohjelmia koskevassa selvityksessä määritellään tarkemmin tarvittavat koulutusmäärät. Tarvittavien koulutuskokonaisuuksien toteutumisen varmistamiseksi hyvinvointialueet ja HUS varaavat riittävät resurssit henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja hyödyntävät korkeakoulujen tarjoamaa täydennyskoulutusta.

Aikataulu:
2026–2028: Syöpätautien diagnostiikkaan ja hoitoon liittyvät lisäkoulutusohjelmat on kartoitettu ja uusien koulutusohjelmien tarve arvioitu; syövän hoitohenkilöstölle on luotu yhteneväiset nimikkeet ja osaamisvaatimukset; erikoistumiskoulutusten sisältöjen kehittäminen työelämän tarpeita vastaavaksi on käynnissä.
2029–2031: Syöpätautien diagnostiikkaan ja hoitoon liittyvät lisäkoulutusohjelmat on käynnistetty tarpeen mukaisesti; syövän hoitohenkilöstön erikoistumiskoulutusten sisällöt on päivitetty.

Mittari: Valmistuneiden ja erikoistumiskoulutuksen suorittaneiden määrä vuosittain.

Toimenpide 3.5.3 Edistetään digitaalisten työkalujen, tekoälyn ja innovaatioiden käyttöönottoa ja kehittämistä syövän hoidossa

Digitaalisten työkalujen tavoitteena on vahvistaa syövän varhaista toteamista sekä hoidon jatkuvuutta koko potilaan hoitopolulla perusterveydenhuollosta erikoissairaanhoitoon, parantaa moniammatillista yhteistyötä, tukea hoidon koordinaatiota ja lisätä potilaiden mahdollisuuksia osallistua omaan hoitoonsa. Digitaaliset ratkaisut, kuten digitaaliset hoitopolut ja niihin integroitava etäseuranta, oirearviointi ja omahoitosovellukset sekä etävastaanotot, helpottavat potilaiden seurantaa ja yksilöllisen ohjauksen toteutusta. Lisäksi ne tukevat yhdenvertaista hoitoa erityisesti alueilla, joissa erikoisosaamista on saatavilla rajallisesti. Edistetään digitaalisten hoitopolkujen ja muiden relevanttien työkalujen käyttöönottoa kaikilla hyvinvointialueilla hyödyntäen olemassaolevia kansallisia alustoja ja digihankkeita. Toteutuksessa huomioidaan digitaalisten palveluiden potilasturvallisuus, käyttäjäystävällisyys ja saavutettavuus.

Tuetaan tekoälyn tarjoamia mahdollisuuksia syövän varhaisessa toteamisessa, hoidossa ja tutkimuksessa.

Toteutus: Selvitetään syövän hoidossa käytössä olevien digihoitopolkujen nykytila. Määritellään digitaalisten hoitopolkujen rakenne, vähimmäissisällöt, keskeiset mittarit ja toiminnallisuudet kansallisesti yhteistyössä asiantuntijaverkostojen kanssa. Otetaan potilaan diagnostiikkaa, hoitoa ja seurantaa tukevat digitaaliset hoitopolut käyttöön osana hyvinvointialueella käytössä olevia teknisiä ratkaisuja ja integroidaan ne osaksi käytössä olevia tietojärjestelmiä ja palvelutuotantoa. Hoitopolkujen lisäksi määritellään muut kansallisesti priorisoitavat syövän varhaisen toteamisen ja hoidon digitaaliset menetelmät, kuten tekoälyyn pohjautuvat ratkaisut, sekä varmistetaan niiden liittäminen käynnissä oleviin kansallisiin ja alueellisiin hankkeisiin (esimerkiksi lainsäädäntöhanke ennakoivan soten mahdollistamiseksi[74]) sekä tiekartan osatavoitteeseen 2.5.

Vastuutaho: FICAN (kansallinen digitaalisten työkalujen ja tekoälypohjaisten ratkaisujen selvitys- ja kehitystyö ja käyttöönoton tuki alueilla), hyvinvointialueet, HUS ja Helsingin kaupunki (työkalujen käyttöönotto).

Resurssi: Arvioitu tarvittava määräraha 1 140 000 €. Rahoitusta kohdennetaan digitaalisten hoitopolkujen ja tekoälypohjaisten työkalujen selvitys- ja kehitystyöhön sekä käyttöönoton tukeen alueilla.

Aikataulu:
2026–2028: Digitaalisten hoitopolkujen ja tekoälypohjaisten ratkaisujen nykytila kartoitettu; kansallinen määrittelytyö tehty; priorisoitujen syöpäryhmien osalta kehitystyö ja rajattu pilotointi käynnistetty osassa hyvinvointialueita.
2029–2031: Digitaalisten hoitopolkujen käyttöönotto laajenee vaiheittain eri syöpäryhmiin ja hyvinvointialueille; ehdotukset muiden tekoälypohjaisten ja digitaalisten ratkaisujen käyttöönottoon ja pilotointiin syövän hoidossa laadittu.

Mittari: Digitaalisten hoitopolkujen ja tekoälysovellusten käyttöaste syöpää hoitavissa yksiköissä.

Toimenpide 3.5.4 Vahvistetaan psykososiaalisen tuen, kuntoutuksen, geriatrisen onkologian ja palliatiivisen hoidon osaamista kaikissa syövän hoidon vaiheissa

Vahvistetaan psykososiaalisen ja kuntoutumisen tuen sekä ikääntyneiden syöpäpotilaiden hoidon osaamista kehittämällä lääketieteen, hoitotyön sekä muiden syövän

74 Valtioneuvosto. Lainsäädäntöhanke ennakoivan sosiaali- ja terveydenhuollon mahdollistamiseksi (ennakoiva sote 2).

hoitoon osallistuvien sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten perus- ja erikoistumiskoulutusten sisältöä. Geriatrisen onkologian osaaminen tulee liittää osaksi geriatrian ja onkologian erikoislääkärien koulutusta.

Perus- ja erikoistumiskoulutusten lisäksi syövän hoidon ammattilaisille varmistetaan säännölliset STM:n asetukseen perustuvat täydennyskoulutukset, jotka käsittelevät psykososiaalista tukea, kuntoutusta, palliatiivista hoitoa ja ikääntyneiden potilaiden hoitoa. Näin vahvistetaan moniammatillista yhteistyötä, osaamista ja kykyä vastata potilaiden tarpeisiin hoitoketjun kaikissa vaiheissa.

Toteutus: Laaditaan selvitys psykososiaalisen ja kuntoutumisen tuen sekä ikääntyneiden syöpäpotilaiden hoidon opetuksen nykytilasta sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten perus- ja erikoistumiskoulutuksissa. Selvityksen pohjalta laaditaan suositukset ja integroidaan tarvittavat opintokokonaisuudet sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten perus- ja erikoistumiskoulutuksiin. Laaditaan ja integroidaan geriatrisen onkologian opintokokonaisuudet osaksi geriatrian ja onkologian erikoislääkärikoulutusta Euroopan geriatrian erikoislääkärien koulutussuositusten mukaisesti, ja luodaan geriatriaan ja onkologiaan erikoistuville lääkäreille koulutuspaikkoja, joissa he oppivat geriatrisen onkologian perusteet.

Rakennetaan ja toteutetaan täydennyskoulutusta osana hyvinvointialueiden järjestämisvastuuta yhteistyössä psykososiaalisen tuen, kuntoutuksen, palliatiivisen hoidon sekä geriatrisen onkologian asiantuntijoiden sekä koulutusorganisaatioiden kanssa. Täydennyskoulutukset integroidaan osaksi ammattilaisten jatkuvaa oppimista (täydennyskoulutussuunnitelmat), ja niiden toteutusta seurataan ja arvioidaan säännöllisesti.

Vastuutaho: Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen sekä yleislääketieteen erityiskoulutuksen koordinaatiojaosto 2026–2029 sekä hoitohenkilöstön koulutuksen koordinaatiojaosto 2024–2026, yliopistot ja ammattikorkeakoulut, HUS ja hyvinvointialueet.

Resurssi: Arvioitu tarvittava määräraha 1 500 000 €. Rahoitusta kohdennetaan geriatrisen onkologian, psykososiaalisen tuen ja kuntoutuksen opintokokonaisuuksien kehittämiseen sekä täydennyskoulutuksen valtakunnalliseen sisällölliseen rakentamiseen myös palliatiivinen hoito huomioiden. Selvitykset ja kansallisten osaamislinjausten valmistelu toteutetaan virkatyönä STM:n ja koordinaatiojaostojen toimesta. Opintokokonaisuuksien integrointi toteutetaan korkeakoulujen normaalina opetussuunnitelmatyönä. Täydennyskoulutus toteutetaan hyvinvointialueiden järjestämisvastuulla osana lakisääteistä täydennyskoulutusta.

Aikataulu:
2026–2028: Psykososiaalisen tuen, kuntoutuksen, palliatiivisen hoidon ja geriatrisen onkologian opetuksen nykytila kartoitettu; kansalliset osaamissuositukset ja opintosisältölinjaukset laadittu; geriatrisen onkologian osaamiskokonaisuus määritelty ja

integroitu geriatrian erikoislääkärikoulutuksen linjauksiin; uusien opintokokonaisuuksien suunnittelu käynnistetty
2029–2031: Opintokokonaisuudet sisältyvät korkeakoulujen opetussuunnitelmiin; geriatris-onkologinen osaamiskokonaisuus määritelty ja integroitu onkologian erikoislääkärikoulutuksen linjauksiin; geriatriseen onkologiaan liittyvä koulutus toteutuu geriatrian erikoislääkärikoulutuksessa; täydennyskoulutus toteutuu systemaattisesti kaikilla hyvinvointialueilla

Mittari: Geriatrisen onkologian sisältyminen geriatrian erikoislääkärikoulutukseen

Toimenpide 3.5.5 Käynnistetään palliatiivisen lääketieteen erikoislääkärikoulutus

Käynnistetään palliatiivisen lääketieteen erikoislääkärikoulutus tukemaan palliatiivisen hoidon laadun ja osaamisen kehittämistä kansallisesti. Koulutuksen myötä Suomeen saadaan yliopistotasoisesti koulutettuja erikoislääkäreitä, joilla on valmiudet toimia palliatiivisen hoidon asiantuntijoina, kehittäjinä ja kouluttajina. Alan erikoislääkärit vastaavat väestön kasvavaan laadukkaan palliatiivisen hoidon tarpeeseen palliatiivisen lääketieteen kehittyvät hoitomuodot huomioiden. Koulutuksen myötä palliatiivisen lääketieteen erikoisala vakiinnuttaa asemansa osana terveydenhuollon rakenteita ja tukee myös tutkimuksen ja koulutuksen kansallista kehittämistä.

Toteutus: Arvioidaan palliatiivisen lääketieteen erikoislääkärikoulutuksen perustamisen palvelujärjestelmälliset, koulutukselliset ja taloudelliset edellytykset mahdolliset terveydenhuoltolain muutokset (saattohoito) ja palliatiivisen hoidon palvelurakenteen kehitys huomioiden. Sosiaali- ja terveysministeriölle on tehty aloite palliatiivisen erikoisalan perustamisesta. Uuden lääketieteen erikoisalan perustamisen arviointi on käsittelyssä sosiaali- ja terveysministeriössä ja erikoislääkärikoulutusta koordinoivissa elimissä. Valmistellaan tarvittavat säädösmuutokset erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksesta annettuun asetukseen. Käynnistetään yhteistyössä yliopistojen ja koulutuspaikkojen kanssa palliatiivisen lääketieteen erikoislääkärikoulutus mukaan lukien siirtymävaiheen järjestelyt erityispätevyyden suhteen. Laaditaan erikoislääkärikoulutuksen opetussuunnitelma, jossa huomioidaan parantumattomasti sairaiden syöpäpotilaiden hoito varhainen integroitu palliatiivinen hoito mukaan lukien.

Vastuutaho: STM:n erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen sekä yleislääketieteen erityiskoulutuksen[75] koordinaatiojaosto ja yliopistojen ammatilliset jatkokoulutustoimikunnat ja professorit, yhteistyötahoina erikoisalayhdistykset, Suomen Lääkäriliitto ja muut tarvittavat sidosryhmät.

75 Sosiaali- ja terveysministeriö. Erikoislääkäri-ja erikoishammaslääkärikoulutuksen sekä yleislääketieteen erityiskoulutuksen koordinaatiojaosto 2026-2029.

Resurssi: Arvioitu tarvittava määräraha 3 000 000 €. Rahoitusta kohdennetaan koulutuskorvausjärjestelmän vahvistamiseen (erikoistumisvirat) sekä opetuksellisten ja kliinisten koulutusresurssien lisäämiseen. Valmisteluvaihe toteutetaan pääosin virkatyönä.

Aikataulu:
2026–2028: Koordinaatiojaoston arvio ja esitys annettu; asetusmuutos hyväksytty; koulutusrakenne ja valtakunnallinen koulutusverkosto suunniteltu; ensimmäiset koulutuspaikat valmisteltu; opetussuunnitelma laadittu; ensimmäinen erikoislääkärikoulutuksen hakukierros käynnistynyt.
2029–2031: Palliatiivisen lääketieteen erikoislääkärikoulutus käynnissä.

Mittari: Perustettu palliatiivisen lääketieteen erikoislääkärikoulutus.

4. Aallonharjalla muuttuvassa toimintaympäristössä

4.1 Kansallinen terveyden tietovaranto ja kehittynyt analytiikka tukevat syövän tutkimusta ja tiedon hyödyntämistä

Toimenpide 4.1.1 Kehitetään palvelujärjestelmän toimintaa mahdollistamaan syöpätiedon ja muun terveystiedon yhdenmukainen rakenteellinen kirjaaminen ja harmonisointi

Yhdenvertaisuus ja hoidon vaikuttavuus ovat kansallisen syöpästrategian keskeisiä tavoitteita. Tietojen yhdenmukainen ja rakenteinen kirjaaminen on välttämätöntä, jotta syöpäpotilaiden hoitopolkuja ja -tuloksia voidaan vertailla systemaattisesti ja valtakunnallisesti. Tämä luo perustan laadukkaalle hoidon seurannalle ja vahvistaa syöpätutkimuksen edellytyksiä.

Toimenpiteen osana määritellään kansallisesti yhteiset tietosisällöt, rakenteet ja kirjaamiskäytännöt (esim. FHIR, OMOP), jotka ohjaavat syöpä- ja muun terveystiedon kirjaamista kaikilla hyvinvointialueilla ja HUSissa. Tekoälypohjaisia menetelmiä hyödynnetään laajalti tukemaan rakenteisen syöpätiedon tuottamista ja harmonisointia osana kansallisesti ja kansainvälisesti yhteensopivaa terveystietomallia. Sitran STM:n kanssa yhteistyössä ehdottama kansallinen terveystietoalue[76] Finnish Health Data Space (FHDS) ja sen datainfrastruktuuri (FHDS-Tieto) muodostavat työlle laajan viitekehyksen. Kansalliset kliiniset valmisaineistot olisivat hyödyllinen resurssi hoidon vaikuttavuuden lähes reaaliaikaisessa seurannassa sekä kansallisen laaturekisterityön tukena. Myös syöpätiedon hyödyntämistä tietojohtamisen tukena hyvinvointialueilla tulee edistää ja pyrkiä kansallisesti yhteensopiviin ratkaisuihin.

76 O. Kallioniemi ja K. Porkka 2026. Terveystiedon tulevaisuus tekoälyn aikakaudella. Sitran selvityksiä 255.

FHDS-tavoitetta edistetään Helsingin yliopiston johtamassa, vuonna 2026 käynnistyneessä hankkeessa ”Kohti suomalaista terveystietoaluetta”[77], jossa luodaan toimintamalli terveystiedon hyödyntämiseen tutkimuksessa ja kehitystyössä, kehitetään ratkaisuja datan yhdistämiseen, nopeutetaan lupaprosesseja ja vähennetään hallinnosta kuormaa sekä hyödynnetään tekoälyä sairauksien etenemisen ja hoitovaikutusten arvioinnissa. Hanke on osa Business Finlandin rahoittamaa Orionin Veturi-ohjelmaa ja sen budjetti on 7,7 miljoonaa euroa.

Vastuutaho: Hyvinvointialueet, Helsingin kaupunki ja HUS, THL, kansalliset monialaiset syöpäryhmät.

Resurssi: Tekoälypohjainen, kattavasti kirjaamista tukeva kehitystyö toteutetaan kaikilla hyvinvointialueilla valtion rahoituksella, joka on riippuvainen ja suhteessa siihen, miten tietovarantoon tuotetaan tietoa. Arvioitu kustannus on 1 750 000 € (350 000 € vuodessa viiden vuoden ajan). Tällä summalla saadaan palkattua osa-aikainen työntekijä kullekin hyvinvointialueelle, Helsingin kaupungille ja HUSiin osallistumaan kirjaamiskäytäntöjen kehittämiseen. Toteutus vaatii lisäksi potilastietojärjestelmien kehittämistä. FHDS-mallin rakennus toteutetaan erillisellä rahoituksella.

Aikataulu:
2026–2028: Kansallinen, rakenteellinen, yleisiä syöpiä koskeva tekoälyä hyödyntävä tietomalli on valmis. Pääosa tietovarantoon talletettavista tiedoista tuotetaan datalähtöisesti; manuaalinen kirjaaminen on käytössä niiden muuttujien osalta, joita on haastavaa tuottaa muuten (esimerkiksi potilaan kuntoisuus, syövän levinneisyys ja hoitovasteet).
2029–2031: Kansallinen, rakenteellinen, kaikkia syöpiä koskeva tietomalli on valmis.

Mittari: Kansallisen, rakenteeltaan yhdenmukaisen kirjaamispohjan käytön laajuus (tavoite: kahden vuoden kuluttua 30 %, viiden vuoden kuluttua 60 %, 10 vuoden kuluttua 100 % syöpätapauksista).

Mittari: Ilman manuaalista tietojen syöttöä tapahtuvan kirjauksen laajuus (tavoite: kahden vuoden kuluttua 30 %, viiden vuoden kuluttua 60 %, 10 vuoden kuluttua 80 % syöpätapauksista).

Mittari: Yhdenmukaisesti ja kattavilla tiedoilla kirjattujen erikoissairaanhoidon potilaiden osuus (tavoite: kahden vuoden kuluttua 50 %, viiden vuoden kuluttua 100 % syöpätapauksista).

77 Helsingin yliopisto. Suomi kehittää uutta tapaa hyödyntää terveystietoa – tavoitteena parempaa hoitoa ja nopeampaa tutkimusta. Uutinen 25.5.2026.

Toimenpide 4.1.2 Mahdollistetaan lainsäädännöllisesti ja resurssoinnin osalta syövän tietovarannon pitkäjänteinen toiminta osana kansallista terveystietovarantoa tai -aluetta

Terveystiedon kansalliset rakenteet ja toimintamallit ovat monilta osin vasta muodostumassa. Syöpästrategian toimeenpanossa ja syövän kansallisen tietovarannon luomisessa huomioidaan tällä hetkellä tiedossa olevat kansallinen hyvinvoinnin sekä sosiaali- ja terveydenhuollon tietovaranto (THL:n sote-hyte-tietovaranto) ja siihen liittyvä, myös tutkimustiedot kattava kansallisen terveystietoalueen FHDS-Tieto, Kanta-palveluiden Potilastietovaranto sekä EU-rahoitteisen National Cancer Data Nodes (CANDLE) -hankkeen kehitystyö. Kansallisten varantojen toteutuminen edellyttää hyvinvointialueiden tietoaltaiden kehitystoimintaa yhdessä potilastietojärjestelmiä kehittävien yritysten kanssa sekä laatutyötä.

Rakenteiden muodostuessa siirrytään kehitystyöstä vakiintuneisiin käytäntöihin, joita rahoitetaan kaikilla hyvinvointialueilla ja HUSissa valtion rahoituksella. Rahoitus on riippuvainen ja suhteessa siihen, miten tietoa tuotetaan tietovarantoon.

Vastuutaho: STM, OKM, VM, hyvinvointialueet, HUS, FICAN, viranomaiset (THL, Kela, Fimea, Palko ja Hila sekä muut HTA-toimijat), lisäksi asiaa edistää ja valmistelee osaltaan STM:n koordinoima EHDS-asetuksen kansallisen toimeenpanon koordinaation ohjausryhmä[78], jonka toimikausi on 2025–2027.

Resurssi: Arvioitu kustannus on 1 750 000 € (350 000 € vuodessa viiden vuoden ajan). Tällä summalla saadaan palkattua osa-aikainen työntekijä kullekin hyvinvointialueelle, Helsingin kaupungille ja HUSiin huolehtimaan kirjaamiskäytäntöjen vakiinnuttamisesta. Lainsäädäntötyö tehdään virkatyönä. FHDS-mallin rakennus toteutetaan erillisellä rahoituksella.

Aikataulu:
2026–2028: Tarvittavat lainsäädäntömuutokset on tehty (toisiolaki), Eurooppalainen terveysdata-avaruus (EHDS) tukee syöpästrategian tavoitteita; kansallinen, erikoissairaanhoidon kattava harmonisoitu syövän tietovaranto tuotantokäytössä.
2029–2031: Syövän tietovaranto osana keskitettyä kansallista tietovarantoa (FHDS-Tieto) on vakiintunut työkalu ja käytettävissä laajalti toiminnan ohjaukseen ja kehittämiseen sekä syöpään liittyvään tutkimukseen.

Mittari: Tehdyt lainsäädäntömuutokset, etenkin toisiolakiin tehdyt muutokset ja eurooppalaisen terveystietoalueen (EHDS) implementaatio.

78 Sosiaali- ja terveysministeriö. EHDS-asetuksen kansallisen toimeenpanon koordinaatio 2025–2027.

Toimenpide 4.1.3 Tuotetaan luotettavaa näyttöä kansallisen syövän tietovarannon avulla TKI-toiminnan, hoitojen vaikuttavuuden ja välittömän tietojohtamisen vahvistamiseksi

Kansallista syövän tietovarantoa hyödynnetään niin kliiniseen ja viranomaiskäyttöön kuin tutkimuskäyttöönkin. Data-analytiikkaa kehitetään systemaattisesti erityisesti tekoälypohjaisia teknologioita hyödyntäen ja sekä alueellisesti että osana kansallisen terveystietoalueen (FHDS) toimintaa.

Keskeisiä käyttötapauksia ovat esimerkiksi:

- Välitön tietojohtaminen: reaaliaikaiset näkymät mm. hoitoon pääsystä, hoitopolkujen sujuvuudesta, hoitojen aloitusviiveistä ja resurssien käytöstä
- Hoitojen vaikuttavuuden seuranta: kokonaiseloonjääminen, tautivapaa elossaolo, uusiutumisaste, haittavaikutusprofiilit, sairaala- ja osastopäivät, käytetyt palvelut, potilaan raportoimat tiedot elämälaatuun liittyen, hoidon laadun vertailu eri hoitoyksiköiden välillä, lääkkeiden hallittu käyttöönotto, riskinjakomallit, kansallisen tason käytön seuranta
- TKI: retrospektiiviset ja prospektiiviset kohortit, RWE (real-world evidence) -analyysit, lääkekehitystä tukevat analyysit, geneettisen tiedon ja biopankkiaineistojen hyödyntäminen, menetelmien vaikuttavuus- ja kustannusvaikuttavuustutkimukset.

Vastuutaho: FHDS-Tieto, viranomaistahot, yliopistot (koulutus, menetelmäkehitys), lisäksi hyvinvointialueet ja HUS.

Resurssi: Arvioitu kustannus on 2 000 000 € (400 000 € vuodessa viiden vuoden ajan). Tällä summalla vahvistetaan hyvinvointialueiden data-analyysikyvykkyyksiä erityisesti tietojohtamisen ja hoitojen vaikuttavuuden seurantaa tukemaan. Soveltuvin osin voidaan hyödyntää myös yritysrahoitusta.

Aikataulu:
2026–2028: Tietoverkon automaattisesti generoima ja päivittämä keskitetty tietovaranto on kehitys- ja testausvaiheessa; ensimmäisiä kansallisia ja kansainvälisiä syöpää koskevia tietovarantohankkeita toteutetaan; tietovarantoa pilotoidaan viranomaisten vaikuttavuustyössä ja HTA-arvioinneissa yhteistyössä myyntiluvan haltijoiden kanssa; potilaiden syöpätiedon käyttöliittymä kehitysvaiheessa; toimeksiantajien toteutettavuusarvioinnit (feasibility) on käynnistetty.
2029–2031: Tietovarantoa hyödynnetään viranomaisten vaikuttavuustyössä automatisoidusti.

Mittari: Keskitetyssä kansallisessa syövän tietovarannossa olevien potilaiden osuus (tavoite viiden vuoden kuluttua 70 %, 10 vuoden kuluttua 100 % syöpätapauksista) ja kirjaamisviive (tavoite < 1 kk).

Toimenpide 4.1.4 Kansallista syövän tietovarantoa muodostettaessa varmistetaan, että tieto on hyödynnettävissä myös Syöpärekisterin ja syövän laaturekisterin edellyttämän tietosisällön tuottamiseen

Suomalaisilla terveydenhuollon organisaatioilla on lakisääteinen velvollisuus toimittaa tiedot jokaisesta todetusta syöpätapauksesta tai sellaisen vahvasta epäilystä syöpärekisteriin. Syöpätietoja saadaan poimimalla niitä suoraan terveydenhuollon organisaation tietojärjestelmistä tai käyttäjän täyttämän sähköisen lomakkeen avulla. Tiedonkeruuseen liittyy kuitenkin merkittäviä haasteita. Viime vuosikymmenten aikana kliinisiä hoitoilmoituksia on alettu tuottaa huomattavasti vähemmän, ja niiden kattavuus on laskenut yli 90 prosentista alle 50 prosenttiin.

Kansallisen syövän tietovarannon tietomalli osana FHDS-Tietoa mahdollistaa syöpään liittyvien rakenteisten tietojen suoran poiminnan syöpärekisteriin ilman tietojen jälkikäteistä muokkaamista.

Syövän laaturekisterin tutkimushankkeen piloteista saatuja ja saatavia kokemuksia hyödynnetään kansallista syövän tietovarantoa rakennettaessa. Laaturekisteritoiminnan kehittäminen ei ole riippuvainen FHDS-Tiedon tai kansallisen syövän tietovarannon muodostumisesta (vrt. kohta 3.2.1).

Vastuutaho: Toteutetaan osana FHDS-kehitystä.

Resurssi: Toteutetaan osana FHDS-kehitystä.

Aikataulu:
2026–2028: Kansallinen, rakenteellinen, yleisiä syöpiä koskeva tietomalli on kehitteillä.
2029–2031: Käytössä on kansallinen, rakenteinen, kaikkia syöpiä koskeva tietomalli, joka tuottaa automaattisesti syöpärekisterin ja laaturekisterin tarvitsemat tiedot.

4.2 Vahvistuva kliininen syöpätutkimus on tiivis osa jokaisen potilaan hoitoa

Toimenpide 4.2.1 Vahvistetaan kansallisen kliinisen syöpätutkimuksen koordinaatiota ja yhteistyötä

Kliinisellä syöpätutkimuksella tarkoitetaan tässä yhteydessä kliinistä interventiotutkimusta, jossa selvitetään, miten jokin hoito, toimenpide, elintapaohjaus tai muu interventio vaikuttaa potilaisiin. Suomessa tehtävästä kliinisestä interventiotutkimuksesta valtaosa on kliinistä lääketutkimusta.

Akkreditointi- ja sertifiointiprosessit, kuten OECI ja EUnetCC-hanke, tukevat ja kirittävät osaltaan syöpätutkimusta vahvistamalla laatujärjestelmiä, integroimalla tutkimuksen potilashoitoon, kehittämällä tutkimusinfrastruktuuria ja osaamista,

edistämällä kansainvälistä yhteistyötä sekä hyödyntämällä olemassa olevia pohjoismaisia ja eurooppalaisia verkostoja.

Suomen kliininen syöpätutkimus tarvitsee kuitenkin nykyistä vahvemman ja yhtenäisemmän kansallisen koordinaation. Tätä varten perustetaan uusia ja vahvistetaan jo olemassa olevia syöpätautien kliinisen tutkimuksen yksiköitä (huomioidaan muissakin erikoisalojen yksiköissä kuin syöpätautien osa-alueilla tehtävä syöpiin liittyvä tutkimus) kaikissa yliopistosairaaloissa, jotka tukevat tutkimuksen tekemistä myös keskussairaaloissa. Yksiköiden välistä yhteistyötä tiivistetään FICANin johdolla, jotta kansallinen tutkimusympäristö kehittyy yhdenmukaisemmaksi ja resurssit voidaan hyödyntää tehokkaammin. STM:n perustaman Kliinisten lääke- ja laitetutkimusten kansallisen koordinaatio- ja toimintamallin työryhmän[79] tehtävänä on lisäksi valmistella kliinisen lääke- ja laitetutkimuksen kansallinen koordinaatio, toimintamalli ja rakenne osana terveys- ja hyvinvointialan kasvua ja uudistumista vauhdittavaa TKI-ohjelmaa.

Sitra julkaisi kliiniseen lääketutkimukseen liittyen marraskuussa 2025 muistion[80], jossa esitetään FinTrials-verkostoa kliinisten lääketutkimusten kansalliseksi toimintamalliksi. Vuonna 2026 päätettiin, että FinTrialsin koordinaatioyksikön perustana toimii biopankkien osuuskunta FINBB. Koordinaatioyksikkö tukee yliopistollisilla hyvinvointialueilla ja HUSissa toteutettavia, sekä akateemisia että sponsoroituja kliinisiä lääke- ja laitetutkimuksia, ja muut hyvinvointialueet voivat osallistua tutkimuksiin yhteistoiminta-alueisiin tukeutuen. FinTrials on valtakunnallinen yhteistyöverkosto, joka nojaa olemassa oleviin tutkimusrakenteisiin. Verkoston avulla voidaan tehostaa resurssien käyttöä, vahvistaa tutkimusten laadun seurantaa sekä kehittää ammattilaisten osaamista kansallisesti.

FinTrialsin keskeisenä tehtävänä on toimia yhden luukun mallina kliinisten lääketutkimusten käynnistämisessä sekä yhtenäistää ja nopeuttaa toteutettavuusarviointeja kansallisesti. Toiminnalla voidaan saavuttaa merkittäviä kustannushyötyjä, jotka on huomioitu myös syöpästrategian kustannuslaskelmissa. FICAN tukee FinTrials-verkoston toimintaa syöpätutkimusten osalta.

Vastuutaho: FinTrials-koordinaatioyksikkö ja alueelliset yksiköt, yliopistolliset sairaalat, FICAN, STM.

Resurssi: Arvioitu kustannus on 4 000 000 € (800 000 € vuodessa viiden vuoden ajan). Tällä summalla tuettaisiin paikallisia kliinisen tutkimuksen yksiköitä. Lisäksi FinTrialsin ja kliinisten lääke- ja laitetutkimusten kansallisen koordinaatio- ja toimintamallin työryhmää resursoidaan osana valtion terveys- ja hyvinvointialan TKI-ohjelmaa. Toimenpide 4.3.1 (CANFIN) tukee myös kliinisten syöpätutkimusten vahvistumista.

79 Sosiaali- ja terveysministeriö. Kliinisten lääke- ja laitetutkimusten kansallisen koordinaatio- ja toimintamallin työryhmä.
80 L. Salmivalli (PwC), ym. Fintrials - Kliinisten lääketutkimusten kansallinen toimintamalli. Sitra 2025.

Aikataulu:
2026–2028: Kaikissa yliopistosairaaloissa on hyvin toimivat kliinisen tutkimuksen yksiköt. FinTrials-koordinaatioyksikkö on perustettu ja sen kautta on tehty ensimmäiset toteutettavuusarvioinnit.
2029–2031: FinTrials- koordinaatioyksikön ja alueellisten tutkimusrakenteiden toiminta on vakiintunutta.

Mittari: Kansallinen kliinisen tutkimuksen tuen koordinaatioyksikkö FinTrials on perustettu.

Mittari: Kliinisten syöpätutkimusten kokonaismäärä, kliinisten lääketutkimusten jakautuminen faaseittain ja syöpätyypeittäin sekä tutkijalähtöisiin ja yritysten toimeksiannosta toteutettuihin tutkimuksiin.

Toimenpide 4.2.2 Vahvistetaan ja tuetaan tutkimusyksiköiden toimintaa

Kliinisten syöpätutkimusyksiköiden toimintaedellytyksiä parannetaan vahvistamalla sekä tutkijoiden että tutkimushoitajien resurssia. Yksiköihin perustetaan vakinaiset toimet kliinisille tutkijoille ja tutkimushoitajille, ja tutkimushoitajien nimikkeistö sekä toimenkuvat yhdenmukaistetaan kansallisesti. Samalla varmistetaan sekä tutkimushoitajien että kliinisten tutkijoiden perus- ja jatkokoulutuksen saatavuus, jatkuvuus ja laatu valtakunnallisesti. Selvitetään mahdollisuutta järjestää YAMK-tasoinen kliinisen tutkimushoitajan koulutus ja lisätä kliinisen tutkimuksen erityispätevyys Lääkäriliiton erityispätevyysjärjestelmään.

Tutkimustoiminnan laatua ja vaikuttavuutta vahvistetaan lisäämällä vuoropuhelua kliinikoiden, biolääketieteellisen tutkimuksen asiantuntijoiden, yritysten ja potilaiden välillä. Asiakas- ja tutkimusraatien toimintaa laajennetaan ja vahvistetaan. Lääkäreiden ja ei-lääkäritaustaisten tutkijoiden biolääketieteellisen tutkimuksen tekemistä tuetaan systemaattisesti rakentamalla selkeitä urapolkuja väitöskirjatyöstä itsenäiseen tutkijanuraan. Tätä edistetään esimerkiksi perustamalla sairaaloihin yhteisvakansseja, jotka mahdollistavat kliinisen työn ja interventiotutkimuksen joustavan yhdistämisen. Lisäksi luodaan toimivat rahoitusinstrumentit tutkimusvapaita varten. Pyritään siihen, että lääkäri- ja tutkimushoitajaresurssit ovat niin kattavia, että kliininen syöpätutkimus on erottamaton osa potilaan hoitoa, jolloin tutkimuspotilaiden vastaanottaminen ja hoito toteutetaan osana normaalia työaikaa. Tämä on perusteltua erityisesti kliinisissä lääketutkimuksissa, jossa annetut lääkehoidot ja tehty diagnostiikka korvaavat standardihoitoa.

Pitkäjänteistä rahoituspohjaa vahvistetaan lisäämällä valtion syöpätutkimusrahoitusta ja tukemalla kansainvälisen tutkimusrahoituksen kotiuttamista. Osa STM:n vuosittaisesta, kliinisille tutkimuksille osoitetusta 10 miljoonan euron lisämäärärahasta kohdennetaan kansallisen tutkimustoiminnan vahvistamiseen sekä hyvinvointialueiden tutkimusinfrastruktuurien, kuten biopankkien ja tietoaltaiden, ylläpitoon ja kehittämiseen. Lisäksi STM:n valtion talousarviosta maksamaa erillisrahoitusta,

jolla korvataan julkiselle palvelujärjestelmälle lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksesta sekä tutkimustoiminnasta aiheutuvia kustannuksia (nk. tutkimus- ja koulutuskorvaus), tulee lisätä.

Vastuutaho: Yliopistosairaalat, hyvinvointialueet, rahoittajat (Suomen Akatemia, säätiöt), ammattikorkeakoulut (tutkimushoitajakoulutus), yliopistot (tutkijoiden, mukaan lukien kliinisten tutkijoiden koulutus).

Resurssi: Arvioitu tarvittava määräraha 5 500 000 € (1 100 000 € vuodessa viiden vuoden ajan). Tällä summalla mahdollistetaan vakinaisia toimia yliopistosairaaloiden tutkijoille ja tutkimushoitajille sekä paikallisten tutkimusinfrastruktuurien toiminnan tukeminen.

Aikataulu:
2026–2028: Kliinisten tutkijoiden ja tutkimushoitajien kansallinen koulutusjärjestelmä on vakiintunut. Tutkijakoulutus sisältyy nykyistä laajemmin erikoislääkärikoulutukseen.
2029–2031: Jokaisessa kliinistä tutkimusta tekevässä yksikössä on vakinaisia tutkimushoitajien ja tutkijoiden toimia.

Mittari: Kaikista syöpäpotilaista vähintään 10 % osallistuu kliinisiin interventiotutkimuksiin (tavoite vuodelle 2035) ja kaikissa syövissä (mukaan lukien harvinaiset syövät ja lasten syövät) osallistuminen tutkimuksiin on merkittävästi lisääntynyt.

Mittari: Sellaisten tutkijalähtöisten tutkimusten osuus (%), joissa potilasedustajat ovat mukana tutkimuksen suunnittelussa tutkimusryhmän tai -raadin jäseninä.

Toimenpide 4.2.3 Erikoistumiskoulutukseen ja erikoislääkäreiden työnkuvaan sisällytetään kliiniseen tutkimukseen tutustuminen, koulutus ja osallistuminen (vähintään 10 % työajasta)

Tutkimukseen ja uusien menetelmien kehitykseen panostaminen mahdollistaa vaikuttavamman ja yhdenvertaisemman syövänhoidon. Kun erikoistuvat ja erikoislääkärit osallistuvat aktiivisesti kliiniseen tutkimukseen, he omaksuvat uusimmat hoitokäytännöt ja ymmärtävät niiden vaikuttavuutta paremmin. Tutkimusmyönteinen koulutus- ja työympäristö parantaa myös mahdollisuuksia saada Suomeen korkeatasoisia kliinisiä tutkimuksia. Kliinisen tutkimuksen ollessa luonteva osa työnkuvaa tutkimusosaaminen juurtuu terveydenhuoltojärjestelmään, mikä parantaa kriittistä ajattelua, diagnostista kyvykkyyttä ja kykyä arvioida uusia hoitoja. Toisaalta tutkimukseen osallistuminen lisää moniammatillista yhteistyötä, syventää ymmärrystä hoitopolkujen vaikuttavuudesta ja vahvistaa organisaation kykyä toteuttaa syöpästrategian mukaisia muita kehittämistoimia. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan vahvistamiseksi olisi tärkeää mahdollistaa työajan osittainen kohdentaminen tutkimukseen myös hoitotyön tutkijoille.

Erikoistumisvaiheessa kannustetaan voimakkaasti väitöskirjan tekoon. Selvitetään mahdollisuuksia tukea tätä myös rahallisesti perustamalla kansallinen syöpätohtorikoulu.

Vastuutaho: yliopistojen lääketieteelliset tiedekunnat ja yliopistolliset sairaalat.

Resurssi: Toteutetaan osana toimenpidettä 3.5.1.

Aikataulu:
2026–2028: Osa erikoistuvien/erikoislääkärien työajasta kohdennetaan säännöllisesti kliinisten interventiotutkimuksen tekemiseen.
2029–2031: Erikoistumisohjelmaan on sisällytetty pakollinen tutkimusjakso, joka koostuu esim. tutkimusmenetelmäopinnoista ja osallistumisesta käynnissä olevaan tutkimukseen. Erikoislääkäreille on tarjolla vakiintunut urapolku, jossa kliinistä ja tutkimustyötä voi yhdistää. Valtaosa syöpäpotilaita hoitavista erikoissairaanhoidon lääkäreistä osallistuu kliinisiin interventiotutkimuksiin.

4.3 Suomi on yksilöllisen lääketieteen edelläkävijä

Toimenpide 4.3.1 Perustetaan yksilöllisen syöpälääketieteen TKI-keskus Cancer Research Hub Finland (CANFIN)

Cancer Research Hub Finlandin (CANFIN) tavoitteena on muodostaa kansainvälisesti näkyvä syöpätutkimuksen ja yksilöllisen hoidon TKI-keskittymä. Keskeiset tavoitteet ovat:

1. Investointien houkuttelu kotiuttamalla Suomeen vähintään 220 miljoonan euron TKI-investoinnit vuosina 2026–2035.
2. Tarjota ratkaisuja syöpähaasteeseen integroimalla tutkimus ja hoito toiminnalliseksi kokonaisuudeksi, jolloin uusimmat täsmähoidot ja diagnostiikka saadaan potilaiden käyttöön nopeammin ja vaikuttavuudesta varmistuen.
3. Innovaatioiden, kasvun ja työllisyyden kiihdyttäminen luomalla yhden luukun kansallinen syöpäalan toimija yrityksille ja tutkijoille.

CANFIN toteutetaan laajentamalla ja kehittämällä iCAN-lippulaivahankkeen luomaa tutkimusalustaa ja toimintamallia kansalliseksi rakenteeksi FICANin puitteissa. Hankkeen käynnistysvaihe ajoittuu vuosille 2026–2030. Valtion rahoituspäätöstä tavoitellaan vuoden 2026 aikana, mikä mahdollistaisi iCAN-tietovarannon täysimääräisen hyödyntämisen jatkossa. CANFIN toimii kansallisen terveystietoalueen (FHDS) ja mahdollisesti CANDLE-hankkeessa kehitettävän syöpädatakeskittymän käytännön sovelluksena ja peruspilarina ja tukee näin osatavoitetta 4.1. sekä FHDS:n periaatteiden mukaista kansallista, tietoturvallista ja harmonisoitua terveysdataa sekä suurteholaskentaa. CANFINin multimodaalinen data voi tukea laaturekisterien ja

Syöpärekisterin kehitystä. CANFIN tukee myös kliinisten syöpätutkimusten vahvistumista (4.2) ja terveysalan kasvuohjelmaa. Dataa voidaan hyödyntää terveystaloustieteellisessä tutkimuksessa. CANFINin tehtävissä huomioidaan ja pyritään vahvistamaan hyvinvointialueiden TKI-toimintoja sekä kansallisia osaamiskeskittymiä kuten biopankkeja, lääkekehityskeskuksia ja neurokeskusta sekä välttämään päällekkäisiä toimintoja.

Vastuutaho: Lääketieteelliset yliopistot ja yliopistosairaalat FICANin puitteissa ja Helsingin yliopisto koordinaattorina, osallistuvat säätiöt, Syöpärekisteri, STM, OKM, TEM, Suomen Akatemia, Business Finland.

Resurssi: Valtion TKI-rahoitus 40 000 000 €. CANFINin toteutuminen edellyttää kokonaisuudessaan 65 000 000 €:n käynnistysrahoitusta vuosina 2026–2030, josta valtion TKI-rahoituksen lisäksi osakkaiden ja kumppanien rahoitus 25 000 000€ (Helsingin yliopisto 5 M€, muut suomalaiset partnerit 10 M€, säätiöt 10 M€).

Aikataulu:
2026–2028: CANFIN on toiminnassa vuoden 2027 alusta, mikä mahdollistaa iCAN-tietovarannon täysimääräisen hyödyntämisen jatkossa. Vuoteen 2028 mennessä CANFIN on mahdollistanut yli 10 000 syöpäpotilaan molekyyliprofiloinnin diagnostiikan ja tutkimuksen kaksoiskäyttöön. Yhdessä RWD-tiedon kanssa ne muodostavat kansallisen tutkimuksellisen pohjan yksilöllisen lääketieteen ohjelmalle. Biopankkien tuorenäyte- ja nestebiopsianäytteiden lukumäärä on merkittävästi kohonnut vuoden 2024 tasoon verrattuna.
2029–2031: CANFIN on rekrytoinut yli 50 000 syöpäpotilasta (vuonna 2035 tavoitteena 100 000 syöpäpotilasta), minkä ansiosta molekyyliprofilointi on moninkertaistunut Suomessa. CANFIN toimii kansallisen syöpäkeskuksen ja biopankkien puitteissa tunnettuna houkuttelevana kansainvälisenä syövän TKI-keskuksena, jossa julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudet mahdollistavat yksilöllisen syöpälääketieteen toteutusta ja innovaatioita. Suomeen on näin saatu vähintään 120 M€ TKI-investointeja (vuonna 2035 tavoitteena 220 M€). Tavoite perustuu iCAN lippulaivan toteutuneiden kansainvälisten investointien kaksinkertaistumiseen, ja sen toteuttamisessa hyödynnetään CANFINin kansallista asemaa, parantunutta terveystiedon hyödyntämistä sekä tekoälyä.

Mittari: CANFINin vaikuttavuus: julkaisujen, innovaatioiden, startup-yritysten, kumppanuuksien ja investointien määrä.

Mittari: Molekyyliprofiloitujen syöpäpotilaiden kansallinen jakauma ja osuus vuosittain diagnostisesti ja tutkimuksellisesti eriteltynä.

Mittari: Biopankkeihin kertyvien, yksilöllistä syöpälääketiedettä tukevien näytteiden määrä ja näytteistä saadun omiikkadatan hyödynnettävyys syövän ehkäisyssä ja hoidossa.

Toimenpide 4.3.2 Luodaan kansalliset suositukset molekyylidiagnostisten tutkimusten laajuudesta ja tutkimusmenetelmistä

Syövän molekyylidiagnostiikalla tarkoitetaan kasvainkohtaisten molekyylimuutosten selvittämistä kohdennettuja hoitoja varten. Molekyylimuutokset voivat ilmetä DNA-, RNA- tai proteiinitasolla, ja niiden tutkimiseen on olemassa useita menetelmällisiä vaihtoehtoja. Tällä hetkellä ei ole olemassa kansallista suositusta siitä, mitkä molekyylimuutokset eri syöpätyypeistä tulisi tutkia.

Tavoitteena on, että molekyylidiagnostiikkaa ohjaavat eurooppalaisiin ohjeistuksiin pohjautuvat kansalliset suositukset, jotka perustuvat hoidolliseen tarpeeseen ja menetelmien vaikutusten arviointiin (viimeksi mainittuja käsitellään osatavoitteessa 3.1). Näin varmistetaan, että testaus on kaikille potilaille tasa-arvoista ja perustuu yhtenäisiin kriteereihin. Nämä suositukset ovat osa säännöllisesti päivittyviä kansallisia hoitosuosituksia. Suositukset määrittävät myös uusien tutkimusmenetelmien, esimerkiksi nestebiopsioiden, yhtenäistä käyttöönottoa.

Molekyylidiagnostiikkaa ohjaa kansallisesti koottu tieto käytössä olevista menetelmistä ja suosituksista, jotka määrittävät muun muassa tutkimuksen kohteen, diagnostisen menetelmän sekä raportoinnin raamit. Suositus voi myös ottaa kantaa palvelujen saatavuuteen tai toteutukseen niin, että jokaisella hyvinvointialueella on mahdollisuus käyttää suositusten mukaisia molekyylidiagnostisia menetelmiä.

Vastuutaho: STM, FICAN, lisäksi kansalliset hoitosuosituksia tekevät asiantuntijaryhmät, MTB Finland ja alueelliset MTB:t.

Resurssi: Toteutetaan osana toimenpiteessä 3.1.1 kuvattua kokonaisresursointia.

Aikataulu:
2026–2028: Suunnitelma kansallisesta tietokannasta, tiedon jakaminen uusien suositusten ja menetelmien käyttöönotosta.
2029–2031: Luotu kansallinen tietokanta, jossa koottu tieto suosituksista ja menetelmistä.

Mittari: Molekyyliprofiloitujen syöpäpotilaiden kansallinen jakauma ja osuus vuosittain diagnostisesti ja tutkimuksellisesti eriteltynä.

Toimenpide 4.3.3 Keskitetään uudet, vaativat tutkimukset riittävästi resursoituihin (henkilöstö, laitteet, sähköinen lähete-vastausliikenne) laboratorioihin

Kudos- ja solunäytteistä tehtävät histologiset, immunohistokemialliset ja *in situ* -hybridisaatioon perustuvat tutkimukset ovat laboratorioissa tehtävän syöpädiagnostiikan perusta. Diagnostiikka vaatii kuitenkin yhä enenevässä määrin myös molekyyligeneettisiä tutkimuksia, joilla tarkennetaan kasvaimen luokittelua ja ohjataan hoidon

valintaa. Vaativia molekyyligeneettisiä tutkimuksia, kuten uuden sukupolven sekvensointitutkimuksia (engl. next-generation sequencing, NGS) tehdään tällä hetkellä muutamassa julkisen terveydenhuollon yksikössä. Tutkimuksia joudutaan kustannus- ja saatavuussyistä ostamaan myös ulkomailta, minkä seurauksena kasvaimista saatava molekyyligeneettinen tieto ei ole kokonaisuudessaan kansallisesti koordinoitua, eikä profilointi ole tällä hetkellä kustannustehokasta.

Molekyylidiagnostiikan kokonaisuus vaatii sitä tuottavilta laboratorioilta paitsi huomattavaa teknistä osaamista ja mittavaa analyysilaitteistoa myös monialaista asiantuntijuutta. Koska tutkimuksia tehdään väestöpohjaan nähden useassa laboratoriossa, niiden käyttöaste jää vähäiseksi eivätkä vastaukset valmistu riittävän nopeasti potilaiden hoidon suunnittelua ajatellen. Kudos- ja solunäytteistä tehtävissä molekyylidiagnostisissa tutkimuksissa on myös huomattavia aluekohtaisia eroja, mikä vaikuttaa hoidon suunnitteluun ja toteutukseen sekä vaarantaa potilaiden yhdenvertaisuuden.

Tavoitteena onkin, että syöpäpotilaiden yhdenvertaisuuden turvaamiseksi uudet, vaativat molekyyliprofiloinnit tehdään pääsääntöisesti yhteisesti valituissa, akkreditoidussa julkisen terveydenhuollon keskuslaboratorioissa, jossa on resurssit uusien menetelmien kehittämiseen ja validointiin sekä riittävä asiantuntijuus vastausten laadukkaaseen ja ymmärrettävään raportointiin. Kansallisesta työnjaosta analyysien toteuttamisessa sovitaan laboratorioiden kesken. Samalla huolehditaan siitä, että tutkimusten läpimenoaika ja kustannukset vastaavat julkisen terveydenhuollon tarpeita ja taloudellisia vaatimuksia. Vastausliikenne tapahtuu suojatuissa sähköisissä kanavissa viiveiden minimoimiseksi. Keskuslaboratorioiden infrastruktuuria ylläpidetään siten, että molekyylidiagnostiikka on soveltuvin osin *in vitro* -diagnostisia lääkinnällisiä laitteita koskevan asetuksen mukaista (IVDR).

Vastuutaho: STM (keskittäminen), hyvinvointialueet ja HUS.

Resurssi: Arvioitu kehittämiseen ja koordinointiin tarvittava määräraha 400 000 €, lisäksi olemassa olevat henkilöstöresurssit hyvinvointialueilla ja HUSissa.

Aikataulu:
2026–2028: Laboratorioiden työnjako selvillä, ajantasainen lista molekyylidiagnostiikan tutkimusmenetelmistä.
2029–2031: Keskitetyt laboratoriot toiminnassa uuden, vaativan molekyyliprofiloinnin osalta.

Toimenpide 4.3.4 Kehitetään ja resursoidaan molekulaaristen tuumoriryhmien (MTB) toimintaa kansallisessa yhteistyössä

Syöpänäytteiden tai nestebiopsianäytteiden molekyyliprofilointi – tyypillisesti NGS-sekvensointia hyödyntäen – on siirtymässä lisääntyvässä määrin kliiniseen käytäntöön. Profiloinnin tulosten huomioiminen asiantuntevasti edellyttää moniammatillisten tiimien (engl. multidisciplinary teams, MDT) ja molekulaaristen

tuumoriryhmien (engl. Molecular Tumor Boards, MTB) muodostamista. Suomessa MTB-toiminta on käynnistynyt vuonna 2018 (Alanne, Duodecim 2021), ja kansallista yhteistyötä on alettu toteuttaa FINPROVE-lääketutkimuksen puitteissa pitkälle edenneessä syövässä 2021 alkaen. Tässä toimenpiteessä tuetaan alueellisten MTB:iden muodostumista ja kehittymistä sekä perustetaan kansallinen koordinoiva MTB (MTB Finland) FINPROVE-tutkimushankkeen puitteissa rakentunutta yhteistyötä hyödyntäen, huomioiden myös pienemmät syöpäryhmät kuten pediatriset ja harvinaiset syövät. Kansallinen MTB vastaa osaltaan molekyyliprofiilointiin liittyvästä koulutuksesta ja mahdollistaa esim. erikoistuvien lääkärien osallistumisen kokouksiin. STM on myöntänyt rahoitusta kansallisen MTB:n kehitykseen osana *Osaamiskeskittymät kehittämässä kansallista yksilöllisen lääketieteen ohjelmaa* -hanketta vuosille 2025–2026.

MTB Finland käsittelee vaativat, esimerkiksi harvinaista syöpää sairastavat potilastapaukset, joissa on tehty laaja molekyyliprofilointi (suositukset molekyyliprofiloinnista toimenpiteessä 4.3.2). Toimintaa ja vaikuttavuutta voidaan arvioida osatavoitteessa 4.1. kuvattua kansallista terveystietoaluetta hyödyntäen, siltä osin kuin molekyyliprofilointi suoritetaan julkisen terveydenhuollon piirissä.

Vastuutaho: FICAN, yliopistolliset sairaalat, STM.

Resurssi: 500 000 €, STM (mm. *Osaamiskeskittymät kehittämässä kansallista yksilöllisen lääketieteen ohjelmaa* –hanke ja mahdollinen Kansallinen yksilöllisen lääketieteen ohjelman pilotti), hyvinvointialueet ja HUS.

Aikataulu:
2026–2028: Kansallinen MTB toiminnassa: tehtävät, toimintatavat, resurssit ja integraatio alueellisiin sovittu.
2029–2031: MTB-toiminta osana yksilöllisen lääketieteen ohjelman hoitopolkua vakiintunut ja henkilöstö on asiantuntevaa. Molekyyliprofiloitujen potilaiden osuus on lisääntynyt vastaamaan yleiseurooppalaista tasoa.

Mittari: Molekulaarisen muutoksen mukaista kohdennettua hoitoa saaneiden potilaiden osuus ja kokemukset saadusta hoidosta (Patient Reported Outcome Measures, PROM)

Toimenpide 4.3.5 Kehitetään biopankkitoimintaa tukemaan yksilöllisen lääketieteen tarpeita

Suomen biopankkien näytekeräyksissä ovat viime vuosina korostuneet patologian diagnostiikassa kerättävät kudosnäytteet ja verinäytteiden keräys erityisesti FinnGen-tutkimushankkeeseen ja THL:n väestökohorttitutkimuksiin liittyen. Yksilöllisen syöpälääketieteen kannalta keskeisiä näytteitä ovat syöpäsoluja tai viitteitä niistä sisältävät näytteet, kuten kudos- ja solunäytteet sekä nestebiopsiat. Kansainvälisiä investointeja houkuttelevat biopankkitutkimukset edellyttävät, että näytteitä

kerätään, prosessoidaan ja säilytetään kansallisesti yhtenäisellä tavalla, joten harmonisointityöhön on syytä panostaa. Samalla on huolehdittava biopankkien riittävistä resursseista näytteiden keräyksen, prosessoinnin ja säilytyksen turvaamiseksi.

Luodaan käytänteet aineistohakemusten kansalliselle ja tieteelliselle arvioinnille. Näin tutkijat saavat biopankkiaineistoja käyttöönsä nykyistä helpommin ja yhdenvertaisemmin, ja biopankkien rajallisia resursseja voidaan keskittää paremmin. Vahvistetaan biopankkitutkimuksessa tuotettujen tietojen käyttöä potilaan hoidon valinnassa ja syövän ennaltaehkäisyssä iCAN-lippulaivahankkeen ja GenomiTerveys-hankkeen kokemusten pohjalta. Hyödynnetään ja jatkojalostetaan myös muita käynnissä olevia osaamiskeskittymien ja biopankkien hankkeita ja niiden tuloksia (esimerkiksi Osaamiskeskittymät kehittämässä kansallista yksilöllisen lääketieteen ohjelmaa ja biopankkien yhteinen FIRI-hanke). Vahvistetaan biopankkitutkimuksessa luotujen tietojen laaja-alaisuutta ja kliinistä merkityksellisyyttä varmistamalla, että terveystietoja kerätään osaksi tietovarantoa biopankkien tietoaltaita hyödyntäen.

Vastuutaho: Suomessa toimivat biopankit, Biopankkien Osuuskunta Suomi (FINBB).

Resurssi: 2 000 000 € biopankkitoiminnan kehittämiseksi, lisäksi olemassa olevat henkilöstöresurssit.

Aikataulu:
2026–2028: Biopankkeihin talletettavat kudos-, solu- ja nestebiopsianäytteet kerätään ja prosessoidaan kansallisesti yhtenäisellä suosituksella.
2029–2031: Biopankkien aineistohakemukset arvioidaan keskitetysti yhden kansallisen toimijan avulla. Biopankkitutkimuksista palautuvaa tietoa palautetaan systemaattisesti näytteenantajalle, mikäli antaja on näin toivonut ja myös palvelujärjestelmään siltä osin kuin tieto on palautettavissa.

Mittari: Biopankkeihin kertyvien, yksilöllistä syöpälääketiedettä tukevien näytteiden määrä ja näytteistä saadun omiikkadatan hyödynnettävyys syövän ehkäisyssä ja hoidossa.

4.4 Vähennetään syöpätaakkaa monitieteisen tutkimuksen avulla

Toimenpide 4.4.1 Kerätään ja ylläpidetään tietoa syöpätutkimuksen rahoituksesta ja tehdään esityksiä sen kohdentamistarpeista

Kartoitetaan syöpätutkimuksen kokonaisuutta ja mahdollisia aukkoja syöpätutkimuksen rahoituksen kentässä. Rahoitusmahdollisuuksien tulisi tukea kaikkia eri syöpätutkimuksen osa-alueita. Tällä hetkellä tieto kansallisista ja kansainvälisistä rahoitusmahdollisuuksista on pirstaleista, ja tietoa kerätään eri tahoille pääosin omiin tarpeisiin. Toimenpiteessä kootaan yhteen ajantasaista tietoa syöpätutkimuksen

rahoituksesta eri tutkimusaloilla, kuten epidemiologisessa, lääkekehityksessä, perus- ja translationaalisessa, kliinisessä sekä palvelujärjestelmän tutkimuksessa. Myös kansallisista rekistereistä ja sairaaloiden sekä hyvinvointialueiden tietoaltaista kerättävä tosielämän RWE-tieto mahdollistaa ajantasaisen laaja-alaisen syöpätutkimuksen toteuttamista monitieteisesti.

Kerätyn tiedon pohjalta tunnistetaan rahoitusaukkoja ja kehittämistarpeita, arvioidaan monitieteisen tutkimuksen riittävyyttä esimerkiksi terveystaloustieteen, psykososiaalisen tutkimuksen, palliatiivisen hoidon ja hoitotieteen alueilla ja tehdään esityksiä rahoituksen kohdentamisesta sinne, missä tutkimuksella voidaan parhaiten tukea ehkäisyä, hoitoa, elämänlaadun parantamista ja hoidon vaikuttavuutta.

Vastuutaho: FICAN yhteistyössä syöpätutkimuksen rahoittajien ja muiden sidosryhmien kanssa.

Resurssi: Huomioidaan osana strategian toteutukseen esitettyä 6 000 000 €, lisäksi julkinen ja säätiöiden tutkimusrahoitus.

Aikataulu:
2026–2028: Kartoitus rahoitusmahdollisuuksista ja rahoituksen jakaantumisesta valmistunut ja yhtenäinen tieto on kaikkien käytettävissä.
2029–2031: Kartoituksen perusteella tehdään rahoittajille esityksiä rahoituksen lisäys- ja kohdentamistarpeista syöpätutkimuksen eri osa-alueille. Tuotetaan vuosittain päivittyvää tietoa rahoitusmahdollisuuksista ja syöpätutkimuksen tuloksista sekä vaikuttavuudesta.

Mittari: Syöpätutkimuksen tulokset ja vaikuttavuus kokonaisuutena (esimerkiksi julkaisujen määrä ja viittaukset julkaisuihin) ja niiden jakautuminen strategian painopistealueille.

Mittari: Syöpätutkimukseen kohdistuva kokonaisrahoituksen kasvu.

Toimenpide 4.4.2 Vahvistetaan laaja-alaisen, monitieteisen syöpätutkimuksen tunnettuutta ja sen merkitystä ennaltaehkäisyssä, hoidon kehittämisessä ja sairastuneiden elämänlaadun parantamisessa

Syöpätutkimusta tuetaan laaja-alaisesti ja kokonaisvaltaisesti ja edistetään näin syövän ehkäisyä, hoitoa ja hyvää elämää syövän kanssa ja sen jälkeen. Suomen vahvuus perustuu kansalaisten luottamukseen, kattaviin, pitkäaikaisiin ja korkealaatuisiin kansallisiin rekistereihin sekä tilastoekosysteemiin (mm. Syöpärekisteri, THL, Tilastokeskus, Kela), jotka tarjoavat rekisteritutkimukselle kansainvälisen kilpailuedun. Yksityiskohtaisemman, ajantasaisemman ja syvemmän tiedon tarpeeseen vastaaminen edellyttää sairaaloiden tietoaltaiden yhdistämistä tilastoekosysteemiin ja tietovarantoon. Lisäksi tarvitaan vahva yhteys lääketieteellisissä yliopistoissa tehtävään biolääketieteelliseen huippututkimukseen.

Toimenpiteessä tuetaan laaja-alaisen syöpätutkimuksen tunnettuutta ja merkityksellisyyttä sekä kokonaisvaltaista syöpätutkimusta sairastuneiden elämänlaatu ja hoitojen pitkäaikaisvaikutukset huomioiden. Ennaltaehkäisevien toimenpiteiden, lääkekehityksen, diagnostiikka- ja hoitomenetelmien sekä psykososiaalisen tuen vaikuttavuutta seurataan myös käyttöönoton jälkeen arkivaikuttavuuden selvittämiseksi. Potilaan näkökulmaa tutkimuksista ja niiden vaikuttavuudesta sekä hoitojen mahdollista haitoista pyritään selvittämään hyödyntämällä digitaalisia oire-, elämänlaatu- ja vointikyselyjä. Lisäksi tutkimuksessa huomioidaan yhdenvertaisuus ja strategiakauden painopisteet kuten geriatrinen onkologia, lasten ja nuorten syövät, harvinaiset ja huonoennusteiset syövät, palliatiivinen hoito sekä ehkäisyyn ja seulontaan liittyvä rekisteritutkimus. Yhdenvertaisuutta koskien tutkitaan monialaisesti, miten koulutusasteelliset ja/tai sosioekonomiset erot ennustavat potilaan mahdollisuutta selvitä syövästä (elämäntavat, hoitoon hakeutuminen, hoitoon pääsy, hoitojen valinnat, hoitoihin sitoutuminen, terveyslukutaito). Tutkimuksen perusteella laaditaan ohjelma, jolla puututaan juurisyihin.

Monitieteisen syöpätutkimuksen merkityksellisyyden ja siihen pohjautuvan päätöksenteon esiintuominen kansalaisille, päättäjille tutkimuksen rahoittajille vaatii hyvin suunniteltua ja kohdennettua viestintää.

Vastuutaho: Syöpämissio Suomi, yliopistot ja ammattikorkeakoulut, tutkimuslaitokset, järjestöt, Syöpärekisteri.

Resurssi: Huomioidaan osana strategian toteutukseen esitettyä 6 000 000 €:a.

Aikataulu:
2026–2028: Tuetaan ja toteutetaan monitieteistä tutkimusta syövästä ja syövästä selviytymisestä.
2029–2031: Viestitään monitieteisestä syöpätutkimuksesta ja sen merkityksestä kansalaisille ja päättäjille sekä tuetaan tietoon pohjautuvaa päätöksentekoa

Mittari: Syöpätutkimukseen kohdistuva kokonaisrahoituksen kasvu ja sen jakautuminen syövän ehkäisyn ja potilaan hoitopolun varrelle.

Mittari: Ilmaantuvuus- ja kuolleisuuserot koulutusasteittaisten ryhmien välillä pienenevät, mikä lisää yhdenvertaisuutta.

Toimenpide 4.4.3 Edistetään eri syöpään liittyvien osa-alueiden, ammatti- ja potilasryhmien ja tutkijoiden yhteistyötä monitieteisten tutkimusten toteuttamisessa osana Syöpämissio Suomen toimintaa

Perustetaan syöpäalan toimijat yhteen kokoava Syöpämissio Suomi (Cancer Mission Hub Finland), jonka tehtävänä on EU:n syöväntorjuntasuunnitelman ja syöpämission sekä kansallisen syöpästrategian toimeenpanon edistäminen ja monitieteisen syöpätutkimuksen tukeminen. Syöpämissio Suomi toimii tällä alueella foorumina, joka

tukee tutkimushankkeiden yhteiskehittämistä eri ammatti- ja potilasryhmien sekä tutkijoiden välillä, korostaa monitieteisyyttä psykososiaalinen, palliatiivinen ja hoitotieteellinen tutkimus huomioiden, ja varmistaa, että tutkimus kattaa koko väestön ja elämänkaaren näkökulmat (mm. ehkäisy, varhainen toteaminen, geriatrinen onkologia, lasten ja nuorten syövät, harvinaiset ja huonoennusteiset syövät) sekä biolääketieteellisen perustutkimuksen ja luo näin mahdollisuuksia syövän diagnostiikan ja hoidon kehittämiseen.

Syöpämissio Suomi edistää kansallisten tietolähteiden käyttöä tutkimuksessa ja koordinoi tutkimuksen sirpaleisuuden vähentämiseksi ja monitieteisten hankkeiden rahoitus- ja yhteistyömahdollisuuksien vahvistamiseksi tarvittavia toimia. Syöpämissio Suomi edesauttaa myös yritysten ja potilasjärjestöjen kanssa tehtävää tutkimusyhteistyötä.

Vastuutaho: Syöpämissio Suomi, syöpästrategiaa toteuttavat tahot, yliopistot ja yliopistosairaalat, ammattikorkeakoulut, hyvinvointialueet, tutkimusrahoittajat, lisäksi järjestöt ja tutkimuksia toteuttavat yritykset, sekä Suomen Lääkekehityskeskus Oy.

Resurssi: Huomioidaan osana strategian toteutukseen esitettyä 6 000 000 €:a. Resurssia kohdennetaan Syöpämissio Suomen toimintaan, lisäksi olemassa olevat resurssit toiminnassa mukana olevissa organisaatioissa.

Aikataulu:
2026–2028: Syöpämissio Suomi on toiminnassa ja edistää yhteistyötä ja verkostoitumista syöpätutkimuksen toimijoiden ja eri ammattiryhmien välillä.
2029–2031: Laaja-alaisen syöpätutkimuksen asema ja yhteistyö on vahvistunut Suomessa.

4.5 Uusien syöpälääkkeiden ja muiden hoitomenetelmien arviointi ja käyttöönotto on vaikuttavaa, viiveetöntä ja yhtenevää arviointitahosta riippumatta

Toimenpide 4.5.1 Varmistetaan syöpälääkkeiden käyttöönottoon liittyvien ongelmien korjaaminen osana STM:n koordinoimaa lääkeasioiden uudistusta

Sosiaali- ja terveysministeriön johtama lääkeasioiden uudistus on hallituskausien yli ulottuva kokonaisuus, jonka tavoitteena on parantaa lääkehoitojen vaikuttavuutta, turvallisuutta ja laatua sekä taloudellisuutta, yhdenvertaisuutta ja saatavuutta. Vuosina 2024–2027 käynnissä olevan Lääkkeet ja apteekkitalous -hankkeen yksi tavoite on lääkkeiden arviointitoiminnan kehittäminen, josta julkaistiin työryhmän raportti[81]

81 Sosiaali- ja terveysministeriö. Lääkkeiden arviointiprosessien ja -kriteereiden lähentäminen. Työryhmän raportti. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2025:34.

syksyllä 2025. Terveydenhuollon menetelmien arviointia ja sen organisoitumisen uudistusta on selvitetty lisäksi STM:n keväällä 2026 julkaisemassa loppuraportissa Selvitys terveydenhuollon menetelmien kansallisista organisoitumismalleista[82], (jatkossa HTA-raportti). Kansallisen käyttöönoton nykyiset prosessit ja kehittämistarpeet on kuvattu selkeästi näissä raporteissa.

Lääkkeiden arviointitoiminnan kehittämistä ja arviointikriteerien sekä -prosessien yhdenmukaistamista tulee jatkaa raportteihin kirjattujen suuntaviivojen mukaisesti niin, että siirrytään vaiheittain yhden arviointitoimijan malliin (HTA-raportin yhden toimijan tai kahden toimijan mallit, joissa lääkkeiden arviointi on koottu yhdelle toimijalle). Toiminnan tulee kattaa sekä avo- että sairaalalääkkeet. Syöpäalan toimijat jatkavat aktiivista keskustelua arviointitoiminnan kehittämisestä ja lainvalmistelusta vastaavien tahojen kanssa ja tuovat esiin syöpälääkkeiden erityishaasteet, joita on kuvattu tarkemmin strategiassa.

Arviointitoimintaa tulee kehittää siten, että uusien lääkkeiden ja yhdistelmähoitojen osalta määritellään selkeästi, mitkä tahot voivat hakea lääkkeen kansallista arviointia ja käyttöönottoa. Myyntiluvan haltijoiden lisäksi myös viranomaisilla ja hoitavilla tahoilla tulisi olla mahdollisuus hakea kansallista lääkkeen arviointia ja käyttöönottoa.

Uuden sairaalalääkkeen käyttöönotosta ja merkittävästä käyttöaiheen laajennuksesta tulee tehdä kansallinen päätös tai linjaus, joka on käytettävissä kaikilla hyvinvointialueilla, ja jota hyvinvointialueet ja muut terveydenhuollon toimijat sitoutuvat noudattamaan. Arvioinnin ja päätöksenteon tulee tapahtua ennalta määritellyssä aikataulussa, selkeästi ja viiveettä, ettei se hidasta merkittävien lääkeinnovaatioiden käyttöönottoa.

Kansallisille neuvotteluille käyttöönoton ehdoista, tuotteen hinta mukaan lukien, luodaan selkeä toimintamalli, jota hyödynnetään kalliita uusia lääkeinnovaatioita painottaen. Riskinjakomalleista tehdään vakiintunut toimintatapa, ja niiden perusperiaatteet määritellään ennakoitavasti ja läpinäkyvästi.

Vastuutaho: STM (päävastuu, arviointitoiminnan kehittäminen), FIMEA, Palko, Hila, Kela, FICAN, hyvinvointialueet, HUS ja sairaala-apteekit, lisäksi syövän hoidon ja tutkimuksen ammattilaiset.

Resurssi: Toteutetaan virkatyönä arviointitoimintaa kehittävässä ministeriössä ja muissa organisaatioissa.

Aikataulu:
2026–2028: Lainsäädäntö päivitetty. Kansallisen hintaneuvottelumekanismin luominen.
2029–2031: Arvioinnin ja päätöksenteon uudistettu kansallinen malli on käytössä.

82 Sosiaali- ja terveysministeriö. Selvitys terveydenhuollon menetelmien kansallisen arvioinnin organisoitumismalleista. Loppuraportti. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2026:11.

Mittari: Lainsäädännölliset muutokset, lääkkeiden arviointi ja päätöksenteko koottu yhdelle toimijalle.

Mittari: Uusien lääkeinnovaatioiden käyttö ja käyttöönottoaika muihin Euroopan maihin verrattuna.

Mittari: Kansallisesti hintaneuvoteltujen syöpälääkkeiden osuus lääkehankinnoista.

Toimenpide 4.5.2 Luodaan yksi yhteinen kansallinen lääkkeiden arviointijärjestelmä päätöksenteon pohjaksi ja riittävän arviointiresurssin varmistamiseksi

Lääkkeiden arviointi ja päätöksenteko kootaan yhdelle toimijalle, jonka kautta EU-HTA-arvioinnin jälkeinen ja muu kansallinen arviointi tapahtuu. Lääkkeiden käyttöönottoa koskeva kansallinen ja sitova päätöksenteko perustuu tähän arviointiin. Hyödynnetään nykyisten arviointeja tekevien tahojen (Fimea, Palko, Hila) olemassa olevat, hyviksi koetut toimintamallit ja osaaminen siten kuin STM:n julkaisemissa raporteissa on kuvattu[83].[84]. Tämä edellyttää selkeää työnjakoa nykyisten toimijoiden välillä, riittävää ja pysyvää arviointiresurssia, koordinaatiotoimintoa ja priorisointimekanismia arviointipyyntöjen käsittelyyn sekä toimeenpanon tukea ja koordinaatiota hoito-ohjeita ja -suosituksia laativien tahojen kanssa.

HTA-toiminnassa tulee tehdä tiivistä yhteistyötä sairauskohtaisten asiantuntijaryhmien kanssa, jotta kliinistä työtä tekevien asiantuntijoiden näkökulmat integroituvat systemaattisesti arviointityöhön. Asiantuntijat voivat vaihdella indikaatiokohtaisesti. Myös potilasedustajia on tärkeää kutsua mukaan arviointityön tueksi. Kliinistä työtä tekevien asiantuntijoiden ja potilasedustajien osaamista tarvitaan erityisesti hoitojen vertailemiseen sekä hoidon tarpeen ja mahdollisten hyötyjen arviointiin suomalaisille potilaille. Ennen yksikanavaisen järjestelmän käyttöönottoa varmistetaan, että sairaalatason nopeat arvioinnit (mini-HTA-arvioinnit) ovat hyödynnettävissä kaikissa hoitoyksiköissä päällekkäisen työn välttämiseksi.

Lääkkeen kansallisessa hoidollisessa ja taloudellisessa arvioinnissa hyödynnetään eurooppalaista ja pohjoismaista yhteistyötä.

Vastuutaho: STM (päävastuu, arviointitoiminnan kehittäminen), Hila, Palko, Fimea, lisäksi syövän hoidon ammattilaiset, potilasjärjestöt, arviointiylilääkäriverkosto.

Resurssi: Toteutetaan virkatyönä arviointitoimintaa kehittävässä ministeriössä ja muissa organisaatioissa.

83 Sosiaali- ja terveysministeriö. Lääkkeiden arviointiprosessien ja -kriteereiden lähentäminen. Työryhmän raportti. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2025:34.
84 Sosiaali- ja terveysministeriö. Selvitys terveydenhuollon menetelmien kansallisen arvioinnin organisoitumismalleista. Loppuraportti. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita|2026:11

Aikataulu:
2026–2028: EU-HTA-arvioinnin jälkeisen kansallisen arviointi- ja päätöksentekovaiheen kehittäminen siten, että lääkkeiden arviointi ja päätöksenteko kootaan yhdelle toimijalle. Eurooppalaisten ja pohjoismaisten yhteistyötahojen määrittely lääkkeen hoidollisessa ja taloudellisessa arvioinnissa.
2029–2031: Lääkkeiden arviointi ja päätöksenteko koottu yhdelle toimijalle kaikkien uusien syöpälääkkeiden ja merkittävien käyttöaiheen laajennusten osalta.

Mittari: Lainsäädännölliset muutokset, lääkkeiden arviointi ja päätöksenteko koottu yhdelle toimijalle.

Mittari: Kansallisesti HTA-arvioitujen/päätettyjen uusien syöpälääkkeiden määrä (tavoite: 100 %) ja käyttöaiheen laajennusten osuus myyntiluvan saaneista valmisteista.

Mittari: Kansallisen HTA-arvioinnin ja päätöksenteon vaatima aika arviointiprosessin käynnistymisestä sekä lääkkeen myyntiluvan myöntämisestä.

Toimenpide 4.5.3 Mahdollistetaan tosielämän vaikuttavuustiedon käyttö uusien lääkkeiden hallitussa käyttöönotossa, riskinjakomallien kehittämisessä ja vaikuttavuusarvioinnissa

Tosielämän vaikuttavuustiedon (RWE) systemaattinen hyödyntäminen on tärkeää uusien lääkkeiden käyttöönoton yhteydessä, erityisesti tilanteissa, joissa uuden lääkehoidon vaikutuksiin tai kustannuksiin liittyy merkittävää epävarmuutta. Hallitun käyttöönoton mallien avulla voidaan tukea potilaiden parempaa hoitoa ja mahdollistaa oikeudenmukaiset, joustavat ja dynaamiset rahoitusratkaisut. RWE on keskeinen osa modernia syöpälääkkeiden arviointi- ja rahoitusjärjestelmää, sillä uudet syöpälääkkeet tulevat markkinoille aiempaa nopeammin ja osittain epävarmemmalla näytöllä lääkkeen vaikuttavuudesta. Tämän vuoksi on tarkoituksenmukaista hyödyntää kliinisen käytön yhteydessä kertyvää tosielämän vaikuttavuustietoa.

Uusien syöpälääkkeiden yhteiskunnalle aiheuttamien kustannusten hallitsemiseksi tarvitaan taloudellisen riskin jakamisen malleja lääkeyritysten ja maksajan välille. Siihen liittyy kiinteästi hoitotulosten seuranta, toisin sanoen tiedon kerääminen siitä, toimiiko lääke suomalaisissa hoitokäytännöissä ja vastaavatko tulokset kliinisistä tutkimuksista saatuja tuloksia. Lisätietoa voi olla tarpeen kerätä myös käyttöönoton vaikutuksista palvelujen ja voimavarojen käyttöön. Näiden tietojen perusteella päästään tarkempaan kustannusvaikuttavuusanalyysiin ja voidaan tehdä perustellumpia ja seurattavampia päätöksiä lääkkeiden käytöstä. Pelkkä RWE:n tuottaminen ei kuitenkaan riitä, vaan lisäksi tarvitaan myös kykyä käyttää tietoa lääkevalikoiman hallinnoinnissa ja ohjauksessa sekä strategisissa hankinnoissa. Sopimukset voivat olla monimutkaisia ja hallinnollisesti raskaita, ja tämän vuoksi kansallisen toimintamallin ja mittareiden kehittäminen on tärkeää.

Tosielämän vaikuttavuustieto on oleellista myös potilaan kannalta: sen avulla voidaan tunnistaa lääkehoidosta eniten hyötyvät potilaat ja välttää tehottomia hoitojaksoja sekä turhia sivuvaikutuksia. Riskinjakosopimukset myös tukevat lääkkeen nopeampaa käyttöönottoa, kun käyttöön liittyvää epävarmuutta voidaan hallita dynaamisesti RWE:n avulla.

Osatavoitteessa 4.1 kuvattu kansallinen terveyden tietovaranto tulee valmistuessaan toimimaan pohjana tosielämän vaikuttavuusdatan keräämiseen ja lääkkeiden hallitun käyttöönoton seuraamiseen. Tietovarannosta voidaan ohjata tietoa tutkimuksiin tai tiedolla johtamisen työkaluihin. Ennen tietovarannon käyttöönottoa RWE-tieto tulee yksittäisten sairaaloiden tietoaltaista. Näihin tietoihin pohjaten luodaan RWE-mittarit, jotka voivat käsittää esim. kliinisiä lopputulemia (kokonaiselossaolo, progressiovapaa elossaolo, hoitovaste), potilaan raportoimia vointimittareita (PROMs), lääkehoidon kustannuksia, hoidon tukitoimenpiteiden tarvetta (esim. sairaalahoitojaksot ja niiden kustannukset) ja aiheutuneita epäsuoria kustannuksia (esim. töistä poissaolot sairauden vuoksi). Lopputulematiedot ovat parhaiten kerättävissä kansalliseen tietovarantoon, kun käytössä on harmonisoitu (OMOP-tietomalli) ja hajautettu (federoitu) tiedonkeruu ja analytiikka.

Keskeistä on huolehtia siitä, että lupaprosessi tarvittavaan RWE-tietoon on sujuva ja data-alustat toimivia. AI-pohjaisia menetelmiä ja automaattisia, reaaliaikaisia vaikuttavuusraportteja hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan.

Vastuutaho: Kansallisen terveyden tietovarannon ylläpitäjät, hyvinvointialueet ja HUS, lääkkeiden arviointiin osallistuvat tahot.

Resurssi: Toteutetaan virkatyönä ja osana perustettavan kansallisen terveyden tietovarannon toteutusta.

Aikataulu:
2026–2028: Riskinjakomallien pohjaksi on määritelty selkeät mittarit.
2029–2031: Ensimmäiset pilottihankkeet, joissa kerätään systemaattisesti RWE-dataa uuden syöpälääkkeen käyttöönotosta, ovat käynnistyneet.

Mittari: RWE-tietoon pohjautuvien riskinjakosopimusten määrä.

Toimenpide 4.5.4 Mahdollistetaan harvinaisten syöpien ja syöpätyyppien kohdalla lääketieteellisesti perustellut yksilölliset hoitoratkaisut

Uusien lääkkeiden laajan kansallisen käyttöönoton tulee perustua tutkimusnäyttöön ja hyväksyttyihin käyttöaiheisiin. Erityisesti harvinaisten syöpien sekä muiden harvinaisten sairauksien kohdalla voi kuitenkin syntyä tilanteita, joissa uuden lääkkeen käyttö voi olla kliinisesti perusteltua hyväksytyn käyttöaiheen ja yleisten korvattavuuskriteerien ulkopuolella (lääkkeen off label -käyttö). Uudessa päätöksentekojärjestelmässä yksilöllinen lääkkeen potilaskohtainen käyttöönotto tulee turvata

poikkeusmenettelyllä arviointikanavasta tai järjestelmästä riippumatta. Lääkkeiden arviointitoiminnan uudistamista valmisteleva työryhmä ehdottaa raportissaan[85], että avohoidon lääkkeen luovuttaminen potilaalle sairaala-apteekista olisi mahdollista, kun lääke on potilaalle välttämätön henkeä tai terveyttä vakavasti uhkaavan sairauden tai vamman takia eikä lääkkeelle ole mahdollista hakea korvattavuutta kyseiseen käyttöaiheeseen.

Yksilöllistenkin lääkkeen käyttöönottopäätösten tulee olla riippumattomia ja yhdenvertaisia. Tätä varten luodaan yleiset kriteerit tilanteille, joissa yksilölliset hoitoratkaisut ovat perusteltuja, ja luodaan mekanismi riippumattomalle, yhdenvertaiselle potilaskohtaisen korvattavuuden ja lääkkeen käyttöönoton myöntämiselle. Yhteisenä kansallisena kehikkona voitaisiin soveltaa hallituksen esityksen mukaisesti uudistuvan terveydenhuoltolain 7a§:n palveluvalikoiman määrittelyn periaatteita ja sen momenttia 4, jossa kuvataan perusteluita palveluvalikoimasta poikkeamiselle.

Vastuutaho: STM.

Resurssi: Toteutetaan virkatyönä osana lainsäädäntömuutosten valmistelua.

Aikataulu:
2026–2028: Kriteerit ja lainsäädännölliset edellytykset potilaskohtaisten päätösten tekemiseen on määritelty.
2029–2031: Lainsäädännölliset muutokset potilaskohtaisten lääkehoitopäätösten tekemiseksi on tehty.

Mittari: Potilaskohtaiset korvattavuuspäätökset harvinaisia syöpätyyppejä sairastaville.

Toimenpide 4.5.5 Vahvistetaan kansallista yhteistyötä merkittävissä laite- ja menetelmähankinnoissa

Laitteisiin liittyvät investoinnit suunnitellaan tällä hetkellä hyvinvointialueilla ja HUSissa omien investointiraamien puitteissa. Yksikkökohtaiset investointisuunnitelmat ulottuvat suurempien laitteiden kohdalla noin viiden vuoden päähän. Asetus erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä (keskittämisasetus) ohjaa laitehankintoja epäsuorasti keskittämällä vaativat tutkimukset, toimenpiteet ja hoidot tiettyihin terveydenhuollon yksiköihin. Erityisesti YTA-alueiden sisällä olisi kuitenkin tärkeää sopia uusien laitteiden hankinnoista ja niiden sijoittamisesta.

85 Sosiaali- ja terveysministeriö. Lääkkeiden arviointiprosessien ja -kriteereiden lähentäminen : Työryhmän raportti. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2025:34.

Toisaalta uusia laitteita vaativien menetelmien käyttöönotto saatetaan tehdä vähäisenkin näytön perusteella, eikä käytössä ole yhtenäisesti sovittuja kansallisia käytäntöjä siitä, millaisia uutta teknologiaa vaativia hoitomenetelmiä eri yksiköissä on käytössä. Lisäksi ajan, henkilöresurssien ja rahoituksen puute rajoittaa uusien menetelmien vaikuttavuuden arviointia ja estää kansallisen tason arvioinnin esimerkiksi laitehankintojen osalta.

Terveydenhuollon menetelmien arviointia ja sen organisoitumisen uudistusta on selvitetty STM:n keväällä 2026 julkaisemassa loppuraportissa (HTA-raportti)[86], jossa huomioidaan myös laitteiden arvioinnit. Jatkossa myös syövän hoidossa käytettävien laitteiden arviointia tulee kehittää raportin ehdotusten ja jatkolinjauksien mukaisesti. Julkisen terveydenhuollon uusien lääkkeiden, yhdistelmähoitojen sekä keskeisten diagnostiikka- ja hoitoteknologioiden yhdenvertainen, vaikuttava ja kustannusvaikuttava käyttöönotto edellyttää siirtymistä hajautetusta arviointi- ja päätöksentekomallista kohti yhtenäistä kansallista rakennetta, jossa samalla voidaan toimeenpanna ja soveltaa terveydenhuollon palveluvalikoiman periaatteet.

Tavoitteena on myös lisätä valtakunnallisia yhteishankintoja ja kilpailutuksia siten, että merkittävät ja kustannuksiltaan suuret investoinnit (lääkinnälliset laitteet, laitteiden ja lääkkeiden yhdistelmät sekä muut vaikuttavat hoitomenetelmät mukaan lukien) perustuvat yhteiseen näkemykseen hoidon järjestämisestä.

Tavoitteena on turvata yhdenvertainen pääsy vaikuttaviin hoitoihin eri puolilla maata ja hyödyntää pohjoismaista ja eurooppalaista yhteistyötä, vertaisarviointia sekä digi-HTA-menetelmiä. Syövän hoito ei kuitenkaan voi muodostua muusta terveydenhuollosta erilliseksi ratkaisuksi, joten taloudellinen vastuu pysyy hyvinvointialueilla ja HUSissa. Yhteishankintoja hyödynnetään aina, kun se on hankintalain puitteissa mahdollista ja kilpailutusedut ovat saavutettavissa. Kansallinen hankintatukipalvelu voisi valmistella myös hoitoteknologioista suorahankintasopimukset hyvinvointialueiden lukuun. Hankintatukipalvelun rooliin sopisi myös uusien innovaatioiden ennakointi (horizon scanning).

Tavoitteen saavuttamiseksi luodaan kansallinen toimintamalli ja vastuutaho, jonka toimesta keskustellaan ja päätetään koko terveydenhuollon kansallisesta laitteiden ja menetelmien tarpeesta, hankinnasta ja sijoittamisesta eri hyvinvointialueille ja HUSiin keskittämisasetuksen pohjalta. Taho voi toimia verkostomaisesti ja toimintamallin kehittämiseen voisivat osallistua VM, STM, hyvinvointialueet ja HUS sekä uusien menetelmien osalta menetelmäarviointia tekevät Palko, arviointiylilääkärien verkosto, FinCCHTA sekä FINOSE. Arviointi voitaisiin jatkossa kytkeä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain mukaiseen investointisuunnitteluun sekä hyvinvointialueiden väliseen työnjakoon siten, että laiteinvestoinnit tukevat vaikuttavaa hoidon keskittämistä ja kustannusvaikuttavaa palvelujärjestelmää. Kansallisen arviointitoiminnan vahvistaminen ja kokoaminen edellyttävät toimeenpanovaiheessa lainsäädäntöhankkeen.

86 Selvitys terveydenhuollon menetelmien kansallisen arvioinnin organisoitumismalleista: Loppuraportti https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/items/7d282a45-4b15-40bc-82d2-0dea33a14c1e

Päätöksenteon tueksi laaditaan kustannusvaikuttavuusarviot eri hoitoteknologioista ja määritellään kriteerit, joiden perusteella uudet menetelmät ohjataan valtakunnalliseen arviointiin. Arviointimalli soveltuu esimerkiksi sädehoitolaitteisiin ja robottikirurgiaan, mutta myös muihin merkittäviin investointeihin. STM:n johdolla ollaankin parhaillaan (6.11.2025 – 31.12.2026) selvittämässä robottiavusteisen kirurgian tilannetta Suomessa sekä tekemässä ehdotusta kansalliseksi robottikirurgian ohjelmaksi[87].

Laitteiden ja menetelmien kokonaiskuvan tarkemmaksi hahmottamiseksi selvitetään mahdollisuutta perustaa kansallinen rekisteri hyvinvointialueilla ja HUSissa jo käytössä olevista erikoismenetelmistä ja laitteista hyödyntäen olemassa olevia STUKin, THL:n ja Fimean sekä hyvinvointialueiden rekistereitä. Rekisteriä päivitettäisiin säännöllisesti ja sen avulla seurattaisiin uusien investointien vaikuttavuutta käyttöönoton jälkeen. Syövän diagnostiikkaan ja hoitoon käytettävät laitteet ovat osa tätä rekisteriä.

Vastuutaho: VM, STM, hyvinvointialueet ja HUS.

Resurssi: Arvioitu tarvittava määräraha 250 000 €. Resurssia kohdennetaan selvityksen toteuttamiseen ja laiterekisterin suunnittelutyöhön.

Aikataulu:
2026–2028: Laitteiden ja menetelmien arviointitoiminta on keskitetty yhdelle toimijalle. Laadittu suunnitelma kansallisen hankintatukipalvelun toiminnasta. Tehty selvitys kansallisen rekisterin perustamisesta olemassa olevien, eri organisaatioiden ylläpitämien tietojen pohjalta.
2029–2031: Kansallinen rekisteri vaativista ja kustannuksiltaan merkittävistä laitteista ja menetelmistä on perustettu, ja sen perusteella pystytään tekemään kansallista ja kansainvälistä vertailua sopiviin referenssimaihin. Kaikki kustannuksiltaan määritellyn kynnysarvon ylittävät laite- ja menetelmähankinnat arvioidaan kansallisesti.

Mittari: Kansallisesti tehtyjen menetelmäarviointien määrä.

Mittari: Kansallisten yhteishankintojen osuus.

87 Kansallinen robottiavusteisen kirurgian selvitys ja ehdotus robottikirurgian ohjelmaksi. https://stm.fi/hanke?tunnus=STM194:00/2025

Toimeenpano ja seuranta

Syöpästrategian mukaisesti tavoitteiden toteutuminen edellyttää riittävää resursointia, selkeää kansallisen tason ohjausta ja eri toimijoiden vahvaa sitoutumista. Strategian tavoitteiden toteutusta on tarkennettu tämän tiekartan aiemmissa luvuissa toimenpiteiden vastuutahojen, aikataulujen, tarvittavien resurssien, ennakoitujen säästöjen ja tarvittavien säädösmuutosten osalta, ja kustannusten ja säästöjen osalta seuraavassa luvussa.

Toimeenpanoa ja seurantaa varten asetetaan kansallisen syöpästrategian seurantaryhmä, jossa ovat edustettuina tiekarttatyön ohjausryhmän taustaorganisaatiot (FICAN, Syöpäjärjestöt, THL, STM), hyvinvointialueet ja HUS, strategian toteutukselle tärkeät muut ministeriöt, viranomaiset, korkeakoulut ja järjestöt. Seurantaryhmän keskeisinä tehtävinä on suunnitella, seurata ja linjata kansallisen syöpästrategian toimeenpanoa ja sen vaiheistusta strategian, tiekartan ja toimintaympäristön (mukaan lukien EU:n syöpämissio ja syöväntorjuntasuunnitelma) ohjaamana sekä esittää säädösmuutoksia ja rahoitusmahdollisuuksia toimeenpanon edistämiseksi. Seurantaryhmän toimintaa ja strategian toimeenpanoa koordinoi FICAN käytettävissä olevien resurssien puitteissa.

Syöpämissio Suomen toiminta integroidaan toimeenpanoon soveltuvin osin. Strategian toimeenpanovaiheessa varmistetaan systemaattinen yhteensovittaminen käynnissä olevien kansallisten kehittämishankkeiden, lainsäädäntöuudistusten sekä selvitysten kanssa.

Kustannukset ja ennakoidut säästöt

Strategian toimeenpano ensimmäisellä viisivuotiskaudella 2026–2031 edellyttää tiekartan muodostamisen yhteydessä tarkennetun arvion mukaan kokonaisuudessaan noin 140 M€:n investointia. Toimenpidekohtaiset arviot kustannuksista on esitetty liitteessä 1. Strategian toteutus edistää vaikuttavaa syövän ennaltaehkäisyä, varhaista toteamista ja hoitoa. Syöpästrategian toimeenpano on kokonaisuutena säästö- ja kasvutoimi. Kustannussäästöjä ennakoidaan strategiakaudella tulevan yhteensä 298 M€, ja ne jakautuvat päätavoitteittain seuraavasti:

Vahvistetaan osallisuutta ja kehitetään ihmislähtöisiä palveluita

Osallisuuden vahvistamisen ja ihmislähtöisten palveluiden kehittämisen osalta kustannussäästöjä ennakoidaan syntyvän yhteensä 2 M€. Nämä koostuvat osatavoitteen 1.3 toimenpiteistä, jotka keskittyvät terveyslukutaidon kehittämiseen, rokotuksiin ja seulontoihin osallistumisen sekä varhaisen hoitoon hakeutumisen edistämiseen.

Vähennetään syöpätaakkaa ehkäisyn ja varhaisen toteamisen avulla

Syövän ehkäisyn osalta ennakoidut säästöt, yhteensä 157 M€, on arvioitu syntyvän osatavoitteesta 2.1, jonka toimenpiteet vähentävät tupakointia ja alkoholinkäyttöä ennaltaehkäisten merkittävän määrän syöpätapauksia. Säästöt on laskettu skenaariolla, jossa tupakointi ja alkoholinkäyttö vähenevät toimenpiteiden seurauksena kymmenen vuoden ajan 10 % vuodessa ja jossa ylipainoisten osuuden kasvu taittuu.

Varmistetaan yhdenvertainen ja vaikuttava syövänhoito

Yhdenvertaisen ja vaikuttavan syövänhoidon kehittämisen ennakoidaan tuovan säästöjä, mutta niiden arvioiminen hoitopolkujen ja palvelujärjestelmien monitahoisuuden sekä toimintamallien kehittymisen vuoksi edellyttää strategiassa esitettyä tietopohjan kehittämistä ja integraatiota. Näitä arvioita toteutetaan toimeenpanon edetessä. Tämän päätavoitteen strategiassa ennakoitujen säästöjen (19 M€) on arvioitu syntyvän palliatiivisen hoidon kehittämisessä syntyvistä, aiemmissa raporteissa ja tutkimuksissa esitetyistä laskelmista[88].

88 H. Finne-Soveri, ym. Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon säädösmuutosten kustannusvaikutusten arviointi : Laskentatyöryhmän raportti. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2021:21.

Aallonharjalla muuttuvassa toimintaympäristössä

Aallonharjalla muuttuvassa toimintaympäristössä -päätavoitteen säästöt tulevat lisääntyneistä kliinisistä tutkimuksista (120 M€, 10 kliinistä tutkimusta lisää vuosittain), joiden välitön arvo terveydenhuollolle on laskettu vuonna 2024 julkaistun raportin mukaisesti[89].

Lisäksi strategian toteutuksen ennakoidaan lisäävän kansainvälisiä investointeja CANFIN-hankkeen toteutuessa (toimenpide 4.3.1) yhteensä 220 M€. CANFIN-hankkeen ennakoidut investoinnit on arvioitu iCAN lippulaivan vuosina 2019-2025 toteutuneiden investointien pohjalta (keskimäärin 11 M€/vuodessa) ja valtiollisen TKI-rahoituksen mahdollistama kansallisen laajentumisen tuoma lisäarvo (investointien kaksinkertaistus toteutuneeseen) huomioiden. On selvää, että sekä tietopohjan integraation kehittäminen että yksilöidympi syöpäprofilointi edistävät Suomen kiinnostavuutta globaalisti.

Kokonaisuudessaan strategian toteuttamisesta syntyvät ennakoidut säästöt ja investoinnit ovat jo tällä strategiakaudella merkittävästi kustannuksia mittavammat. Toimeenpanon edetessä ja tietopohjan parantuessa strategian vaikuttavuutta, taloudelliset vaikutukset mukaan lukien, tullaan arvioimaan säännöllisesti.

89 Esior Oy, 2024. Miten yhteiskunta hyötyy Suomessa tehtävistä lääketutkimuksista? Miten yhteiskunta hyötyy Suomessa tehtävistä lääketutkimuksista? Lääketutkimuksen yhteiskunnallinen arvo – loppuraportti 11.6.2024.

Liite 1. Syöpästrategian toimeenpanon arvioidut kustannukset 2026-2031 päätavoite-, osatavoite- ja toimenpidekohtaisesti

Syöpästrategian toimeenpanon kustannukset 2026–2031			Arvioitu rahoitustarve (€)
1	**Vahvistetaan osallisuutta ja kehitetään ihmislähtöisiä palveluja**		**5 800 000**
1.1	Asiakkaat, potilaat ja läheiset osallistuvat syövän ehkäisyn, hoidon ja palveluiden kehittämiseen		4 500 000
	1.1.1	Vahvistetaan asukkaiden, asiakkaiden ja potilaiden osallisuutta ja osallistumismahdollisuuksia väestölle suunnattujen seulontojen, rokotusohjelmien ja muiden ennaltaehkäisevien palveluiden kehittämisessä	1 500 000
	1.1.2	Vahvistetaan potilasedustajien osallistumista syöpäkohtaisten hoito- ja muiden suositusten sekä hoitopolkujen laatimiseen	1 500 000
	1.1.3	Syöpää hoitavat yksiköt kuvaavat osallisuuden organisaatiorakenteissa, toimintasuunnitelmissa sekä hoito- ja palveluprosesseissa	1 500 000
	1.1.4	Hyvinvointialueet, HUS ja järjestöt tekevät aiempaa tiiviimpää yhteistyötä osallisuustoiminnan kehittämiseksi	
1.2	Arvostava, inhimillinen ja yksilöllinen kohtaaminen tukee potilasta osallistumaan aktiivisesti omaan hoitoonsa		100 000
	1.2.1	Hoitosuosituksiin lisätään osio, joka tukee jaettua päätöksentekoa	
	1.2.2	Otetaan käyttöön olemassa olevat mittarit, jotka mittaavat potilaan kokemuksesta omaan hoitoonsa osallistumisesta	
	1.2.3	Luodaan toimintamalli ja ohjeistus syövän hoidon koordinaatiosta vastaavan, nimetyn työntekijän mallista	100 000
1.3	Selkeä ja saavutettava terveysviestintä sekä terveyslukutaidon tukeminen edistävät syövän ehkäisyä, varhaista toteamista ja hoidon vaikuttavuutta		1 200 000
	1.3.1	Parannetaan eri kieliryhmiin kuuluvien väestöryhmien osallistumista rokotuksiin sekä syöpäseulontoihin kohdennetun ja yhteisölähtöisen viestinnän avulla	400 000
	1.3.2	Edistetään varhaista hoitoon hakeutumista kansallisella viestintäsuunnitelmalla, joka keskittyy lisäämään tietoisuutta syöpien oireista	400 000

Syöpästrategian toimeenpanon kustannukset 2026–2031		Arvioitu rahoitustarve (€)
1.3.3	Vahvistetaan palliatiivisen hoidon tunnettuutta ja myönteistä asenneilmapiiriä selkeällä ja yhdenmukaisella viestinnällä	400 000
2	**Vähennetään syöpätaakkaa ehkäisyn ja varhaisen toteamisen avulla**	**19 330 000**
2.1	Syövän riskitekijöitä vähennetään ja suojaavia tekijöitä vahvistetaan yhteiskuntapoliittisin keinoin	3 480 000
2.1.1	Sisällytetään kattava syövän ehkäisyä tukeva terveys- ja terveyserovaikutusten arviointi säädös- ja budjettiesityksiin	
2.1.2	Laajennetaan terveysperusteista verotusta	
2.1.3	Suunnitellaan ja toteutetaan kansallinen ravitsemuksen ja liikunnan toimintaohjelma yhteistyössä keskeisten toimijoiden kanssa	1 000 000
2.1.4	Asetetaan hallituskausittain tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittämistyöryhmä vahvistamaan tupakka- ja nikotiinituotteiden sääntelyä	
2.1.5	Varmistetaan sosiaali- ja terveyspoliittisten näkökulmien huomiointi alkoholipolitiikassa ja säädetään alkoholituotteiden tuotemerkinnöistä	1 100 000
2.1.6	Parannetaan UV-säteilyltä ja radonilta suojautumista	380 000
2.1.7	Otetaan työperäisen syövän torjunta osaksi valtakunnallista työsuojelustrategiaa	
2.1.8	Varmistetaan keskeisten toimijoiden mahdollisuus kehittää ja jalkauttaa lasten ja nuorten elinympäristöjen terveyttä edistäviä toimintamalleja	1 000 000
2.2	Syöpää ehkäistään hyvinvointialueilla ja lähipalveluissa	1 950 000
2.2.1	Selvitetään ennaltaehkäisyn painoarvon kasvattamista edelleen hyvinvointialueiden rahoituksessa	
2.2.2	Varmistetaan kansallisten syöpää ehkäisevien toimintamallien käyttö muun muassa päihteiden, ravitsemuksen ja liikunnan osalta	1 800 000
2.2.3	Nostetaan HPV-rokotuskattavuutta alakouluissa koordinoidulla yhteistyöllä ja viestinnällä sekä varmistetaan rokotusten aktiivinen tarjoaminen ja täydentäminen myös yläkoulussa ja toisella asteella	150 000
2.3	Eurooppalaiset suositukset ja kansalliset rakenteet ovat perustana vaikuttavien syöpäseulontaohjelmien suunnittelulle ja toteutukselle	9 250 000
2.3.1	Selvennetään syöpäseulontojen kansallisen ohjausryhmän, seulontaohjelmakohtaisten asiantuntijaryhmien ja Palkon seulontajaoston välinen työnjako ja vastuut	250 000
2.3.2	Päivitetään kriteerit syöpäseulontaohjelmien päätöksentekoon	
2.3.3	Laajennetaan rintasyövän seulonta 46–74-vuotiaisiin	9 000 000

Syöpästrategian toimeenpanon kustannukset 2026–2031			Arvioitu rahoitustarve (€)
	2.3.4	Perustetaan uusia valtakunnallisia seulontaohjelmia ja muokataan nykyisiä ohjelmia tutkittuun tietoon ja EU-suosituksiin pohjautuen	
2.4		Lainsäädäntö ja rekisteritieto mahdollistavat laadukkaan, kustannusvaikuttavan ja riskiperusteisen seulonnan	3 650 000
	2.4.1	Otetaan seulontaohjelmien laatukäsikirjat käyttöön kattavasti palvelujen hankinnassa ja ohjauksessa	350 000
	2.4.2	Uudistetaan lainsäädäntöä mahdollistamaan kustannusvaikuttava ja riskiperusteinen seulonta	
	2.4.3	Kohdennetaan seulontaa kohdeväestön tilastollisesti arvioidun riskin perusteella, jolloin osa seulottavista voidaan kutsua seulontaan harvemmin tai useammin	500 000
	2.4.4	Turvataan rahoitus seulontaohjelman puitteissa tehtäviin pilottitutkimuksiin	2 500 000
	2.4.5	Määritetään toimintamallit, joiden avulla seulontarekistereissä olevaa tietoa hyödynnetään seulontaohjelman kehittämisessä yhdessä hyvinvointialueiden kanssa	300 000
2.5		Syövät havaitaan aiempaa varhaisemmassa vaiheessa kaikkialla terveydenhuollossa	1 000 000
	2.5.1	Parannetaan hoitoonpääsyä lisäämällä lääkäriresurssia perusterveydenhuoltoon esimerkiksi laajentamalla omalääkärimalli valtakunnalliseksi	
	2.5.2	Tuetaan sujuvaa siirtymää erikoissairaanhoitoon määrittämällä standardoidut lähetekriteerit osana kansallisia hoitoketjuja, joiden täyttyessä mahdollisista syöpäoireista kärsivät potilaat ohjataan nopeasti tarvittaviin diagnostisiin tutkimuksiin	Sisältyy toimenpiteen 3.1.1. arvioituun rahoitustarpeeseen
	2.5.3	Luodaan toimintamallit syöpäriskiryhmien tunnistamiseksi ja varhaisdiagnostiikan parantamiseksi geenitiedon avulla	1 000 000
3		**Varmistetaan yhdenvertainen ja vaikuttava syövänhoito**	**49 730 000**
3.1		Kansalliset hoitosuositukset ja hoitoketjut ohjaavat yhdenvertaista, viiveetöntä ja vaikuttavaa hoitoa	25 000 000
	3.1.1	Luodaan kansallinen mekanismi sekä pysyvä rahoitus syöpäkohtaisten hoitosuositusten ylläpitoon	25 000 000
	3.1.2	Laaditaan syöpäkohtaiset hoitoketjukuvaukset, ja niiden pohjalta sovelletut alueelliset hoitoketjut, sekä mekanismi niiden ylläpitoon ja hallintaan	Sisältyy toimenpiteen 3.1.1. arvioituun rahoitustarpeeseen
	3.1.3	Luodaan kansallisesti yhtenäiset linjaukset kustannusten ja muiden yhteiskunnallisten vaikutusten huomioimisesta hoitovalinnoissa	Sisältyy toimenpiteen 3.1.1. arvioituun rahoitustarpeeseen

Syöpästrategian toimeenpanon kustannukset 2026–2031		Arvioitu rahoitustarve (€)
3.1.4	Määritellään kansalliset laatu- ja vaikuttavuustavoitteet ja seurantamittarit hoitoketjujen seurannan mahdollistamiseksi	Sisältyy toimenpiteen 3.1.1. arvioituun rahoitustarpeeseen
3.2	Kansallisen syövänhoidon laaturekisteri, systemaattinen tulosten tarkastelu ja vertaisarviointi tukevat vaikuttavan hoidon kehittämistä	5 800 000
3.2.1	Luodaan lainsäädännöllinen pohja THL:n Syöpärekisterin yhteyteen perustettavalle syövän hoidon laaturekisterille	2 500 000
3.2.2	Määritetään ja käynnistetään vertaiskehittämisen prosessit, joilla laaturekisterien tuottamaa tietoa vertaillaan ja tarkastellaan systemaattisesti	300 000
3.2.3	Määritetään ja käynnistetään ohjaus- ja johtamismekanismit, joilla vertaisarvioinnin tuloksiin ja mahdollisiin puutteisiin reagoidaan	3 000 000
3.2.4	Selkeytetään syövän hoidon laaturekisteritoimintaan osallistuvien toimijoiden roolit ja vastuut, laaditaan sopimuksellinen pohja sekä varmistetaan pysyvä rahoitus laaturekisteritoiminnalle	
3.3	Kuntoutus, psykososiaalinen tuki, terveyssosiaalityö ja palliatiivinen hoito ovat vakiintunut osa syöpäpotilaan hoitoketjua ja yhdenvertaisesti saatavilla	2 040 000
3.3.1	Laaditaan kansallisesti yhdenmukaiset käytännöt ja mittarit syöpäpotilaiden oireiden, elämänlaadun, toimintakyvyn ja yksilöllisten tuen tarpeiden arvioimiseksi	500 000
3.3.2	Määritetään kansallinen syöpäpotilaiden tukipalveluiden palveluvalikoima (ml. kolmannen sektorin palvelut) ja suositukset tukipalveluiden henkilöstömitoituksesta sekä varmistetaan suositusten mukaiset ja saumattomat tukipalveluiden palveluketjut	350 000
3.3.3	Laaditaan ja otetaan käyttöön kansalliset ohjeistukset ja vaikuttavat toimintamallit syöpään sairastuneiden työ- ja toimintakyvyn sekä oikea-aikaisen palliatiivisen hoidon varmistamiseksi kaikissa ikäryhmissä	1 140 000
3.3.4	Selvitetään sosiaaliturvauudistuksen yhteydessä syöpään sairastuneiden erityiset toimeentulon haasteet ja tarvittavat toimenpiteet sekä syöpäpotilaiden lainojen ja vakuutusten saantiin liittyvät säädösmuutostarpeet Suomessa (Oikeus tulla unohdetuksi -lainsäädäntö)	50 000
3.4	Toimintakykytieto ohjaa ikääntyneiden syöpäpotilaiden hoitoa	2 750 000
3.4.1	Otetaan systemaattinen toimintakyvyn arviointi käyttöön kaikissa iäkkäitä syöpäpotilaita hoitavissa yksiköissä	750 000
3.4.2	Toimintakykytietoa kerätään jo perusterveydenhuollossa ja se kirjataan lähetteeseen	1 000 000

Syöpästrategian toimeenpanon kustannukset 2026–2031		Arvioitu rahoitustarve (€)
3.4.3	Lisätään geriatris-onkologisten potilaiden toimintakyvyn arviointia hoitoketjun eri vaiheissa	1 000 000
3.5	Riittävä ja osaava henkilöstö varmistaa vaikuttavan ja ihmislähtöisen syövän hoidon	14 140 000
3.5.1	Luodaan kestävät strategiat syövän hoitoon osallistuvan henkilöstön riittävyyden varmistamiseksi	8 500 000
3.5.2	Kehitetään ja lisätään syövän hoitoon osallistuvien ammattilaisten jatkuvaa koulutusta ja erikoistumismahdollisuuksia sekä määritellään kansalliset yhtenäiset ammatti- ja tehtävänimikkeet	
3.5.3	Edistetään digitaalisten työkalujen, tekoälyn ja innovaatioiden käyttöönottoa ja kehittämistä syövän hoidossa	1 140 000
3.5.4	Vahvistetaan psykososiaalisen tuen, kuntoutuksen, geriatrisen onkologian ja palliatiivisen hoidon osaamista kaikissa syövän hoidon vaiheissa	1 500 000
3.5.5	Käynnistetään palliatiivisen lääketieteen erikoislääkärikoulutus	3 000 000
4	**Aallonharjalla muuttuvassa toimintaympäristössä**	**58 150 000**
4.1	Kansallinen terveyden tietovaranto ja kehittynyt analytiikka tukevat syövän tutkimusta ja tiedon hyödyntämistä	5 500 000
4.1.1	Kehitetään palvelujärjestelmän toimintaa mahdollistamaan syöpätiedon ja muun terveystiedon yhdenmukainen rakenteellinen kirjaaminen ja harmonisointi	1 750 000
4.1.2	Mahdollistetaan lainsäädännöllisesti ja resurssoinnin osalta syövän tietovarannon pitkäjänteinen toiminta osana kansallista terveystietovarantoa tai -aluetta	1 750 000
4.1.3	Tuotetaan luotettavaa näyttöä kansallisen syövän tietovarannon avulla TKI-toiminnan, hoitojen vaikuttavuuden ja välittömän tietojohtamisen vahvistamiseksi	2 000 000
4.1.4	Kansallista syövän tietovarantoa muodostettaessa varmistetaan, että tieto on tarvittaessa hyödynnettävissä myös Syöpärekisterin ja syövän laaturekisterin edellyttämän tietosisällön tuottamiseen	
4.2	Vahvistuva kliininen syöpätutkimus on tiivis osa jokaisen potilaan hoitoa	9 500 000
4.2.1	Vahvistetaan kansallisen kliinisen syöpätutkimuksen koordinaatiota ja yhteistyötä	4 000 000
4.2.2	Vahvistetaan ja tuetaan tutkimusyksiköiden toimintaa	5 500 000
4.2.3	Erikoistumiskoulutukseen ja erikoislääkäreiden työnkuvaan sisällytetään kliiniseen tutkimukseen tutustuminen, koulutus ja osallistuminen (vähintään 10 % työajasta)	
4.3	Suomi on yksilöllisen lääketieteen edelläkävijä	42 900 000

Syöpästrategian toimeenpanon kustannukset 2026–2031		**Arvioitu rahoitustarve (€)**
4.3.1	Perustetaan yksilöllisen syöpälääketieteen kansallinen tutkimus- ja TKI-keskus Cancer Research Hub Finland (CANFIN)	40 000 000
4.3.2	Luodaan kansalliset suositukset molekyylidiagnostisten tutkimusten laajuudesta ja tutkimusmenetelmistä	Sisältyy toimenpiteen 3.1.1. arvioituun rahoitustarpeeseen
4.3.3	Keskitetään uudet, vaativat tutkimukset riittävästi resursoituihin (henkilöstö, laitteet, sähköinen lähete-vastausliikenne) laboratorioihin	400 000
4.3.4	Kehitetään ja resursoidaan molekulaaristen tuumoriryhmien (MTB) toimintaa kansallisessa yhteistyössä	500 000
4.3.5	Kehitetään biopankkitoimintaa tukemaan yksilöllisen lääketieteen tarpeita	2 000 000
4.4	Vähennetään syöpätaakkaa monitieteisen tutkimuksen avulla	
4.4.1	Kerätään ja ylläpidetään tietoa syöpätutkimuksen rahoituksesta ja tehdään esityksiä sen kohdentamistarpeista	
4.4.2	Vahvistetaan laaja-alaisen, monitieteisen syöpätutkimuksen tunnettuutta ja sen merkitystä ennaltaehkäisyssä, hoidon kehittämisessä ja sairastuneiden elämänlaadun parantamisessa	
4.4.3	Edistetään eri syöpään liittyvien osa-alueiden, ammatti- ja potilasryhmien ja tutkijoiden yhteistyötä monitieteisten tutkimusten toteuttamisessa osana Syöpämissio Suomen toimintaa	
4.5	Uusien syöpälääkkeiden ja muiden hoitomenetelmien arviointi ja käyttöönotto on vaikuttavaa, viiveetöntä ja yhtenevää arviointitahosta riippumatta	250 000
4.5.1	Varmistetaan syöpälääkkeiden käyttöönottoon liittyvien ongelmien korjaaminen osana STM:n koordinoimaa lääkeasioiden uudistusta	
4.5.2	Luodaan yksi yhteinen kansallinen lääkkeiden arviointijärjestelmä päätöksenteon pohjaksi ja riittävän arviointiresurssin varmistamiseksi	
4.5.3	Mahdollistetaan tosielämän vaikuttavuustiedon käyttö uusien lääkkeiden hallitussa käyttöönotossa, riskinjakomallien kehittämisessä ja vaikuttavuusarvioinnissa	
4.5.4	Mahdollistetaan harvinaisten syöpien ja syöpätyyppien kohdalla lääketieteellisesti perustellut yksilölliset hoitoratkaisut	
4.5.5	Vahvistetaan kansallista yhteistyötä merkittävissä laite- ja menetelmähankinnoissa	250 000
5	**Toteutus ja seuranta vuosina 2026–31**	**6 000 000**
Yhteensä		**139 100 000**

Liite 2. Ohjausryhmän ja sihteeristön kokoonpano

Ohjausryhmä

Puheenjohtaja:
Markku Mäkijärvi, johtajaylilääkäri, HUS (1.1.2026-10.6.2026), Hanne Kuitunen, osaamiskeskusjohtaja, OYS Syöpäkeskus, (10.6.2026 alkaen)

Varapuheenjohtaja:
Hanne Kuitunen, osaamiskeskusjohtaja, OYS Syöpäkeskus (1.1.2026-10.6.2026), Sirkku Jyrkkiö, syöpätautien erikoislääkäri, dosentti (10.6.2026 alkaen)

Tuula Helander, johtaja, sosiaali- ja terveysministeriö
varajäsenenä Julia Kinnunen, lakimies, sosiaali- ja terveysministeriö (1.1.2026-30.6.2026), Kari Raaska, lääkintöneuvos, sosiaali- ja terveysministeriö (30.6.2026 alkaen)

Johanna Arola, dekaani, Helsingin yliopisto
varajäsenenä Tapio Visakorpi, vararehtori, Tampereen yliopisto

Jan Magnusson, yksikönpäällikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
varajäsenenä Satu Männistö, tutkimuspäällikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Juha Pekka Turunen, pääsihteeri, Syöpäjärjestöt
varajäsenenä Janne Pitkäniemi, Syöpärekisterin johtaja, Syöpäjärjestöt

Sihteeristö:

FICAN: Tomi Mäkelä (pääsihteeri), Mirjami Tran Minh (projektipäällikkö),
Outi Nikunen, Timo Nykopp, Sauli Vuoti

Syöpäjärjestöt: Sarianne Hartonen, Sanna Lappi-Heikkinen, Veli-Matti Partanen

Suomen Syöpäinstituutin säätiö: Tiina Vesterinen

Kansallisen syöpästrategiatyön käynnistämisen ohjausryhmä 2026

Kansallinen syöpästrategia 2026–2035:
Toimeenpanon tiekartta vuosille 2026–2031

Taitto: Grano Oy